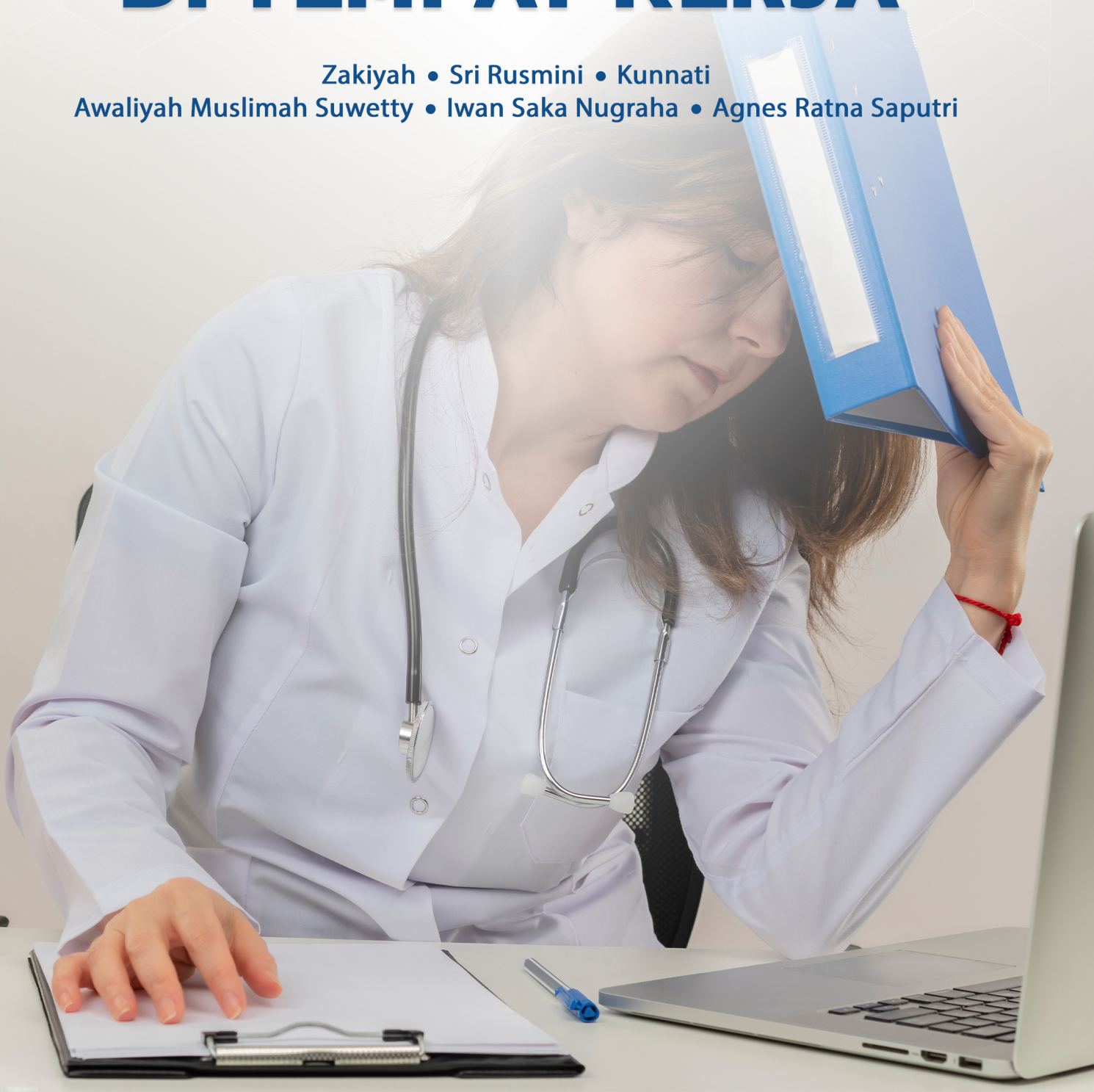


Buku Referensi

PENGELOLAAN STRES PADA TENAGA MEDIS DI TEMPAT KERJA

Zakiyah • Sri Rusmini • Kunnati
Awaliyah Muslimah Suwetty • Iwan Saka Nugraha • Agnes Ratna Saputri



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN STRES PADA

TENAGA MEDIS DI TEMPAT KERJA

Ns. Zakiyah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J
Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua
Kunnati, S.ST., M.KM
Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep
apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes
Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN STRES PADA TENAGA MEDIS DI TEMPAT KERJA

Penulis: Ns. Zakiyah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J

Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM., FISQua

Kunnati, S.ST., M.KM

Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep

apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes

Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-7294-22-7

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Prakata

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **“Pengelolaan Stres pada Tenaga Medis di Tempat Kerja”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi tenaga medis di era pelayanan kesehatan modern, yang ditandai dengan tingginya beban kerja, tekanan emosional, serta ekspektasi terhadap pelayanan yang cepat dan tepat.

Stres kerja merupakan masalah serius yang berdampak luas, tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental tenaga medis, tetapi juga pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengelolaan stres perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif, melibatkan seluruh elemen dalam lingkungan kerja tenaga kesehatan.

Buku ini terdiri dari enam bab yang saling melengkapi dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah serta temuan terbaru di bidang kesehatan kerja dan psikologi tenaga medis. Bab pertama mengulas secara menyeluruh faktor penyebab stres di lingkungan kerja tenaga medis, termasuk beban kerja, konflik peran, kurangnya dukungan sosial, serta tekanan administratif yang sering tidak terlihat. Bab kedua menekankan pentingnya edukasi tentang manajemen stres, yang menjadi fondasi dalam membentuk kesadaran diri dan keterampilan koping yang adaptif.

Bab ketiga menawarkan pendekatan strategi berbasis komunitas dalam mendukung kesehatan mental, dengan menyoroti peran institusi, kelompok kerja, dan komunitas profesional dalam menciptakan ruang aman untuk berbagi dan tumbuh bersama. Bab keempat memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan konseling jarak jauh, sebagai bentuk inovasi dalam menjangkau kebutuhan psikososial tenaga medis yang tersebar luas dan memiliki keterbatasan waktu.

Bab kelima mengangkat peran penting dukungan kolega dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, hangat, dan inklusif. Kesehatan mental tenaga medis akan lebih terjaga jika rekan kerja saling mendukung dan membangun solidaritas tim yang kuat. Sementara itu, bab keenam menyoroti peran manajemen dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis, melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja

dan hidup, penyediaan fasilitas psikososial, serta pengakuan atas kerja keras dan dedikasi para tenaga kesehatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan rujukan penting bagi dosen, mahasiswa, manajer institusi pelayanan kesehatan, serta praktisi di bidang keperawatan dan kedokteran kerja. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran dari para pembaca akan sangat berarti untuk penyempurnaan edisi selanjutnya.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v
BAB I FAKTOR PENYEBAB STRES DI LINGKUNGAN KERJA TENAGA MEDIS.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Beban Kerja yang Berlebihan	2
C. Faktor Lingkungan Kerja	3
D. Dinamika Hubungan Interpersonal di Tempat Kerja.....	5
E. Tekanan Psikososial	6
F. Kurangnya Dukungan Organisasi	7
G. Ketidakpastian Karir dan Pengembangan Profesional	9
H. Dampak Pandemi dan Krisis Kesehatan	10
I. Pengukuran dan Identifikasi Faktor Stres di Tempat Kerja	12
J. Ringkasan dan Implikasi Manajerial	13
K. Penutup	15
Referensi	16
BAB II EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MANAJEMEN STRES BAGI TENAGA MEDIS	18
A. Pendahuluan.....	18
B. Pemahaman Tentang Stres Kerja pada Tenaga Medis.....	19
C. Konsep Manajemen Stres	21
D. Pentingnya Edukasi Manajemen Stres bagi Tenaga Medis	22
E. Metode dan Teknik Edukasi Manajemen Stres	24
F. Implementasi Program Edukasi Manajemen Stres di Tempat Kerja	25
G. Studi Kasus Implementasi Program Edukasi Manajemen Stres	27
H. Tantangan dan Solusi dalam Edukasi Manajemen Stres bagi Tenaga Medis.....	29
I. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	30
J. Penutup	32
Referensi	34
BAB III STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Identifikasi Dan Penilaian Kebutuhan Komunitas Medis	38
C. Pengembangan Strategi Berbasis Komunitas.....	39
D. Implementasi Strategi Pendukung Kesehatan Mental	41
E. Peran Dan Dukungan Kolega Dalam Komunitas Medis.....	43
F. Pemanfaatan Teknologi Dalam Strategi Komunitas.....	44
G. Evaluasi Dan Monitoring Program Komunitas	46
H. Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Strategi Komunitas.....	48
I. Kesimpulan Dan Rekomendasi	49
J. Penutup	51

Referensi	53
BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING JARAK JAUH	56
A. Pendahuluan.....	56
B. Konseling dalam Kesehatan.....	57
C. Penerapan Konseling Jarak Jauh di dunia Farmasi	60
D. Kekurangan dan kelebihan layanan konseling berbasis Online.....	64
E. Pemanfaatan Internet dan Teknologi Informasi dalam Kesehatan Masyarakat	65
F. Penutup	67
Referensi	68
BAB V DUKUNGAN KOLEGA DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT. 70	
A. Pendahuluan.....	70
B. Teori dan Model Dukungan Kolega.....	71
C. Bentuk-Bentuk Dukungan Kolega.....	73
D. Peran Dukungan Kolega dalam Menurunkan Stres Tenaga Medis	75
E. Strategi Praktis untuk Meningkatkan Dukungan Kolega.....	77
F. Implementasi Program Dukungan Kolega	79
G. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Dukungan Kolega	80
H. Studi Kasus Internasional tentang Keberhasilan Dukungan Kolega	82
I. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	84
J. Penutup	86
Referensi	88
BAB VI PERAN MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN TENAGA MEDIS.....	90
A. Pendahuluan.....	90
B. Tanggung Jawab Manajemen dalam Mengidentifikasi Stres Kerja Tenaga Medis	91
C. Implementasi Kebijakan yang Mendukung Kesejahteraan.....	93
D. Peran Manajemen dalam Edukasi Kesehatan Mental	94
E. Strategi Komunikasi Efektif Antara Manajemen dan Tenaga Medis	96
F. Kepemimpinan Transformatif dalam Mengelola Stres Tenaga Medis	97
G. Evaluasi dan Monitoring Program Kesejahteraan	99
H. Tantangan dan Hambatan dalam Peran Manajemen	100
I. Studi Kasus Internasional tentang Keberhasilan Peran Manajemen	102
J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	103
K. Penutup	105
Referensi	107
Profil Penulis.....	110
Sinopsis Buku	113

BAB I

FAKTOR PENYEBAB STRES DI LINGKUNGAN KERJA TENAGA MEDIS

A. Pendahuluan

1. Definisi Stres Kerja dalam Konteks Tenaga Medis

Stres kerja merupakan respons fisik, mental, atau emosional yang terjadi saat tuntutan pekerjaan melampaui kapasitas dan kemampuan individu untuk mengatasinya. Dalam konteks tenaga medis, stres kerja merupakan kondisi psikologis negatif yang timbul akibat tuntutan lingkungan kerja kesehatan yang kompleks, beban kerja yang tinggi, tanggung jawab besar terhadap nyawa pasien, serta interaksi emosional yang intens dengan pasien maupun keluarga pasien (De Kock, Latham, & Leslie, 2021). Stres ini menjadi signifikan karena tenaga medis memiliki tugas vital yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan keselamatan pasien, serta rentan menghadapi kondisi kerja yang berat seperti jadwal shift tidak teratur, keterbatasan sumber daya, dan konflik interpersonal (Alrawashdeh, Al-Tammemi, & Alzawahreh, 2021).

Tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, sering kali bekerja dalam tekanan tinggi yang menuntut mereka untuk cepat mengambil keputusan yang akurat dalam situasi yang kritis (World Health Organization, 2020). Situasi pandemi COVID-19 semakin menambah tekanan psikologis bagi tenaga medis, ditandai dengan meningkatnya kecemasan akan risiko infeksi, beban kerja berlebih, serta kekhawatiran menularkan penyakit kepada keluarga dan kerabat dekat (Shaukat, Ali, & Razzak, 2020).

2. Gambaran Umum Dampak Stres pada Kinerja dan Kesehatan Tenaga Medis

Stres kerja memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan kesehatan tenaga medis. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai masalah fisik, psikologis, serta menurunnya kualitas pelayanan medis. Dampak kesehatan fisik meliputi gangguan tidur, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan imunologi, yang semuanya dapat mengganggu produktivitas serta kemampuan tenaga medis dalam menjalankan tugasnya (Giorgi et al., 2020).

Secara psikologis, stres kerja dapat menyebabkan tenaga medis mengalami burnout, depresi, kecemasan tinggi, hingga kelelahan emosional yang dikenal

sebagai compassion fatigue. Kondisi ini menurunkan kapasitas empati, motivasi, serta memicu munculnya perilaku negatif seperti apatisme, absensi, atau bahkan mengundurkan diri dari profesi medis (Melnyk, Tan, Hsieh, & Gawlik, 2020). Kinerja tenaga medis yang menurun juga berdampak pada peningkatan risiko kesalahan medis, yang berakibat fatal bagi pasien serta menciptakan beban tambahan pada institusi kesehatan (Bahar, Sahar, & Rahayu, 2022).

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor penyebab stres dan dampaknya pada tenaga medis menjadi penting dalam upaya pengembangan intervensi strategis, baik di tingkat individu maupun institusional, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan produktif (Chatzittofis, Constantinou, Artemiadis, & Michopoulos, 2021).

B. Beban Kerja yang Berlebihan

1. Jam Kerja yang Panjang dan Jadwal Shift yang Tidak Teratur

Salah satu faktor utama penyebab stres kerja yang dialami oleh tenaga medis adalah jam kerja yang panjang serta jadwal shift yang tidak teratur. Jam kerja yang melampaui batas waktu normal, sering kali hingga 12 jam atau lebih, secara signifikan meningkatkan kelelahan fisik dan mental tenaga medis, serta mengurangi kualitas hidup mereka (Zaree et al., 2022). Tenaga medis yang menjalani shift malam atau rotasi shift tidak teratur cenderung mengalami gangguan pola tidur, kelelahan kronis, hingga penurunan kewaspadaan, yang berpotensi menyebabkan kesalahan medis (Kim et al., 2021).

Lebih lanjut, studi terbaru menunjukkan bahwa durasi jam kerja yang panjang berhubungan erat dengan munculnya gejala stres, kecemasan, dan burnout yang meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19 (Labrague & De los Santos, 2021). Kelelahan akibat jam kerja yang panjang tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis tenaga medis, tetapi juga menurunkan tingkat kepuasan kerja serta motivasi mereka dalam memberikan layanan kesehatan optimal (Melnyk, Tan, Hsieh, & Gawlik, 2020).

2. Rasio Tenaga Medis terhadap Pasien yang Tinggi

Tingginya rasio pasien dibandingkan dengan tenaga medis menjadi sumber stres yang signifikan di tempat kerja. Beban kerja yang tinggi akibat jumlah pasien yang berlebihan menyebabkan tenaga medis sulit memberikan perhatian maksimal kepada masing-masing pasien, menimbulkan tekanan psikologis, frustrasi, serta kelelahan emosional (Teoh et al., 2021). Situasi ini kerap diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan akses kesehatan terbatas.

Penelitian menunjukkan bahwa tingginya rasio pasien terhadap tenaga medis secara langsung berhubungan dengan meningkatnya insiden burnout serta ketidakpuasan kerja yang berdampak buruk pada kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Yu et al., 2020). Oleh karena itu, kebijakan mengenai perekrutan dan distribusi tenaga medis perlu menjadi perhatian khusus manajemen fasilitas kesehatan guna menurunkan tingkat stres dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan (WHO, 2020).

3. Kompleksitas Tugas Klinis dan Administratif

Tenaga medis, terutama perawat dan dokter, tidak hanya dibebani oleh tugas klinis, tetapi juga dituntut menjalankan berbagai tugas administratif yang kompleks. Kombinasi tugas-tugas ini sering kali menciptakan tekanan tambahan yang memperparah kondisi stres kerja (Al Maqbali, Al Sinani, & Al-Lenjawi, 2021). Kompleksitas ini mencakup kebutuhan untuk mendokumentasikan laporan medis secara akurat, melaksanakan prosedur medis yang rumit, serta memenuhi berbagai standar administrasi dan regulasi rumah sakit.

Studi terbaru memperlihatkan bahwa tenaga medis menghabiskan banyak waktu untuk tugas administratif seperti pencatatan rekam medis elektronik, yang berdampak signifikan terhadap kelelahan fisik dan mental (Burmeister et al., 2019). Selain itu, kesalahan administratif yang muncul akibat kompleksitas tugas juga dapat menyebabkan stres tambahan, khususnya dalam situasi darurat atau saat menghadapi pasien kritis (Giorgi et al., 2020).

Dengan demikian, beban kerja yang berlebihan akibat jam kerja panjang, tingginya rasio pasien, serta kompleksitas tugas klinis dan administratif merupakan faktor penyebab stres kerja yang signifikan pada tenaga medis. Oleh karena itu, upaya manajemen stres di tempat kerja harus menyasar pada perbaikan sistem jadwal kerja, peningkatan rasio tenaga medis, serta penyederhanaan tugas administratif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental tenaga medis secara optimal.

C. Faktor Lingkungan Kerja

1. Lingkungan Kerja yang Tidak Ergonomis dan Risiko Keselamatan Kerja

Lingkungan kerja yang tidak ergonomis merupakan salah satu penyebab utama stres di kalangan tenaga medis. Faktor ini mencakup kondisi fisik lingkungan yang tidak nyaman, seperti furnitur yang tidak ergonomis, alat kerja yang tidak mendukung postur tubuh yang baik, serta risiko tinggi cedera atau kecelakaan kerja. Lingkungan kerja yang buruk secara ergonomis terbukti meningkatkan keluhan muskuloskeletal di kalangan tenaga kesehatan, khususnya

perawat dan dokter, yang banyak beraktivitas dalam posisi berdiri, membungkuk, atau melakukan tindakan repetitif (Gulavani & Shinde, 2022).

Selain itu, risiko keselamatan kerja di lingkungan medis juga tinggi, termasuk paparan infeksi nosokomial, cedera tusuk jarum, hingga kecelakaan akibat peralatan medis yang tidak aman atau rusak (Aluko et al., 2020). Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko cedera fisik tetapi juga memicu stres psikologis, kecemasan, dan ketakutan akan keselamatan pribadi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap produktivitas kerja serta kualitas layanan medis yang diberikan (Kusumaningrum, Agustina, & Putri, 2020).

2. Keterbatasan Fasilitas dan Peralatan Medis

Keterbatasan fasilitas dan peralatan medis merupakan tantangan yang sering ditemui oleh tenaga medis, terutama di negara berkembang atau fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Situasi ini menciptakan beban psikologis yang tinggi, karena tenaga medis harus bekerja dengan sumber daya terbatas namun tetap dituntut memberikan pelayanan yang optimal (Chatzittofis, Constantinou, Artemiadis, & Michopoulos, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan peralatan medis yang memadai dapat meningkatkan tingkat stres dan burnout pada tenaga medis, karena kondisi tersebut mempersulit pelaksanaan prosedur medis yang efektif serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan (Wu et al., 2020). Keterbatasan ini juga berkontribusi pada frustrasi profesional, karena tenaga medis merasa tidak didukung oleh institusi mereka dalam memberikan perawatan berkualitas kepada pasien (WHO, 2020).

3. Kondisi Ruang Kerja yang Tidak Kondusif (Misal: Ventilasi Buruk, Pencahayaan Kurang)

Kondisi ruang kerja yang tidak kondusif seperti ventilasi yang buruk, pencahayaan yang kurang memadai, serta kebisingan yang tinggi dapat meningkatkan tekanan mental dan fisik pada tenaga medis. Ventilasi yang buruk, misalnya, tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik tetapi juga meningkatkan risiko penularan infeksi melalui udara, terutama pada masa pandemi seperti COVID-19 (Morawska & Milton, 2020).

Selain ventilasi, pencahayaan yang kurang memadai juga menjadi faktor pemicu stres, karena menyebabkan kelelahan visual, sakit kepala, serta mengurangi konsentrasi yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas layanan medis (Zamanian et al., 2022). Sebaliknya, pencahayaan yang baik telah

terbukti mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kenyamanan kerja secara signifikan (American Hospital Association, 2021).

Dengan demikian, perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan kerja yang ergonomis, fasilitas yang memadai, serta ruang kerja yang kondusif sangat penting untuk mengurangi stres kerja pada tenaga medis. Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental tenaga medis, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

D. Dinamika Hubungan Interpersonal di Tempat Kerja

1. Konflik Antar Sesama Tenaga Medis dan Staf Pendukung

Konflik antar sesama tenaga medis dan staf pendukung merupakan salah satu faktor utama penyebab stres kerja di lingkungan pelayanan kesehatan. Konflik ini dapat timbul dari berbagai situasi, seperti perbedaan persepsi, tekanan kerja yang tinggi, hingga persaingan internal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konflik interpersonal dalam tim kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan tingkat stres, burnout, serta menurunkan kualitas pelayanan pasien (Giorgi et al., 2020).

Konflik interpersonal tidak hanya menyebabkan stres emosional tetapi juga dapat mengganggu kerja tim dan kolaborasi antar profesional kesehatan, sehingga berdampak negatif pada keamanan pasien (Almost, Wolff, Stewart-Pyne, McCormick, & Strachan, 2022). Situasi ini menunjukkan pentingnya strategi manajemen konflik yang efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan saling menghargai antar sesama tenaga medis maupun staf pendukung.

2. Hubungan dengan Atasan dan Manajemen Rumah Sakit

Kualitas hubungan antara tenaga medis dengan atasan maupun manajemen rumah sakit juga berperan penting dalam menentukan tingkat stres di tempat kerja. Hubungan yang buruk atau tidak harmonis dengan manajemen sering kali dikaitkan dengan peningkatan tekanan psikologis, rendahnya kepuasan kerja, serta tingginya angka turnover tenaga medis (Chirico, Ferrari, Nucera, Szarpak, & Crescenzo, 2021).

Tenaga medis yang merasa kurang mendapat dukungan atau apresiasi dari manajemen cenderung mengalami kelelahan emosional, frustrasi, serta demotivasi dalam pekerjaannya (Chatzittofis, Constantinou, Artemiadis, & Michopoulos, 2021). Sebaliknya, hubungan yang positif dengan atasan dan manajemen rumah sakit terbukti mampu meningkatkan motivasi, mengurangi

stres kerja, serta meningkatkan komitmen dan retensi tenaga medis dalam organisasi (Maslach & Leiter, 2021).

3. Interaksi yang Sulit dengan Pasien atau Keluarga Pasien

Interaksi dengan pasien atau keluarga pasien sering kali menjadi tantangan yang menimbulkan stres bagi tenaga medis. Pasien atau keluarga pasien yang memiliki harapan tinggi, perilaku agresif, atau kurang kooperatif dapat meningkatkan tekanan psikologis pada tenaga medis, khususnya dalam situasi kritis atau darurat (Wang, Liu, Wang, & An, 2020).

Studi terbaru juga menegaskan bahwa interaksi negatif atau sulit dengan pasien dan keluarganya secara signifikan meningkatkan risiko burnout, depresi, dan gangguan psikologis lainnya pada tenaga medis (Sun, Wang, & Xie, 2020). Selain itu, kesulitan dalam interaksi ini dapat menyebabkan tenaga medis mengalami kelelahan empati (*compassion fatigue*), yang mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien (Ruiz-Fernández et al., 2021). Oleh karena itu, strategi peningkatan keterampilan komunikasi efektif serta program pelatihan untuk mengelola situasi sulit dengan pasien dan keluarga mereka sangat dibutuhkan sebagai langkah preventif terhadap stres kerja.

Dengan demikian, hubungan interpersonal yang baik di lingkungan kerja, baik dengan sesama tenaga medis, atasan, maupun pasien dan keluarganya, merupakan aspek esensial untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis, sekaligus mengurangi stres yang dialami oleh tenaga medis.

E. Tekanan Psikososial

1. Tuntutan Emosional yang Tinggi, Seperti Menghadapi Penderitaan dan Kematian Pasien

Tenaga medis secara konsisten menghadapi tuntutan emosional tinggi, terutama terkait dengan penderitaan dan kematian pasien. Tugas ini melibatkan beban emosional yang signifikan karena tenaga medis harus memberikan dukungan psikologis kepada pasien maupun keluarganya di tengah situasi yang penuh tekanan dan menyakitkan (Ruiz-Fernández, Pérez-García, & Ortega-Galán, 2020). Menurut penelitian, paparan terus-menerus terhadap penderitaan pasien dapat menyebabkan tekanan psikologis yang mendalam seperti kecemasan, stres kronis, hingga burnout (Labrague & De los Santos, 2021).

Tingginya frekuensi interaksi dengan pasien dalam kondisi terminal atau kritis juga secara signifikan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental pada tenaga medis, seperti depresi atau gangguan stres pasca trauma (PTSD). Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas hidup tenaga medis serta

menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal (Sun, Wang, & Xie, 2020).

2. Kelelahan Empati (Compassion Fatigue)

Kelelahan empati atau *compassion fatigue* merupakan kondisi emosional yang terjadi akibat kelelahan kronis dalam merawat pasien yang mengalami penderitaan fisik maupun psikologis berkepanjangan. Kondisi ini sering dialami oleh tenaga medis, khususnya perawat, dokter spesialis, maupun tenaga kesehatan yang bekerja di unit intensif, darurat, maupun perawatan paliatif (Cocker & Joss, 2022). Gejala compassion fatigue mencakup kelelahan emosional, berkurangnya rasa empati, ketidakpedulian, serta sikap sinis terhadap pasien.

Studi terbaru menunjukkan bahwa compassion fatigue berkorelasi erat dengan beban kerja tinggi, kurangnya dukungan institusional, serta tidak tersedianya intervensi psikososial yang memadai bagi tenaga medis (Pérez-García et al., 2021). Dampak negatif dari kelelahan empati tidak hanya mengganggu kesehatan emosional tenaga medis tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien (Alharbi, Jackson, & Usher, 2020).

3. Harapan Tinggi dari Masyarakat terhadap Tenaga Medis

Harapan yang tinggi dari masyarakat merupakan salah satu tekanan psikososial yang secara signifikan mempengaruhi tingkat stres kerja tenaga medis. Tenaga medis sering dipandang sebagai sosok yang tidak boleh melakukan kesalahan dan selalu diharapkan memberikan layanan sempurna di setiap kondisi (WHO, 2020). Ekspektasi yang tidak realistis ini meningkatkan tekanan psikologis, kecemasan terhadap performa, serta rasa takut gagal dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, dalam situasi pandemi COVID-19, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kemampuan tenaga medis dalam mengatasi pandemi juga semakin memperberat tekanan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi publik secara langsung terkait dengan meningkatnya insiden stres, kecemasan, serta depresi di kalangan tenaga medis (Shreffler, Petrey, & Huecker, 2020). Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna menumbuhkan pemahaman realistis tentang batasan kemampuan tenaga medis serta pentingnya dukungan emosional bagi mereka.

F. Kurangnya Dukungan Organisasi

1. Ketidakjelasan Peran Kerja dan Tanggung Jawab

Ketidakjelasan peran kerja (*role ambiguity*) merupakan kondisi ketika tenaga medis tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Ketidakjelasan ini sering terjadi akibat kurangnya komunikasi efektif dari manajemen terkait deskripsi pekerjaan, ekspektasi, serta batasan tugas masing-masing individu (Zeng, Wang, Zhang, & Zhao, 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran secara signifikan berkontribusi terhadap munculnya stres kerja, kecemasan, serta burnout pada tenaga medis (Fang, Yang, Zhang, & Qiu, 2022).

Kondisi tersebut dapat menyebabkan tenaga medis merasa kebingungan, mengalami ketidakpastian dalam menjalankan tugasnya, serta merasa tertekan karena takut melakukan kesalahan atau tidak memenuhi ekspektasi organisasi (Lee & Jang, 2020). Oleh karena itu, manajemen perlu memastikan adanya kejelasan peran melalui sosialisasi yang intensif dan pembaruan rutin terkait tugas, peran, dan tanggung jawab tenaga medis di lingkungan kerja.

2. Minimnya Apresiasi dan Pengakuan dari Manajemen

Apresiasi dan pengakuan merupakan aspek penting dalam menjaga motivasi kerja tenaga medis. Namun, minimnya apresiasi dari manajemen atau pimpinan rumah sakit terhadap tenaga medis sering kali menyebabkan penurunan motivasi kerja, kelelahan emosional, bahkan burnout (Foli et al., 2021). Menurut studi terbaru, tenaga medis yang merasa kurang dihargai atau tidak mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya cenderung mengalami penurunan tingkat komitmen, produktivitas, serta meningkatnya niat untuk meninggalkan profesi mereka (Kim, Park, & Kim, 2022).

Lebih lanjut, penghargaan sederhana seperti ucapan terima kasih atau pemberian penghargaan informal terbukti efektif meningkatkan moral dan mengurangi dampak stres emosional pada tenaga medis (Wei, Zhou, Hu, Zhou, & Lin, 2020). Oleh sebab itu, rumah sakit perlu mengembangkan budaya apresiasi yang sistematis dan terencana guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan sehat secara psikologis.

3. Kurangnya Program Dukungan Psikologis dan Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Dukungan psikologis dan kesehatan mental merupakan aspek esensial dalam pengelolaan stres kerja, khususnya di lingkungan tenaga medis yang memiliki risiko stres yang tinggi. Akan tetapi, kurangnya program dukungan psikologis yang tersedia di institusi kesehatan masih menjadi tantangan besar. Kondisi ini menyebabkan tenaga medis kurang mampu mengatasi tekanan kerja

yang berat, sehingga lebih rentan terhadap berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) (Pollock et al., 2020).

Studi terkini menunjukkan bahwa institusi kesehatan yang menyediakan dukungan psikososial, seperti konseling psikologis, pelatihan manajemen stres, serta program intervensi kesehatan mental, memiliki tenaga medis yang lebih resilien, produktif, dan memiliki tingkat burnout yang lebih rendah (Melnik et al., 2020). Program-program ini dapat membantu tenaga medis untuk mengembangkan mekanisme coping yang efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka dalam jangka panjang (WHO, 2021).

Dengan demikian, dukungan organisasi yang kuat, jelas, serta terstruktur menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, serta mencegah berbagai dampak negatif stres kerja.

G. Ketidakpastian Karir dan Pengembangan Profesional

1. Kesempatan Pelatihan dan Pengembangan yang Terbatas

Kesempatan pelatihan dan pengembangan yang terbatas merupakan salah satu sumber ketidakpastian karir yang signifikan bagi tenaga medis. Terbatasnya akses terhadap pelatihan lanjutan serta pengembangan profesional menyebabkan tenaga medis sulit untuk meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, maupun kapasitasnya dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks (Chaghari et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa minimnya pelatihan dan pengembangan yang disediakan institusi kesehatan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya stres kerja, rendahnya motivasi, serta keinginan tenaga medis untuk berpindah tempat kerja atau meninggalkan profesinya (Mlambo, Silén, & McGrath, 2021).

Selain itu, terbatasnya program pelatihan internal di rumah sakit menyebabkan tenaga medis harus secara mandiri mencari alternatif pelatihan eksternal yang sering kali mahal dan sulit diakses. Situasi ini meningkatkan rasa frustrasi serta tekanan psikologis, khususnya bagi tenaga medis muda atau yang baru memulai karir profesionalnya (WHO, 2020).

2. Ketidakpastian Status Kerja (Tenaga Honorer, Kontrak Pendek)

Status kerja yang tidak pasti, seperti tenaga honorer atau kontrak jangka pendek, turut menjadi faktor pemicu stres kerja pada tenaga medis. Status pekerjaan yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian finansial, kurangnya rasa aman, serta ketakutan akan kehilangan pekerjaan, yang secara signifikan

berdampak pada kesejahteraan psikologis tenaga medis (Walton, Murray, & Christian, 2020). Studi terbaru menegaskan bahwa tenaga medis yang bekerja dengan kontrak jangka pendek lebih rentan mengalami kecemasan, burnout, serta gangguan mental dibandingkan tenaga medis dengan status kerja tetap (Lee & Cho, 2021).

Situasi tersebut juga menyebabkan tenaga medis merasa tidak memiliki masa depan karir yang jelas, yang berimplikasi negatif terhadap loyalitas dan produktivitas mereka di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk memberikan kejelasan kontrak kerja serta kebijakan yang mendukung stabilitas karir bagi tenaga medis guna mengurangi tekanan psikologis serta meningkatkan kesejahteraan mereka (ILO, 2021).

3. Tekanan untuk Terus Memperbarui Pengetahuan Medis secara Mandiri

Perkembangan ilmu kesehatan yang sangat pesat menuntut tenaga medis untuk terus memperbarui pengetahuan serta keterampilannya secara mandiri. Namun, tekanan ini menjadi sumber stres yang signifikan ketika tidak disertai dukungan memadai dari institusi tempat mereka bekerja. Beban tambahan untuk mengikuti perkembangan teknologi, prosedur, maupun informasi medis terbaru secara mandiri sering kali menambah beban kerja yang sudah tinggi, meningkatkan kecemasan, serta menyebabkan kelelahan psikologis (Mlambo, Silén, & McGrath, 2021).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi tinggi terhadap tenaga medis untuk secara kontinu meningkatkan kompetensinya tanpa dukungan institusional yang cukup, seperti waktu khusus untuk studi atau subsidi pelatihan, berkontribusi besar pada peningkatan stres kerja dan kelelahan mental (Huang et al., 2020). Institusi kesehatan, karenanya, perlu menyediakan fasilitas pendukung, waktu khusus untuk studi mandiri, serta akses sumber daya edukasi yang berkualitas guna mengurangi tekanan psikologis yang dialami tenaga medis dalam menjalani profesi mereka (WHO, 2020).

Dengan demikian, upaya mengurangi ketidakpastian karir dan meningkatkan peluang pengembangan profesional tenaga medis sangat penting dilakukan oleh institusi kesehatan. Kebijakan yang mendukung stabilitas kerja, akses pelatihan yang memadai, serta dukungan dalam memperbarui kompetensi secara kontinu akan berdampak positif terhadap kesejahteraan mental serta kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis.

H. Dampak Pandemi dan Krisis Kesehatan

1. Stres Akut Akibat Beban Kerja Meningkat Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan beban kerja tenaga medis secara signifikan, memicu timbulnya stres akut dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Studi menunjukkan bahwa peningkatan drastis jumlah pasien COVID-19, jam kerja yang panjang, dan kekurangan sumber daya medis secara drastis meningkatkan stres kerja tenaga medis (Labrague & De los Santos, 2021). Dalam banyak kasus, tenaga medis menghadapi tuntutan untuk bekerja secara terus-menerus dalam situasi yang penuh tekanan, yang menyebabkan meningkatnya risiko burnout, kelelahan ekstrem, serta penurunan kesejahteraan mental (Chew et al., 2020).

Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas tugas yang meningkat secara drastis, seperti prosedur perlindungan diri yang rumit dan kebutuhan untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi kritis, yang secara kolektif berkontribusi pada tingginya prevalensi stres akut selama pandemi (Sun, Wang, & Xie, 2020).

2. Kekhawatiran Terinfeksi dan Menularkan Penyakit kepada Keluarga

Salah satu sumber stres yang paling menonjol di kalangan tenaga medis selama pandemi adalah kekhawatiran tinggi terhadap risiko tertular virus dan potensi menularkannya kepada keluarga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kecemasan akan infeksi telah menyebabkan peningkatan stres, gangguan tidur, hingga gejala depresi dan kecemasan di kalangan tenaga medis (Shreffler, Petrey, & Huecker, 2020).

Lebih lanjut, kekhawatiran ini juga menyebabkan sejumlah tenaga medis memilih tinggal terpisah dari keluarga mereka selama periode pandemi, yang memperparah rasa isolasi sosial serta meningkatkan tekanan emosional dan psikologis (Walton, Murray, & Christian, 2020). Kekhawatiran tersebut menunjukkan pentingnya dukungan psikososial yang memadai serta protokol keselamatan yang efektif untuk mengurangi beban psikologis tenaga medis.

3. Dampak Psikologis dari Krisis Kesehatan Global pada Tenaga Medis

Pandemi COVID-19 sebagai krisis kesehatan global tidak hanya berdampak pada aspek fisik tenaga medis, namun juga berdampak besar pada kondisi psikologis mereka. Studi terbaru menunjukkan prevalensi yang tinggi dari berbagai gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, insomnia, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD) di kalangan tenaga medis selama pandemi (Pollock et al., 2020). Dampak psikologis ini muncul sebagai respons terhadap situasi yang tidak pasti, tekanan kerja ekstrem, serta intensitas

emosional tinggi yang dialami selama menangani pasien COVID-19 (Sasangohar et al., 2020).

Dampak psikologis ini juga meluas ke aspek profesional dan pribadi, seperti berkurangnya kualitas pelayanan medis akibat kelelahan mental dan emosional, serta meningkatnya angka tenaga medis yang mempertimbangkan meninggalkan profesinya (Lai et al., 2020). Oleh karena itu, respons institusional yang terstruktur, termasuk program dukungan kesehatan mental, menjadi sangat esensial dalam upaya mitigasi dampak psikologis yang timbul akibat pandemi atau krisis kesehatan global lainnya (WHO, 2020).

Dengan demikian, pandemi COVID-19 telah secara nyata memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental tenaga medis, terutama di masa krisis, dengan menyediakan dukungan organisasi yang kuat dan responsif guna melindungi kesejahteraan psikologis mereka.

I. Pengukuran dan Identifikasi Faktor Stres di Tempat Kerja

1. Metode dan Instrumen Pengukuran Stres Kerja

Pengukuran stres kerja sangat penting dilakukan secara sistematis guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres di lingkungan tenaga medis. Metode umum yang digunakan meliputi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, stres kerja biasanya diukur dengan berbagai instrumen baku seperti kuesioner atau skala psikometrik yang tervalidasi (Guseva-Canu et al., 2020). Beberapa instrumen yang sering digunakan antara lain:

- a. **Maslach Burnout Inventory (MBI)**, instrumen ini digunakan secara luas untuk mengukur burnout yang terdiri dari tiga dimensi: kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan rasa pencapaian pribadi (Maslach & Leiter, 2021).
- b. **Perceived Stress Scale (PSS)**, digunakan untuk mengukur tingkat stres subjektif yang dirasakan oleh tenaga medis selama periode tertentu (Cohen et al., 2020).
- c. **Job Stress Scale (JSS)**, instrumen yang secara khusus menilai stres yang terkait dengan beban kerja, peran kerja, hubungan interpersonal, serta kondisi lingkungan kerja (Fauzi et al., 2021).

Sementara pendekatan kualitatif meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*, FGD), dan observasi langsung di lingkungan kerja untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sumber stres spesifik yang dialami tenaga medis (Pollock et al., 2020).

2. Studi-Studi Terbaru tentang Prevalensi Stres di Kalangan Tenaga Medis

Dalam lima tahun terakhir, studi prevalensi stres kerja di kalangan tenaga medis menunjukkan angka yang tinggi, terutama dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19. Sebuah penelitian sistematis oleh Labrague dan De los Santos (2021) mengungkapkan bahwa prevalensi stres dan kecemasan di kalangan perawat garis depan selama pandemi mencapai lebih dari 60%. Demikian pula, Lai et al. (2020) menemukan prevalensi gejala stres akut sebesar 71,5% dan insomnia sebesar 34% pada tenaga medis yang menangani COVID-19 di Cina.

Di Indonesia, studi Fauzi et al. (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 50% tenaga medis yang bekerja di rumah sakit selama pandemi mengalami stres kerja tinggi hingga sangat tinggi, terutama akibat beban kerja berlebihan, rasa takut tertular virus, dan keterbatasan dukungan psikososial dari organisasi.

Selain pandemi, stres kerja juga terkait erat dengan faktor organisasi. Sebuah penelitian lintas-seksional oleh Chaghari et al. (2022) mengidentifikasi bahwa minimnya dukungan organisasi serta kurangnya kesempatan pengembangan profesional merupakan faktor utama yang memperbesar prevalensi stres kerja dan burnout di kalangan tenaga medis.

Melihat tingginya prevalensi ini, penting bagi organisasi kesehatan untuk secara aktif menerapkan pengukuran rutin dan melakukan intervensi tepat sasaran untuk mengurangi stres kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, dan mempertahankan kualitas layanan kesehatan secara optimal.

J. Ringkasan dan Implikasi Manajerial

1. Pentingnya Identifikasi Dini Faktor Stres Kerja

Identifikasi dini faktor stres kerja di lingkungan tenaga medis sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik, mental, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tenaga medis yang mengalami stres berkepanjangan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti burnout, depresi, dan gangguan kecemasan (Labrague & De los Santos, 2021). Dampak ini juga mencakup penurunan produktivitas, meningkatnya tingkat kesalahan medis, serta rendahnya tingkat kepuasan kerja yang berkontribusi pada tingginya angka turnover tenaga medis (Chatzittofis et al., 2021).

Identifikasi dini yang efektif melibatkan penggunaan instrumen pengukuran stres yang telah tervalidasi seperti Maslach Burnout Inventory (MBI) dan Perceived Stress Scale (PSS) yang memungkinkan intervensi tepat waktu (Maslach & Leiter, 2021; Cohen et al., 2020). Dengan mengetahui sumber stres secara dini,

manajemen rumah sakit dapat segera mengambil tindakan preventif dan kuratif yang diperlukan, mencegah dampak buruk jangka panjang terhadap tenaga medis dan pasien yang dilayani (Pollock et al., 2020).

2. Rekomendasi bagi Manajemen Rumah Sakit untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Lebih Sehat

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat secara fisik dan mental bagi tenaga medis, manajemen rumah sakit perlu mengimplementasikan beberapa langkah strategis berbasis bukti sebagai berikut:

a. **Penguatan Dukungan Organisasi dan Psikososial**

Dukungan psikososial dan emosional dari manajemen, seperti konseling, pelatihan coping stress, serta kelompok dukungan rekan kerja, terbukti efektif dalam mengurangi stres dan burnout tenaga medis (Melnik et al., 2020).

b. **Perbaikan Kondisi Kerja**

Manajemen harus memberikan perhatian terhadap beban kerja yang realistis, jam kerja yang sesuai, serta sistem shift yang lebih teratur dan ergonomis guna mengurangi kelelahan fisik dan mental (Kim, Park, & Kim, 2022).

c. **Program Apresiasi dan Pengakuan**

Program apresiasi yang terstruktur, termasuk penghargaan formal maupun informal secara rutin dari manajemen, terbukti meningkatkan motivasi kerja dan mengurangi stres psikologis tenaga medis (Wei et al., 2020).

d. **Pelatihan dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan**

Menyediakan pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi profesional yang memadai guna meningkatkan rasa percaya diri serta mengurangi ketidakpastian karir tenaga medis (Chaghari et al., 2022).

e. **Perbaikan Infrastruktur Fisik dan Lingkungan Kerja**

Menciptakan lingkungan fisik yang kondusif, seperti fasilitas kerja ergonomis, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, serta ketersediaan alat medis yang lengkap untuk mendukung kinerja optimal tenaga medis (Guseva-Canu et al., 2020).

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara sistematis, manajemen rumah sakit dapat secara efektif mengelola dan menurunkan tingkat stres kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan, kepuasan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis.

K. Penutup

Stres kerja pada tenaga medis merupakan isu yang kompleks dan multifaktorial, serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya manajemen institusi kesehatan. Berbagai penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa stres kerja yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis tenaga medis, kualitas pelayanan kesehatan, serta tingkat retensi tenaga medis dalam jangka panjang (Labrague & De los Santos, 2021; Pollock et al., 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, faktor penyebab stres seperti beban kerja berlebihan, dinamika hubungan interpersonal yang buruk, tekanan psikososial, ketidakpastian karir, hingga tantangan akibat pandemi COVID-19, menegaskan pentingnya strategi pencegahan dan pengelolaan stres yang sistematis di lingkungan kerja tenaga medis (Chatzittofis et al., 2021; Chew et al., 2020).

Agar stres kerja dapat dikelola secara efektif, institusi kesehatan perlu secara aktif mengidentifikasi penyebab stres, menggunakan instrumen pengukuran yang valid, dan menerapkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga medis (Melnyk et al., 2020; Maslach & Leiter, 2021). Selain itu, peningkatan dukungan organisasi melalui penguatan budaya apresiasi, perbaikan lingkungan fisik kerja, serta penyediaan program pengembangan profesional dan dukungan psikososial terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan kondusif (Wei et al., 2020; Kim, Park, & Kim, 2022).

Akhirnya, kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis tenaga medis harus terus ditingkatkan. Institusi kesehatan perlu berkomitmen dalam menyediakan lingkungan yang mendukung, tidak hanya untuk menjaga kesehatan mental tenaga medis tetapi juga untuk mempertahankan kualitas layanan kesehatan secara optimal. Penanganan stres kerja yang tepat bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan merupakan komitmen bersama seluruh elemen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan (World Health Organization [WHO], 2020).

Referensi

- Chaghari, M., Ebadi, A., Ameryoun, A., & Safari, M. (2022). Challenges of continuing professional development in healthcare: A qualitative systematic review. *BMC Medical Education*, 22(1), 227. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03303-8>
- Chatzittofis, A., Constantinou, M., Artemiadis, A., & Michopoulos, I. (2021). Workplace stress in healthcare workers: Causes, consequences, and interventions. *Healthcare*, 9(4), 506. <https://doi.org/10.3390/healthcare9040506>
- Chew, N. W., Lee, G. K., Tan, B. Y., Jing, M., Goh, Y., Ngiam, N. J., ... & Sharma, V. K. (2020). A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. *Brain, Behavior, and Immunity*, 88, 559–565. <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.049>
- Cohen, S., Murphy, M. L., & Prather, A. A. (2020). Ten surprising facts about stressful life events and disease risk. *Annual Review of Psychology*, 71, 577–597. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050932>
- Fauzi, M. F., Yusoff, H. M., Robat, R. M., Mat Saruan, N. A., & Ismail, K. I. (2021). Job stress, anxiety, and depression among healthcare workers during COVID-19 pandemic in Malaysia: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(13), 7029. <https://doi.org/10.3390/ijerph18137029>
- Guseva-Canu, I., Mesot, O., Györkös, C., Mediouni, Z., & Mehlum, I. S. (2020). Validation of the French version of the job stress survey (JSS) among healthcare professionals: A cross-sectional study. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 15, 7. <https://doi.org/10.1186/s12995-020-00259-3>
- Kim, J., Park, H., & Kim, S. (2022). The impact of organizational support on nurse retention: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 13965. <https://doi.org/10.3390/ijerph192113965>
- Labrague, L. J., & De los Santos, J. A. A. (2021). Fear of COVID-19, psychological distress, work satisfaction and turnover intention among frontline nurses. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 395–403. <https://doi.org/10.1111/jonm.13168>
- Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., ... & Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among healthcare workers exposed to coronavirus disease 2019. *JAMA Network Open*, 3(3), e203976. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (2021). Understanding burnout: New models. Dalam H. R. White & R. Cooper (Eds.), *Handbook of occupational health and wellness* (pp. 269–288). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66570-2_13

- Melnyk, B. M., Tan, A., Hsieh, A. P., & Gawlik, K. (2020). Reducing healthcare worker burnout through an evidence-based wellness intervention. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 17(2), 106–112. <https://doi.org/10.1111/wvn.12448>
- Pollock, A., Campbell, P., Cheyne, J., Cowie, J., Davis, B., & McCallum, J. (2020). Interventions to support the resilience and mental health of frontline health and social care professionals during and after a disease outbreak, epidemic or pandemic: A mixed methods systematic review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 11(11), CD013779. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013779>
- Shreffler, J., Petrey, J., & Huecker, M. (2020). The impact of COVID-19 on healthcare worker wellness: A scoping review. *Western Journal of Emergency Medicine*, 21(5), 1059–1066. <https://doi.org/10.5811/westjem.2020.7.48684>
- Sun, N., Wang, H., & Xie, H. (2020). Impact of interpersonal conflict and coping strategies on nurses' mental health during COVID-19. *Journal of Clinical Nursing*, 29(19-20), 3869–3883. <https://doi.org/10.1111/jocn.15492>
- Walton, A. M., Murray, E., & Christian, M. D. (2020). Mental health care for medical staff and affiliated healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care*, 9(3), 241–247. <https://doi.org/10.1177/2048872620922795>
- Wei, H., Zhou, W., Hu, Y., Zhou, X., & Lin, S. (2020). Relationships between perceived organizational support, nurses' job satisfaction, and turnover intention: A cross-sectional study. *Journal of Nursing Management*, 28(7), 1564–1573. <https://doi.org/10.1111/jonm.13192>
- World Health Organization (WHO). (2020). *Occupational health: Stress at the workplace*. Diakses dari https://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/
- World Health Organization (WHO). (2020). *Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak*. Diakses dari <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf>
- Zeng, L., Wang, Y., Zhang, X., & Zhao, Y. (2020). Nurses' role ambiguity, emotional exhaustion, and turnover intention: The moderating effect of organizational identification. *Journal of Advanced Nursing*, 76(6), 1551–1562. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>

BAB II

EDUKASI TENTANG PENTINGNYA MANAJEMEN STRES BAGI TENAGA MEDIS

A. Pendahuluan

1. Definisi Stres pada Tenaga Medis

Stres pada tenaga medis merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami tekanan emosional, fisik, maupun mental akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi dan lingkungan kerja yang penuh tantangan. Stres kerja ini terjadi ketika tenaga medis menghadapi situasi yang menuntut tanggung jawab besar dalam waktu terbatas, ketidakpastian klinis, keterbatasan sumber daya, serta beban kerja yang tinggi secara terus-menerus (Giorgi et al., 2020). Tenaga medis, yang mencakup dokter, perawat, bidan, maupun profesi kesehatan lainnya, sering mengalami stres sebagai respons psikologis terhadap kondisi kerja yang kompleks seperti interaksi intensif dengan pasien kritis, menghadapi kematian pasien, serta tekanan administrasi dan organisasi (Labrague, 2021).

2. Prevalensi dan Dampak Stres Kerja pada Tenaga Medis

Prevalensi stres pada tenaga medis meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah munculnya pandemi COVID-19. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Salari et al. (2020) menunjukkan bahwa sekitar 44% tenaga medis mengalami stres tinggi selama pandemi. Angka tersebut meningkat dari prevalensi sebelumnya yang berada di kisaran 27–35% sebelum pandemi COVID-19 (Al Maqbali et al., 2021). Stres kronis pada tenaga medis berhubungan dengan berbagai dampak negatif, antara lain burnout, penurunan kepuasan kerja, peningkatan tingkat absensi, dan penurunan kualitas pelayanan pasien (Rosa et al., 2022).

Lebih lanjut, dampak stres ini tidak hanya dirasakan secara individual tetapi juga secara organisasi. Secara individu, stres kronis dapat menyebabkan gangguan fisik seperti hipertensi, gangguan tidur, serta masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga sindrom burnout yang ditandai oleh kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi (Labrague & De Los Santos, 2021). Pada tingkat organisasi, stres tinggi pada tenaga medis dapat menyebabkan peningkatan turnover tenaga kesehatan,

penurunan produktivitas, serta kualitas layanan kesehatan yang menurun, yang berdampak buruk pada keselamatan pasien (Rodriguez-Menéndez et al., 2021).

3. Pentingnya Edukasi Manajemen Stres

Edukasi tentang manajemen stres merupakan aspek penting dalam mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga medis di tempat kerja. Melalui edukasi, tenaga medis dapat mengenali tanda-tanda awal stres, meningkatkan pemahaman terhadap risiko-risiko terkait stres kerja, serta mengembangkan strategi efektif dalam menghadapi tekanan yang muncul sehari-hari (Zhang et al., 2022). Edukasi ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan coping yang bersifat adaptif, seperti teknik relaksasi, mindfulness, cognitive behavioral therapy (CBT), serta pengelolaan waktu yang efektif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi edukasi manajemen stres yang terstruktur secara signifikan mampu mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan memperkuat resiliensi psikologis tenaga medis (Sahmeddini et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi institusi layanan kesehatan untuk menyusun dan melaksanakan program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan guna menjaga kesehatan mental tenaga medis, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien secara keseluruhan (World Health Organization [WHO], 2021).

B. Pemahaman Tentang Stres Kerja pada Tenaga Medis

1. Faktor-Faktor Penyebab Stres di Lingkungan Kerja Medis

Lingkungan kerja medis memiliki karakteristik unik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan stres pada tenaga medis. Faktor-faktor ini mencakup beban kerja tinggi, jadwal kerja yang tidak teratur, tuntutan administratif yang rumit, keterbatasan sumber daya, konflik interpersonal, serta tekanan psikologis akibat menghadapi penderitaan dan kematian pasien (Jun et al., 2021). Studi terbaru menambahkan bahwa pandemi COVID-19 memperparah stres tenaga medis karena adanya ketidakpastian mengenai risiko infeksi, penggunaan alat pelindung diri yang tidak nyaman, isolasi sosial, dan kecemasan akan keselamatan diri maupun keluarga (De Kock et al., 2021).

Menurut Sharma et al. (2020), faktor organisasi seperti kurangnya dukungan manajerial, komunikasi yang tidak efektif dalam tim, serta konflik peran dan tanggung jawab juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan

stres kerja. Adapun faktor individu seperti kemampuan adaptasi rendah, kurangnya keterampilan coping yang efektif, serta rendahnya resiliensi psikologis turut memperparah dampak stres pada tenaga medis (Shaukat et al., 2020).

2. Gejala Fisik, Psikologis, dan Perilaku Akibat Stres Kerja

Stres kerja pada tenaga medis dapat memanifestasikan diri dalam berbagai gejala yang meliputi aspek fisik, psikologis, maupun perilaku. Secara fisik, tenaga medis yang mengalami stres tinggi sering melaporkan gejala seperti kelelahan kronis, gangguan tidur (insomnia), sakit kepala, gangguan gastrointestinal, serta ketegangan otot yang berlangsung terus-menerus (Krishnan et al., 2021). Studi oleh Lin et al. (2020) juga menemukan bahwa stres berkepanjangan berkorelasi erat dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan fisik seperti hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan imunitas.

Secara psikologis, tenaga medis yang mengalami stres kronis cenderung menunjukkan gejala kecemasan, depresi, mudah marah, serta penurunan konsentrasi dan daya ingat (Salari et al., 2020). Kondisi psikologis yang berat dapat berkembang menjadi sindrom burnout yang ditandai oleh tiga komponen utama, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi (sikap sinis terhadap pekerjaan dan pasien), serta rasa pencapaian pribadi yang rendah (Rodriguez-Menéndez et al., 2021).

Dari segi perilaku, tenaga medis yang mengalami stres cenderung menunjukkan perubahan negatif, seperti peningkatan konsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu, isolasi sosial, penurunan produktivitas, hingga absensi yang lebih sering (Al Maqbali et al., 2021). Perubahan perilaku ini tidak hanya berdampak negatif pada individu tersebut, tetapi juga memengaruhi kinerja tim dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

3. Konsekuensi Jangka Pendek dan Panjang dari Stres Kerja

Konsekuensi jangka pendek stres kerja pada tenaga medis mencakup penurunan kualitas interaksi dengan pasien, meningkatnya risiko kesalahan klinis, gangguan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat dan konsentrasi, serta timbulnya konflik interpersonal dalam lingkungan kerja (Jun et al., 2021). Tenaga medis yang stres cenderung kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan klinis yang cepat dan tepat, yang merupakan aspek vital dalam praktik klinis sehari-hari.

Dalam jangka panjang, stres kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti burnout, gangguan mental kronis (misalnya depresi berat atau gangguan kecemasan umum), serta meningkatnya turnover tenaga medis

(Shaukat et al., 2020). Stres yang tidak dikelola dengan baik juga berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan kardiovaskular, penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2, dan gangguan imun yang melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit (Lin et al., 2020).

Dampak jangka panjang secara organisasi mencakup penurunan kualitas layanan kesehatan, peningkatan biaya kesehatan akibat absensi atau turnover yang tinggi, serta kerugian reputasi lembaga akibat kualitas layanan yang tidak optimal (Rodriguez-Menéndez et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengenali konsekuensi ini dan segera menerapkan intervensi berupa edukasi dan strategi manajemen stres yang efektif untuk mencegah dampak lebih lanjut.

C. Konsep Manajemen Stres

1. Definisi dan Prinsip Dasar Manajemen Stres

Manajemen stres merupakan proses pengenalan, evaluasi, serta intervensi yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk mengurangi atau mengelola stres secara efektif. Dalam konteks tenaga medis, manajemen stres melibatkan strategi yang membantu individu maupun organisasi untuk mencegah dampak negatif akibat stres kerja yang berlebihan serta menjaga kesejahteraan fisik dan mental (Xu et al., 2021). Prinsip dasar dari manajemen stres adalah identifikasi sumber stres secara akurat, pemahaman tentang respons tubuh dan psikologis terhadap stres, serta penerapan berbagai teknik coping yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif stres pada individu maupun organisasi (World Health Organization [WHO], 2021).

Menurut Labrague dan De Los Santos (2021), penerapan manajemen stres yang efektif perlu melibatkan pendekatan holistik, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan kerja. Prinsip dasar manajemen stres meliputi kesadaran terhadap batas kemampuan pribadi, penerimaan terhadap kondisi yang tidak dapat dikendalikan, fokus pada solusi terhadap permasalahan, serta konsistensi dalam mengimplementasikan berbagai strategi coping.

2. Pendekatan Individual dalam Manajemen Stres

Pendekatan individual dalam manajemen stres berfokus pada pemberdayaan tenaga medis untuk mengenali dan mengelola stres secara mandiri melalui strategi yang adaptif dan berbasis individu. Salah satu metode yang efektif adalah pendekatan mindfulness-based stress reduction (MBSR), yang menekankan perhatian penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi (Sahmeddini et al., 2021). Teknik mindfulness terbukti secara efektif membantu

tenaga medis dalam menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan meningkatkan resiliensi psikologis.

Selain mindfulness, pendekatan individual yang umum digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang bertujuan membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memperparah stres kerja (Gupta et al., 2021). Strategi lainnya meliputi latihan relaksasi progresif, teknik pernapasan dalam, aktivitas fisik teratur, manajemen waktu yang efektif, dan meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Pendekatan individual yang bersifat preventif ini dapat mengurangi risiko terjadinya burnout serta meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik tenaga medis (Jun et al., 2021).

3. Pendekatan Organisasi dalam Manajemen Stres

Pendekatan organisasi merupakan bagian integral dari manajemen stres yang berfokus pada kebijakan, lingkungan, dan sistem organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan tenaga medis. Pendekatan ini mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur kerja yang jelas, penyediaan sumber daya yang memadai, dukungan emosional dan sosial dari pimpinan serta rekan kerja, serta pelaksanaan program edukasi kesehatan mental secara berkala (Nowrouzi-Kia et al., 2022).

Menurut penelitian Shaukat et al. (2020), organisasi yang menerapkan strategi seperti jadwal kerja yang fleksibel, sistem rotasi tugas yang adil, penguatan tim kerja, serta penyediaan ruang konseling dan layanan psikologis secara signifikan berhasil mengurangi tingkat stres tenaga medis. Pendekatan organisasi juga mencakup budaya organisasi yang mendorong keterbukaan komunikasi dan umpan balik konstruktif, serta pelatihan kepemimpinan yang berorientasi pada dukungan psikologis karyawan (Rodriguez-Menéndez et al., 2021).

Organisasi yang secara aktif menerapkan pendekatan manajemen stres akan memperoleh manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas tenaga medis, pengurangan absensi, peningkatan kepuasan kerja, serta retensi karyawan yang lebih tinggi (Jun et al., 2021). Oleh karena itu, pendekatan organisasi perlu diintegrasikan dalam kebijakan strategis institusi kesehatan secara berkelanjutan.

D. Pentingnya Edukasi Manajemen Stres bagi Tenaga Medis

1. Manfaat Edukasi dalam Meningkatkan Kesadaran tentang Stres Kerja

Edukasi tentang manajemen stres bagi tenaga medis memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kesadaran individu terhadap stres yang dialami di lingkungan kerja. Kesadaran yang tinggi tentang stres memungkinkan tenaga medis mengenali secara dini gejala fisik, psikologis, dan perilaku yang muncul akibat tekanan kerja (Søvold et al., 2021). Melalui edukasi, tenaga medis juga memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor pemicu stres, termasuk tekanan pekerjaan, hubungan interpersonal, beban emosional dalam menghadapi pasien, serta tekanan administratif dan organisasi (Chen et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi secara signifikan meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam mengidentifikasi dan mengelola stres secara dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti burnout atau gangguan kesehatan mental lainnya (Pollock et al., 2020). Edukasi juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran organisasi akan pentingnya mendukung kesehatan mental dan emosional tenaga kerja melalui kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan (Cunningham & Çalışkan, 2022).

2. Peran Edukasi dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Strategies

Edukasi manajemen stres juga berperan krusial dalam memperkuat kemampuan coping strategies pada tenaga medis. Coping strategies merupakan keterampilan atau mekanisme yang digunakan oleh individu untuk menghadapi, mengurangi, atau mengelola tekanan akibat stres kerja (Labrague & De Los Santos, 2021). Melalui edukasi, tenaga medis diperkenalkan dengan berbagai teknik coping adaptif seperti mindfulness-based stress reduction (MBSR), cognitive behavioral therapy (CBT), teknik relaksasi, latihan pernapasan, serta manajemen waktu dan beban kerja secara efektif (Amanullah & Shankar, 2020).

Hasil studi oleh Labrague (2021) menunjukkan bahwa program edukasi berbasis CBT maupun mindfulness secara signifikan meningkatkan kemampuan coping tenaga medis, membantu mereka lebih efektif dalam menghadapi situasi stres tinggi seperti pandemi COVID-19. Edukasi juga memungkinkan tenaga medis mengurangi kecenderungan menggunakan coping maladaptif seperti isolasi sosial, konsumsi alkohol berlebihan, atau tindakan menghindar yang justru memperparah kondisi stres (Rosa et al., 2022).

3. Dampak Positif Edukasi terhadap Produktivitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Edukasi manajemen stres tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga medis serta kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Tenaga medis yang memiliki

kemampuan coping yang baik dan mampu mengelola stres secara efektif terbukti lebih mampu menjaga performa kerja, memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, serta menunjukkan penurunan absensi dan turnover (Labrague & De Los Santos, 2021; Nowrouzi-Kia et al., 2022).

Lebih lanjut, edukasi manajemen stres membantu tenaga medis dalam meningkatkan kualitas interaksi dengan pasien, menurunkan risiko kesalahan klinis, serta memperbaiki kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi tekanan tinggi (Pollock et al., 2020). Organisasi yang menginvestasikan sumber daya dalam edukasi manajemen stres juga menikmati peningkatan keselamatan pasien, kepuasan pasien yang lebih tinggi, serta reputasi yang lebih baik sebagai institusi yang peduli pada kesejahteraan tenaga medisnya (Jun et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi edukasi yang sistematis menjadi salah satu strategi utama yang perlu dikembangkan dalam lingkungan kerja medis.

E. Metode dan Teknik Edukasi Manajemen Stres

1. Teknik Mindfulness dan Meditasi

Mindfulness merupakan teknik psikologis yang bertujuan membantu individu fokus pada pengalaman di saat ini secara sadar tanpa penilaian negatif. Metode ini sering dikombinasikan dengan meditasi, yaitu praktik yang menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri melalui konsentrasi mendalam pada objek, sensasi tubuh, atau pernapasan (Sahmeddini et al., 2021). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa mindfulness dan meditasi secara signifikan mampu mengurangi stres, kecemasan, dan gejala burnout di kalangan tenaga medis (Ruotsalainen et al., 2020).

Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Ghawadra et al. (2020) melaporkan bahwa mindfulness secara efektif meningkatkan resiliensi psikologis, menurunkan tingkat stres kronis, serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan emosional pada tenaga kesehatan yang bekerja di bawah tekanan tinggi.

2. Pelatihan Relaksasi dan Pernapasan Dalam

Teknik relaksasi dan pernapasan dalam merupakan pendekatan sederhana namun efektif untuk mengelola stres. Metode ini membantu individu dalam meredakan ketegangan fisik dan mental melalui kontrol ritme pernapasan, yang berdampak langsung pada penurunan aktivitas sistem saraf simpatik dan peningkatan aktivitas sistem saraf parasimpatik (Wu et al., 2021).

Penelitian oleh Hopper et al. (2019) menunjukkan bahwa pelatihan relaksasi progresif yang dipadukan dengan teknik pernapasan dalam secara efektif menurunkan gejala stres, memperbaiki kualitas tidur, dan menurunkan tingkat kecemasan di kalangan tenaga medis. Teknik ini umumnya melibatkan latihan rutin, dengan sesi singkat tetapi konsisten, sehingga mudah diaplikasikan di lingkungan kerja medis yang padat aktivitas.

3. Pelatihan Coping Strategies Berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan pendekatan psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir negatif serta perilaku maladaptif dalam menghadapi stres. CBT membantu tenaga medis mengidentifikasi pemikiran yang menyebabkan kecemasan dan stres, kemudian menggantinya dengan pola pikir yang lebih adaptif (Pollock et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi CBT berbasis edukasi secara signifikan mengurangi tingkat burnout, stres kerja, serta meningkatkan kemampuan coping tenaga medis. Studi yang dilakukan oleh Liu et al. (2020) menegaskan bahwa tenaga medis yang menerima pelatihan CBT mampu mengelola stres dengan lebih baik dan menunjukkan peningkatan performa kerja, serta kesejahteraan psikologis jangka panjang.

4. Program Edukasi Kesehatan Mental secara Digital

Seiring kemajuan teknologi, program edukasi kesehatan mental berbasis digital menjadi semakin populer sebagai metode yang efektif dalam menjangkau tenaga medis di berbagai wilayah, terutama selama pandemi COVID-19. Metode ini meliputi aplikasi mobile, sesi pelatihan berbasis video online, platform konseling daring, serta modul edukasi interaktif (Amanullah & Shankar, 2020).

Menurut Frazier et al. (2021), edukasi digital efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pelatihan, memungkinkan fleksibilitas waktu bagi tenaga medis yang memiliki jadwal kerja yang padat, serta mampu menjangkau audiens yang luas dalam waktu relatif singkat. Program digital terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan resiliensi tenaga medis di masa-masa krisis kesehatan seperti pandemi (Chen et al., 2022).

F. Implementasi Program Edukasi Manajemen Stres di Tempat Kerja

1. Langkah-Langkah Perancangan Program Edukasi

Program edukasi manajemen stres bagi tenaga medis perlu dirancang secara sistematis dan terstruktur agar efektif mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Cunningham dan Çalışkan (2022), perancangan program edukasi dimulai dari analisis kebutuhan tenaga medis melalui survei atau wawancara mendalam guna mengidentifikasi tingkat stres, faktor penyebab, dan kebutuhan khusus peserta program. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan yang spesifik, terukur, realistis, dan memiliki batas waktu (SMART objectives).

Selanjutnya, pengembangan konten edukasi berdasarkan kebutuhan peserta sangat penting. Materi yang disusun mencakup teknik coping adaptif, strategi mindfulness, relaksasi, CBT, hingga metode digital jika relevan dengan kebutuhan institusi (Chen et al., 2022). Kemudian, langkah penting lainnya adalah menentukan metode dan media penyampaian edukasi, seperti workshop tatap muka, pelatihan daring, aplikasi digital, atau kombinasi dari metode tersebut (Frazier et al., 2021).

Tahapan akhir dari perancangan adalah perencanaan evaluasi dengan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, seperti penurunan tingkat stres, peningkatan kemampuan coping, kepuasan kerja, serta produktivitas peserta program (Pollock et al., 2020).

2. Strategi Implementasi yang Efektif di Lingkungan Kerja Medis

Implementasi program edukasi di lingkungan kerja medis menghadapi tantangan tersendiri, seperti jadwal kerja yang padat dan tingkat partisipasi tenaga medis yang bervariasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi implementasi yang efektif meliputi dukungan penuh dari pimpinan organisasi, integrasi pelatihan dengan jadwal kerja yang fleksibel, serta partisipasi aktif dari tenaga medis melalui metode pelatihan interaktif dan kolaboratif (Jun et al., 2021).

Studi oleh Labrague dan De Los Santos (2021) menunjukkan bahwa melibatkan pimpinan dan supervisor dalam pelatihan meningkatkan partisipasi peserta secara signifikan. Organisasi juga dianjurkan menyediakan insentif berupa sertifikat pelatihan, pengakuan profesional, maupun jam kerja yang disesuaikan agar tenaga medis lebih termotivasi mengikuti program edukasi (Nowrouzi-Kia et al., 2022).

Penerapan metode blended learning, yang mengombinasikan metode tatap muka dan daring, terbukti efektif dalam menjaga keterlibatan peserta sekaligus memberikan fleksibilitas waktu, sehingga lebih mudah diterapkan dalam lingkungan kerja medis yang sibuk (Frazier et al., 2021).

3. Evaluasi Efektivitas Program Edukasi Manajemen Stres

Evaluasi efektivitas merupakan komponen penting dalam implementasi program edukasi manajemen stres, yang bertujuan mengukur dampak dari pelatihan serta menentukan kebutuhan perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini dilakukan melalui metode kuantitatif seperti survei pre-post pelatihan, pengukuran tingkat stres menggunakan alat ukur baku seperti Perceived Stress Scale (PSS), serta indikator klinis seperti absensi dan laporan insiden kesalahan klinis (Chen et al., 2022; Pollock et al., 2020).

Selain itu, evaluasi kualitatif melalui wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD) juga penting untuk menggali umpan balik mendalam mengenai manfaat yang dirasakan, kendala implementasi, dan rekomendasi dari tenaga medis (Jun et al., 2021). Evaluasi secara berkala, misalnya setiap 3 atau 6 bulan setelah pelatihan, memberikan gambaran lebih akurat tentang dampak jangka panjang dari intervensi edukasi ini (Cunningham & Çalışkan, 2022).

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan konten edukasi, metode implementasi, serta upaya peningkatan dukungan organisasi terhadap kesehatan mental tenaga medis secara keseluruhan (Labrague & De Los Santos, 2021).

G. Studi Kasus Implementasi Program Edukasi Manajemen Stres

1. Studi Kasus di Rumah Sakit Umum

Implementasi program edukasi manajemen stres di rumah sakit umum telah dilakukan secara luas, terutama selama pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi psikologis tenaga kesehatan. Studi yang dilakukan di rumah sakit umum menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness, meditasi, dan pelatihan relaksasi progresif secara signifikan menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan burnout di kalangan perawat dan dokter (Frazier et al., 2021).

Penelitian oleh Blake et al. (2020) pada rumah sakit umum di Inggris melaporkan bahwa implementasi program berbasis digital dengan modul interaktif serta sesi konseling daring memberikan fleksibilitas tinggi, sehingga meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan. Hasilnya, 75% peserta melaporkan penurunan tingkat stres yang nyata serta peningkatan kesejahteraan psikologis dan kualitas pelayanan terhadap pasien.

2. Studi Kasus di Klinik atau Fasilitas Layanan Kesehatan Primer

Berbeda dengan rumah sakit besar, implementasi edukasi manajemen stres di klinik atau fasilitas layanan primer menghadapi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Studi kasus di layanan primer yang dilakukan oleh Cunningham dan Çalışkan (2022) mengungkapkan bahwa program edukasi berbasis komunitas dengan pelatihan singkat namun rutin setiap minggu berhasil meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam mengelola stres secara efektif.

Penelitian di klinik layanan primer di Amerika Serikat juga menekankan efektivitas pelatihan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam kelompok kecil. Dalam studi ini, tenaga medis diberikan pelatihan rutin selama 4 minggu yang berfokus pada teknik coping berbasis CBT. Hasilnya, tenaga medis menunjukkan peningkatan kemampuan coping, penurunan stres, dan peningkatan kualitas interaksi pasien (Liu et al., 2020).

3. Pelajaran dari Keberhasilan dan Tantangan dalam Implementasi Program

Implementasi program edukasi manajemen stres memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, keterlibatan aktif pimpinan dan supervisor sangat menentukan keberhasilan program. Dukungan pimpinan terbukti memperbesar tingkat partisipasi dan keberhasilan jangka panjang dari program edukasi stres di lingkungan kerja medis (Labrague & De Los Santos, 2021).

Kedua, fleksibilitas metode implementasi menjadi kunci keberhasilan, terutama di fasilitas layanan kesehatan dengan aktivitas padat. Program berbasis digital dan blended learning berhasil mengatasi keterbatasan waktu dan meningkatkan partisipasi tenaga medis dibandingkan pelatihan tatap muka yang rigid (Frazier et al., 2021).

Namun, beberapa tantangan juga ditemukan. Misalnya, studi oleh Pollock et al. (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran tenaga medis tentang manfaat manajemen stres dapat menurunkan minat dan partisipasi. Oleh karena itu, edukasi awal tentang pentingnya manajemen stres sebelum implementasi sangat diperlukan.

Selain itu, evaluasi program yang kurang konsisten juga menjadi kendala. Studi oleh Chen et al. (2022) merekomendasikan evaluasi yang terstruktur dan rutin sebagai bagian integral dari implementasi, guna memastikan efektivitas program secara berkelanjutan.

H. Tantangan dan Solusi dalam Edukasi Manajemen Stres bagi Tenaga Medis

1. Hambatan Umum dalam Pelaksanaan Edukasi

Implementasi program edukasi manajemen stres bagi tenaga medis sering menemui berbagai hambatan. Hambatan utama yang paling sering ditemukan adalah terbatasnya waktu akibat jadwal kerja yang padat, kurangnya kesadaran tenaga medis tentang pentingnya program ini, serta minimnya dukungan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan (Chen et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga medis cenderung menempatkan kebutuhan pasien di atas kebutuhan kesehatan pribadi, sehingga sulit bagi mereka mengalokasikan waktu untuk mengikuti edukasi stres (Jun et al., 2021).

Selain itu, stigma negatif terkait kesehatan mental dalam profesi medis juga menjadi hambatan signifikan. Banyak tenaga medis enggan berpartisipasi dalam program karena khawatir dianggap lemah atau tidak kompeten (Cunningham & Çalışkan, 2022). Rendahnya motivasi akibat kurangnya pemahaman mengenai manfaat edukasi juga seringkali menjadi kendala yang memperlambat partisipasi peserta dalam pelaksanaan program (Labrague & De Los Santos, 2021).

2. Strategi untuk Mengatasi Hambatan Edukasi di Tempat Kerja

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan efektif. Salah satu strategi utama adalah menciptakan dukungan manajerial yang kuat melalui advokasi aktif dari pimpinan organisasi, seperti memberikan waktu khusus selama jam kerja yang dialokasikan untuk edukasi manajemen stres (Nowrouzi-Kia et al., 2022). Dengan adanya dukungan eksplisit dari manajemen, tenaga medis akan merasa terdorong untuk berpartisipasi secara aktif tanpa khawatir meninggalkan kewajiban profesional.

Strategi lain yang efektif adalah penggunaan metode pelatihan fleksibel seperti blended learning yang menggabungkan pelatihan daring dan tatap muka, atau edukasi berbasis digital yang memungkinkan tenaga medis mengakses modul pelatihan kapan pun dan di mana pun (Frazier et al., 2021). Program digital yang dapat diakses melalui smartphone atau perangkat digital lainnya terbukti meningkatkan aksesibilitas serta mengurangi hambatan waktu dan tempat bagi tenaga medis yang sibuk (Chen et al., 2022).

Selain itu, untuk mengatasi stigma negatif, penting bagi institusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan terbuka terhadap kesehatan mental melalui kampanye internal, komunikasi efektif, serta contoh positif dari pimpinan mengenai pentingnya kesehatan mental dalam menjaga kualitas layanan (Pollock et al., 2020).

3. Rekomendasi Praktis untuk Meningkatkan Partisipasi Tenaga Medis dalam Edukasi

Untuk meningkatkan partisipasi tenaga medis dalam program edukasi manajemen stres, institusi kesehatan dapat menerapkan beberapa rekomendasi praktis berikut:

- a. **Memberikan insentif dan pengakuan profesional:** Institusi dapat memberikan sertifikat, poin kredit profesional, atau penghargaan khusus kepada tenaga medis yang mengikuti dan menyelesaikan program edukasi secara aktif. Penelitian menunjukkan bahwa insentif non-finansial seperti pengakuan profesional secara signifikan meningkatkan partisipasi tenaga medis dalam program edukasi (Jun et al., 2021).
- b. **Integrasi edukasi dalam rutinitas kerja:** Pelatihan manajemen stres yang disisipkan dalam rapat rutin, seminar, atau pelatihan wajib yang diadakan secara reguler, membantu tenaga medis terbiasa mengikuti edukasi tanpa mengganggu jadwal kerja yang ada (Cunningham & Çalışkan, 2022).
- c. **Kampanye edukasi internal berkelanjutan:** Kampanye internal yang berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi institusi, seperti email, newsletter, atau papan informasi elektronik, sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen stres, sekaligus meningkatkan minat tenaga medis untuk berpartisipasi dalam program (Labrague & De Los Santos, 2021).
- d. **Evaluasi berkelanjutan:** Institusi perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas program dan mendengarkan umpan balik tenaga medis, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut (Pollock et al., 2020). Evaluasi yang transparan dan partisipatif akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga medis dalam edukasi manajemen stres.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi Manajemen Stres

Stres kerja pada tenaga medis telah menjadi isu penting dalam pelayanan kesehatan, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan fisik, psikologis, serta kualitas pelayanan pasien. Edukasi manajemen stres merupakan strategi vital untuk membantu tenaga medis mengenali tanda-tanda stres sejak dini, meningkatkan kemampuan coping strategies secara efektif, serta mengurangi dampak negatif stres kronis seperti burnout dan gangguan kesehatan mental lainnya (Labrague & De Los Santos, 2021; Chen et al., 2022).

Melalui edukasi terstruktur, tenaga medis tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan pribadi tetapi juga berdampak positif pada organisasi, yang tercermin dari peningkatan produktivitas, kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta menurunnya turnover dan absensi di tempat kerja (Jun et al., 2021). Dengan demikian, edukasi manajemen stres seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam institusi kesehatan.

2. Rekomendasi untuk Institusi Kesehatan dalam Mengembangkan Program Edukasi Manajemen Stres yang Berkelanjutan

Berdasarkan berbagai kajian terkini, beberapa rekomendasi penting bagi institusi kesehatan dalam mengembangkan program edukasi manajemen stres yang efektif dan berkelanjutan antara lain:

- a. **Integrasi dalam Kebijakan Institusional:** Edukasi manajemen stres harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan tenaga kerja di institusi kesehatan. Program ini perlu diintegrasikan dalam agenda institusi dengan dukungan jelas dari pimpinan serta alokasi sumber daya yang memadai (Cunningham & Çalışkan, 2022).
- b. **Pengembangan Program Berbasis Kebutuhan:** Institusi perlu melakukan asesmen rutin untuk mengidentifikasi tingkat stres, kebutuhan spesifik, serta preferensi tenaga medis terhadap metode edukasi. Dengan pendekatan ini, institusi mampu merancang program yang relevan dan efektif (Frazier et al., 2021).
- c. **Fleksibilitas dan Inovasi:** Institusi dianjurkan mengadopsi metode edukasi yang fleksibel, seperti blended learning atau digital-based learning yang dapat diakses secara luas oleh tenaga medis dengan jadwal yang padat (Chen et al., 2022). Program edukasi daring atau hybrid mampu menjawab tantangan keterbatasan waktu dan lokasi.
- d. **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Evaluasi rutin harus dilakukan untuk menilai efektivitas program secara berkala. Hasil evaluasi harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan agar program edukasi tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan tenaga medis (Pollock et al., 2020).

3. Implikasi Masa Depan dalam Penelitian dan Praktik Kesehatan Kerja

Dalam konteks penelitian dan praktik di masa depan, beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan adalah:

- a. **Penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas intervensi digital:** Dengan semakin luasnya penerapan teknologi digital dalam dunia kesehatan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas berbagai platform digital dalam meningkatkan kesejahteraan mental tenaga medis (Frazier et al., 2021).
- b. **Pengembangan program yang berorientasi pada pencegahan stres:** Penelitian ke depan hendaknya lebih banyak menitikberatkan pada strategi pencegahan primer untuk mencegah stres berkembang menjadi gangguan kesehatan yang serius seperti burnout atau gangguan mental lainnya (Labrague & De Los Santos, 2021).
- c. **Evaluasi dampak jangka panjang edukasi manajemen stres:** Penelitian di masa mendatang perlu berfokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari program edukasi yang sudah diterapkan. Evaluasi longitudinal ini penting untuk memahami efektivitas program dalam mengelola stres dalam jangka waktu lama (Nowrouzi-Kia et al., 2022).
- d. **Peningkatan kolaborasi interprofesional dalam manajemen stres:** Institusi kesehatan perlu memperkuat kolaborasi antar disiplin ilmu seperti psikologi, keperawatan, dan kedokteran dalam pengembangan serta implementasi program edukasi manajemen stres, guna meningkatkan efektivitas dan dampak program secara keseluruhan (Cunningham & Çalışkan, 2022).

Dengan memperhatikan rekomendasi dan implikasi di atas, institusi kesehatan dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan tenaga medis, yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan secara umum.

J. Penutup

Stres yang dialami oleh tenaga medis merupakan tantangan yang nyata dan perlu mendapat perhatian serius dalam praktik kesehatan. Kondisi stres yang kronis tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental tenaga medis, tetapi juga secara signifikan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien (Chen et al., 2022). Oleh karena itu, implementasi program edukasi manajemen stres yang efektif di tempat kerja sangat penting untuk diterapkan secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian terbaru telah menegaskan pentingnya edukasi manajemen stres dalam meningkatkan kemampuan tenaga medis mengidentifikasi stres lebih dini, mengembangkan kemampuan coping strategies yang adaptif, serta meningkatkan resiliensi psikologis dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

(Labrague & De Los Santos, 2021; Jun et al., 2021). Edukasi yang dilakukan secara rutin dan terintegrasi dalam kebijakan institusi mampu memberikan dampak positif secara jangka panjang, baik terhadap individu maupun organisasi.

Dalam praktiknya, institusi kesehatan harus terus mengembangkan dan mengevaluasi program edukasi yang relevan, adaptif terhadap kebutuhan tenaga medis, serta memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk mengatasi tantangan implementasi seperti keterbatasan waktu dan sumber daya (Frazier et al., 2021). Upaya kolaboratif antar profesi dan disiplin ilmu juga penting untuk memperkuat efektivitas program edukasi manajemen stres.

Sebagai langkah ke depan, penelitian lebih lanjut tentang metode edukasi yang paling efektif serta evaluasi dampak jangka panjang program edukasi sangat diperlukan untuk terus memperbaiki kualitas praktik manajemen stres di lingkungan kerja medis (Nowrouzi-Kia et al., 2022). Dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kualitas hidup tenaga medis dan kualitas pelayanan kesehatan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Akhirnya, semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat bagi para tenaga medis, praktisi kesehatan, peneliti, serta pengambil kebijakan untuk terus berinovasi dan peduli terhadap pentingnya pengelolaan stres di tempat kerja dalam menciptakan lingkungan kerja medis yang lebih sehat, produktif, dan humanis.

Referensi

- Amanullah, S., & Shankar, R. R. (2020). The impact of COVID-19 on physician burnout globally: A review. *Healthcare*, 8(4), 421. <https://doi.org/10.3390/healthcare8040421>
- Blake, H., Bermingham, F., Johnson, G., & Tabner, A. (2020). Mitigating the psychological impact of COVID-19 on healthcare workers: A digital learning package. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 2997. <https://doi.org/10.3390/ijerph17092997>
- Chen, H., Liu, F., Pang, L., Liu, F., Fang, T., Wen, Y., & Zhang, X. (2022). Mental health and stress management among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *Frontiers in Public Health*, 10, 849878. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.849878>
- Cunningham, T., & Çalışkan, S. (2022). Workplace interventions for reducing occupational stress in healthcare professionals: A systematic review. *Occupational Medicine*, 72(4), 205–213. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqac043>
- Frazier, P., Meredith, L., Greer, C., Paulsen, J. A., Howard, K., Dietz, L. R., & Qin, K. (2021). Randomized controlled trial evaluating the effectiveness of a web-based stress management program among healthcare workers during COVID-19. *Journal of Occupational Health Psychology*, 26(6), 534–545. <https://doi.org/10.1037/ocp0000304>
- Ghawadra, S. F., Abdullah, K. L., Choo, W. Y., & Phang, C. K. (2020). Mindfulness-based stress reduction for psychological distress among nurses: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 29(21-22), 3747–3758. <https://doi.org/10.1111/jocn.15496>
- Gupta, S., Sahoo, S., Mehra, A., & Grover, S. (2021). Psychological impact of COVID-19 pandemic on healthcare workers in India & their perceptions on the way forward—a qualitative study. *Indian Journal of Medical Research*, 153(5-6), 637–648. https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_2206_20
- Hopper, S. I., Murray, S. L., & Ferrara, L. R. (2019). Relaxation training with deep breathing exercises to reduce perceived stress in healthcare professionals. *Journal of Nursing Education and Practice*, 9(3), 43–49. <https://doi.org/10.5430/jnep.v9n3p43>
- Jun, J., Tucker, S., & Melnyk, B. M. (2021). Clinician mental health and well-being during global healthcare crises: Evidence learned from prior epidemics for COVID-19 pandemic. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 18(3), 182–184. <https://doi.org/10.1111/wvn.12521>

- Labrague, L. J. (2021). Psychological resilience, coping behaviors, and social support among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review of quantitative studies. *International Journal of Nursing Studies*, 121, 103953. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103953>
- Labrague, L. J., & De Los Santos, J. A. A. (2021). Fear of COVID-19, psychological distress, work satisfaction and turnover intention among frontline nurses. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 395–403. <https://doi.org/10.1111/jonm.13168>
- Liu, Z., Qiao, D., Xu, Y., Zhao, W., Yang, Y., Wen, D., & Li, X. (2020). The efficacy of cognitive behavioral therapy in healthcare workers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 129, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.06.003>
- Nowrouzi-Kia, B., Sithamparanathan, G., & Tan, X. (2022). Factors associated with work performance and mental health of healthcare workers during pandemics: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational Health*, 64(1), e12334. <https://doi.org/10.1002/1348-9585.12334>
- Pollock, A., Campbell, P., Cheyne, J., Cowie, J., Davis, B., & McCallum, J. (2020). Interventions to support the resilience and mental health of frontline health and social care professionals during and after a disease outbreak: A rapid review. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(11), CD013779.
- Rodriguez-Menéndez, M. C., López-Gómez, A., Fernández-Carnero, J., & Ruiz-Gómez, A. (2021). Burnout syndrome in healthcare workers during COVID-19 pandemic: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 12, 709209. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709209>
- Ruotsalainen, J. H., Verbeek, J. H., Mariné, A., & Serra, C. (2020). Preventing occupational stress in healthcare workers. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(4), CD002892.
- Sahmeddini, M. A., Ardakani, H. B., Rezaei, Z., & Javadpour, S. (2021). The effect of mindfulness-based stress reduction on burnout syndrome among nurses. *BMC Nursing*, 20(1), 89. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00603-1>
- Shaukat, N., Ali, D. M., & Razzak, J. (2020). Physical and mental health impacts of COVID-19 on healthcare workers: A scoping review. *International Journal of Emergency Medicine*, 13(1), 40.
- Søvold, L. E., Naslund, J. A., Kousoulis, A. A., Saxena, S., Qoronfleh, M. W., Grobler, C., & Münter, L. (2021). Prioritizing the mental health and well-being of healthcare workers: an urgent global public health priority. *Frontiers in Public Health*, 9, 679397.

- Wu, W., Zhang, Y., Wang, P., Zhang, L., Wang, G., Lei, G., & Xiao, Q. (2021). Psychological stress of medical staffs during outbreak of COVID-19 and adjustment strategy. *Journal of Medical Virology*, 92(10), 1962-1970.
- World Health Organization. (2021). *Mental Health and Psychosocial Considerations during COVID-19 Outbreak*. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1>

BAB III

STRATEGI BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Konsep Kesehatan Mental dalam Komunitas Medis

Kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan psikologis dan emosional individu, di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta berkontribusi positif pada komunitasnya (World Health Organization [WHO], 2022). Dalam konteks komunitas medis, kesehatan mental memiliki dimensi khusus yang mencerminkan kompleksitas lingkungan kerja tenaga medis, seperti tekanan psikologis akibat tingginya tanggung jawab profesional, beban kerja, serta interaksi intens dengan penderitaan pasien (Labrague & De Los Santos, 2021).

Komunitas medis mencakup semua profesional kesehatan yang bekerja dalam institusi kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kesehatan mental di kalangan tenaga medis tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mencakup lingkungan kerja, kebijakan institusi, dukungan sosial, serta budaya organisasi (Tiete et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis yang mengalami gangguan kesehatan mental berisiko tinggi mengalami burnout, depresi, kecemasan, serta menurunnya kinerja profesional yang berakibat langsung terhadap kualitas pelayanan pasien (Greenberg et al., 2021; Liao et al., 2023). Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental tenaga medis tidak hanya penting bagi kesejahteraan individu tetapi juga bagi kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

2. Pentingnya Strategi Berbasis Komunitas dalam Pengelolaan Stres Tenaga Medis

Strategi berbasis komunitas adalah pendekatan yang melibatkan seluruh elemen dalam komunitas medis untuk mendukung pengelolaan stres dan kesehatan mental tenaga medis. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama kolektif, dukungan sosial yang kuat, serta kolaborasi interprofesional dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis (Billings et al., 2021).

Penerapan strategi berbasis komunitas di lingkungan medis menjadi krusial karena tenaga medis tidak hanya membutuhkan pendekatan individu, tetapi juga dukungan sosial dan sistemik yang luas. Misalnya, kelompok dukungan sebaya (peer support groups) terbukti efektif dalam mengurangi stres, meningkatkan ketahanan mental, serta memfasilitasi berbagi pengalaman dan strategi coping (Petrella et al., 2021). Demikian pula, program pelatihan berbasis komunitas seperti mindfulness, pengelolaan stres berbasis kelompok, dan pelatihan komunikasi efektif juga telah menunjukkan manfaat signifikan dalam mengurangi tekanan mental tenaga medis (An et al., 2022).

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas memungkinkan identifikasi dan intervensi dini terhadap stres melalui monitoring berkelanjutan oleh komunitas profesional kesehatan itu sendiri. Kondisi ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang proaktif dalam menjaga kesehatan mental anggotanya, mengurangi stigma terhadap isu kesehatan mental, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis jangka panjang (Afulani et al., 2021).

Secara keseluruhan, penerapan strategi berbasis komunitas tidak hanya berdampak positif terhadap individu tetapi juga membangun sistem dukungan sosial yang kuat, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan mental komunitas medis dalam menghadapi berbagai tantangan kerja sehari-hari.

B. Identifikasi Dan Penilaian Kebutuhan Komunitas Medis

1. Metode Penilaian Kebutuhan Komunitas Terkait Kesehatan Mental

Penilaian kebutuhan komunitas (Community Needs Assessment/CNA) adalah langkah mendasar dalam mengembangkan program berbasis komunitas, khususnya dalam bidang kesehatan mental. Dalam konteks komunitas medis, CNA melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi secara sistematis untuk memahami kondisi, kebutuhan, serta prioritas tenaga medis terkait kesehatan mental (Kang et al., 2020).

Metode penilaian kebutuhan yang umum digunakan meliputi survei, wawancara mendalam (in-depth interviews), diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussions/FGDs), serta analisis data sekunder yang mencakup laporan internal rumah sakit, rekam medis tenaga medis, dan laporan insiden stres kerja (Patel & Saxena, 2022). Survei berbasis kuantitatif sering digunakan karena mampu menjangkau populasi besar dan memberikan gambaran umum terkait tingkat stres, kecemasan, dan burnout dalam komunitas medis. Instrumen standar yang biasa digunakan antara lain Maslach Burnout Inventory (MBI), Perceived Stress Scale (PSS), serta General Health Questionnaire (GHQ-12) (Luo et al., 2022).

Sementara itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara dan FGD penting untuk memahami persepsi mendalam, faktor penyebab, serta kebutuhan spesifik yang tidak terungkap dalam survei kuantitatif (Arnetz et al., 2021). Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif ini menghasilkan data komprehensif yang berguna dalam perencanaan strategi intervensi yang efektif dan berbasis bukti.

2. Faktor-Faktor Risiko dan Protektif terhadap Stres pada Tenaga Medis

Dalam penilaian kebutuhan komunitas medis, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko maupun protektif terkait stres kerja tenaga medis. Faktor-faktor risiko adalah kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan peluang tenaga medis mengalami stres yang tinggi. Beberapa faktor risiko utama mencakup beban kerja berlebihan, jam kerja yang panjang, konflik peran, kurangnya dukungan organisasi, rendahnya penghargaan dari lingkungan kerja, serta pengalaman traumatis, seperti kematian pasien secara tiba-tiba atau kejadian kritis lainnya (Greenberg et al., 2021; Labrague & De Los Santos, 2021).

Penelitian terkini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan terkait dengan peningkatan risiko burnout, kecemasan, depresi, serta penurunan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis (Liao et al., 2023). Situasi pandemi COVID-19 secara khusus meningkatkan intensitas faktor risiko tersebut, dengan tekanan psikologis tambahan akibat rasa takut tertular penyakit, isolasi sosial, dan ketidakpastian pekerjaan (Billings et al., 2021).

Sebaliknya, faktor-faktor protektif memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan mental tenaga medis. Faktor protektif mencakup adanya dukungan sosial yang kuat dari kolega, keluarga, dan pimpinan organisasi, akses terhadap program kesehatan mental, kemampuan coping yang baik, pelatihan reguler mengenai manajemen stres, serta lingkungan kerja yang mempromosikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional (Søvold et al., 2021; Lasalvia et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis yang mendapatkan dukungan sosial dan organisasi secara aktif memiliki risiko lebih rendah mengalami stres berat dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan dukungan tersebut (Petrella et al., 2021). Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan protektif ini, komunitas medis dapat merancang intervensi yang tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan untuk mendukung kesehatan mental para anggotanya.

C. Pengembangan Strategi Berbasis Komunitas

1. Perencanaan Program Kesehatan Mental Berbasis Komunitas

Perencanaan program kesehatan mental berbasis komunitas di lingkungan tenaga medis memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan komunitas, penentuan tujuan dan sasaran program, pemilihan strategi intervensi yang tepat, serta penetapan indikator evaluasi yang jelas (Rajamohan et al., 2022). Menurut penelitian terbaru, perencanaan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari anggota komunitas sejak tahap awal, untuk memastikan bahwa intervensi dirancang sesuai kebutuhan spesifik tenaga medis dan mendapat dukungan kuat dari seluruh komunitas kerja (Billings et al., 2021).

Tahap-tahap penting dalam perencanaan ini antara lain adalah menentukan prioritas masalah kesehatan mental, mengembangkan intervensi yang feasible dan berbasis bukti, serta memastikan dukungan organisasi dan sumber daya yang memadai (World Health Organization [WHO], 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa program yang berhasil adalah program yang secara jelas mengintegrasikan strategi dukungan sosial seperti peer-support groups, program pelatihan keterampilan coping, serta penyediaan layanan konseling psikologis secara rutin bagi tenaga medis (Lasalvia et al., 2021).

2. Kolaborasi Interprofesional dalam Pelaksanaan Program Komunitas

Kolaborasi interprofesional adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program kesehatan mental berbasis komunitas. Kolaborasi ini melibatkan berbagai profesi dalam bidang kesehatan, seperti perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan administrator rumah sakit, dalam sebuah tim terpadu untuk mendukung pelaksanaan intervensi secara efektif (Liao et al., 2023). Studi terbaru menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya meningkatkan efektivitas intervensi tetapi juga memperkuat solidaritas, komunikasi, dan rasa tanggung jawab bersama di antara tenaga medis (Arnetz et al., 2021).

Untuk mewujudkan kolaborasi interprofesional yang efektif, diperlukan komunikasi terbuka, pembagian peran yang jelas, serta pelatihan interprofesional secara reguler untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang tantangan kesehatan mental yang dihadapi tenaga medis (Petrella et al., 2021). Studi juga menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional mampu mengatasi hambatan struktural dan budaya dalam implementasi strategi kesehatan mental, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan dampak positif program (Billings et al., 2021).

3. Contoh Program Sukses dari Berbagai Negara

Berbagai negara telah sukses mengimplementasikan program kesehatan mental berbasis komunitas bagi tenaga medis dengan hasil yang signifikan.

Sebagai contoh, Inggris menerapkan program berbasis komunitas bernama "NHS Practitioner Health Programme," yang menawarkan layanan dukungan psikologis terpadu bagi tenaga medis dengan memanfaatkan pendekatan kolaboratif dan interprofesional. Program ini terbukti berhasil mengurangi stres, kecemasan, dan depresi secara signifikan di kalangan tenaga medis, terutama selama pandemi COVID-19 (Greenberg et al., 2021).

Di Amerika Serikat, program "Schwartz Rounds" yang berfokus pada sesi refleksi dan dukungan emosional kelompok secara rutin juga menunjukkan dampak positif. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa program ini mampu menurunkan tingkat burnout, meningkatkan empati di antara tenaga medis, serta menciptakan budaya dukungan yang kuat dalam institusi kesehatan (Taylor et al., 2022).

Sementara itu, di Australia, program intervensi mindfulness berbasis komunitas medis telah berhasil mengurangi gejala stres kronis di kalangan perawat dan tenaga kesehatan. Program ini menunjukkan bahwa integrasi intervensi berbasis mindfulness dalam jadwal kerja rutin dapat memberikan manfaat jangka panjang terhadap kesehatan mental tenaga medis, termasuk menurunkan risiko gangguan psikologis serius (An et al., 2022).

Studi-studi ini menegaskan bahwa keberhasilan program berbasis komunitas sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif komunitas, kolaborasi interprofesional, serta dukungan organisasi dan kebijakan kesehatan yang kondusif.

D. Implementasi Strategi Pendukung Kesehatan Mental

1. Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik

Implementasi pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik menjadi langkah penting dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis di lingkungan kerja. Tenaga medis yang terampil berkomunikasi mampu membangun hubungan yang harmonis, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan efisiensi kerja (Rosen et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi efektif secara signifikan menurunkan tingkat stres, konflik interpersonal, serta burnout pada tenaga medis, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Fernandez et al., 2020).

Selain keterampilan komunikasi, manajemen konflik juga menjadi aspek penting dalam mendukung kesehatan mental. Pelatihan manajemen konflik bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam mengenali, mengelola, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif, sehingga mencegah dampak negatif konflik terhadap kesehatan mental (Alsalamah et al., 2021). Studi

menunjukkan bahwa tenaga medis yang mengikuti pelatihan ini cenderung memiliki tingkat ketahanan psikologis yang lebih baik dan mampu menghadapi stres dengan lebih efektif (Ghafoor et al., 2021).

2. Program Dukungan Kelompok (Support Groups) di Lingkungan Kerja

Program dukungan kelompok atau *support groups* merupakan pendekatan efektif yang banyak diterapkan dalam komunitas medis untuk mengatasi stres kerja. Program ini menyediakan ruang aman bagi tenaga medis untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan emosional, serta mendapatkan dukungan emosional dan psikososial dari sesama rekan kerja (Petrella et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam kelompok dukungan sebaya secara konsisten berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, penurunan gejala depresi, kecemasan, serta risiko burnout pada tenaga medis (Billings et al., 2021). Di samping itu, kelompok dukungan ini mampu menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggota komunitas medis, sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan saling mendukung (Greenberg et al., 2021).

Kesuksesan program dukungan kelompok sangat bergantung pada konsistensi pertemuan, fasilitasi yang tepat, serta keterlibatan aktif dari seluruh anggota. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan sumber daya yang cukup, pelatihan bagi fasilitator kelompok, serta menciptakan budaya organisasi yang mendorong partisipasi aktif dalam aktivitas tersebut (Shapiro & Galowitz, 2021).

3. Aktivitas Komunitas yang Mendukung Relaksasi dan Mindfulness

Aktivitas komunitas yang berfokus pada relaksasi dan *mindfulness* semakin diakui manfaatnya dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis. Mindfulness adalah praktik melatih kesadaran penuh pada momen saat ini secara non-judgmental, yang terbukti efektif dalam mengurangi stres, meningkatkan fokus, serta memperbaiki kesejahteraan mental secara keseluruhan (An et al., 2022).

Implementasi kegiatan mindfulness berbasis komunitas seperti yoga, meditasi kelompok, latihan pernapasan dalam, serta terapi musik telah menunjukkan hasil positif di berbagai studi terkini. Misalnya, program meditasi mindfulness yang diadakan secara rutin di rumah sakit terbukti mampu menurunkan gejala kecemasan, depresi, serta burnout pada tenaga medis secara signifikan (Antonova et al., 2021).

Selain itu, aktivitas relaksasi lainnya seperti seni kreatif, terapi seni, dan kegiatan fisik ringan berbasis komunitas juga memberikan dampak positif. Kegiatan tersebut tidak hanya mengurangi ketegangan emosional tetapi juga mendorong interaksi sosial yang memperkuat dukungan sosial di antara tenaga medis (Rushton et al., 2021). Dalam implementasi praktisnya, organisasi perlu menjadwalkan aktivitas ini secara rutin serta memastikan akses yang mudah bagi tenaga medis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

E. Peran Dan Dukungan Kolega Dalam Komunitas Medis

1. Pentingnya Dukungan Sosial dari Kolega

Dukungan sosial dari kolega merupakan aspek vital dalam menjaga kesehatan mental tenaga medis, terutama dalam menghadapi lingkungan kerja yang penuh tekanan dan risiko tinggi. Dukungan sosial kolega merujuk pada interaksi positif, saling pengertian, dan pemberian bantuan emosional, informasi, serta praktis antar sesama tenaga medis (Tiete et al., 2020). Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa dukungan kolega mampu menurunkan tingkat stres, meningkatkan resiliensi, dan mengurangi risiko burnout di kalangan tenaga medis (Billings et al., 2021).

Menurut Labrague dan De Los Santos (2021), dukungan kolega yang tinggi secara signifikan berhubungan dengan penurunan kecemasan dan depresi, serta mampu membantu tenaga medis menghadapi tantangan emosional dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Kolega dapat menjadi sumber kekuatan emosional melalui diskusi terbuka tentang kesulitan yang dihadapi, sehingga mengurangi rasa terisolasi dan meningkatkan rasa percaya diri serta kesejahteraan mental (Greenberg et al., 2021).

2. Strategi Meningkatkan Solidaritas dan Rasa Kebersamaan

Solidaritas dan rasa kebersamaan dalam komunitas medis memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Strategi yang efektif untuk meningkatkan solidaritas di antaranya adalah melalui kegiatan rutin yang mempererat hubungan interpersonal, seperti pertemuan sosial informal, sesi refleksi bersama, maupun kegiatan kerja sama tim yang intensif (Fernandez et al., 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa institusi kesehatan yang rutin mengadakan kegiatan berbasis tim, seperti lokakarya kolaborasi interprofesional dan sesi reflektif seperti Schwartz Rounds, mampu menciptakan budaya kerja yang lebih empatik, kolaboratif, dan saling menghargai antar kolega (Taylor et al., 2022). Selain itu, kepemimpinan yang partisipatif dan budaya organisasi yang

mendukung komunikasi terbuka juga terbukti efektif dalam memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan (Ghafoor et al., 2021).

Pendekatan lain, seperti aktivitas komunitas informal berupa rekreasi bersama, olahraga bersama, serta pelatihan tim juga efektif dalam memperkuat ikatan sosial antar kolega, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kesehatan mental secara keseluruhan (Rushton et al., 2021).

3. Efektivitas Pendekatan Peer Support untuk Mengurangi Stres

Pendekatan dukungan sebaya (*peer support*) menjadi salah satu strategi intervensi yang paling efektif dalam mengurangi stres pada tenaga medis. Dukungan sebaya adalah pendekatan di mana tenaga medis yang memiliki latar belakang pengalaman serupa saling memberikan dukungan emosional, berbagi strategi coping, serta mendiskusikan tantangan secara terbuka dalam lingkungan yang aman dan suportif (Petrella et al., 2021).

Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa program peer support mampu secara signifikan mengurangi gejala stres, kecemasan, depresi, dan burnout di kalangan tenaga medis (Billings et al., 2021; Greenberg et al., 2021). Program ini efektif karena memungkinkan tenaga medis mendapatkan validasi terhadap perasaan mereka, serta belajar strategi efektif dari kolega yang telah mengalami situasi serupa.

Studi oleh Shapiro dan Galowitz (2021) mengindikasikan bahwa peer support tidak hanya memberikan manfaat secara individual tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih resilien dan terbuka terhadap diskusi tentang kesehatan mental. Efektivitas pendekatan ini meningkat secara signifikan jika didukung oleh fasilitator terlatih, struktur pertemuan yang rutin, serta dukungan institusional yang kuat.

F. Pemanfaatan Teknologi Dalam Strategi Komunitas

1. Platform Digital sebagai Sarana Dukungan Psikososial

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis melalui pemanfaatan platform digital. Platform ini dapat berupa aplikasi mobile, situs web interaktif, maupun media sosial khusus yang didesain untuk menyediakan dukungan psikososial secara virtual. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform digital memungkinkan tenaga medis mendapatkan akses mudah dan cepat terhadap layanan konseling online, sumber daya psikologis, serta interaksi sosial dengan rekan-rekan yang menghadapi tantangan serupa (Lai et al., 2020).

Contoh konkret platform digital yang efektif adalah aplikasi mobile yang menyediakan latihan mindfulness, manajemen stres berbasis kognitif, dan akses kepada terapis virtual. Penelitian oleh De Kock et al. (2021) mengungkapkan bahwa aplikasi digital ini mampu mengurangi gejala stres akut, kecemasan, dan depresi pada tenaga medis secara signifikan, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Selain itu, fitur komunitas virtual dalam platform digital juga mampu meningkatkan dukungan sosial antar kolega, menciptakan ruang interaksi positif, serta memperkuat hubungan interpersonal (Søvold et al., 2021).

2. Telehealth untuk Dukungan Kesehatan Mental bagi Tenaga Medis

Telehealth merupakan pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan mental secara jarak jauh, seperti konsultasi psikologis daring, terapi virtual, dan pemantauan kondisi psikologis melalui video call atau platform konferensi video (Smith et al., 2022). Dalam konteks tenaga medis, telehealth menjadi sangat relevan karena memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan mental, mengatasi hambatan waktu, jarak, serta stigma sosial yang masih sering dijumpai dalam lingkungan kerja medis (Greenhalgh et al., 2020).

Hasil studi terkini menunjukkan bahwa telehealth tidak hanya efektif dalam memberikan dukungan psikologis tetapi juga mampu mengurangi tingkat stres, meningkatkan ketahanan mental, serta mempercepat pemulihan tenaga medis yang mengalami gangguan mental ringan hingga sedang (Békés & Doorn, 2020). Telehealth juga memfasilitasi pemberian intervensi berbasis bukti seperti terapi kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/CBT), terapi mindfulness, serta sesi dukungan kelompok secara daring yang terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi di kalangan tenaga medis (Antonova et al., 2021).

3. Studi Kasus Pemanfaatan Teknologi dalam Komunitas Medis

Implementasi teknologi dalam komunitas medis telah dibuktikan melalui beberapa studi kasus sukses di berbagai negara. Salah satunya adalah program "Virtual Support Forum" yang dikembangkan oleh National Health Service (NHS) di Inggris selama pandemi COVID-19. Program ini menyediakan ruang daring khusus bagi tenaga medis untuk mendiskusikan tantangan psikologis, berbagi strategi coping, serta mendapatkan bimbingan psikolog secara virtual. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa forum ini efektif dalam mengurangi tingkat burnout dan meningkatkan kesejahteraan mental tenaga medis yang berpartisipasi (Greenberg et al., 2021).

Studi kasus lain berasal dari Amerika Serikat, di mana aplikasi mobile bernama "COVID Coach" dikembangkan untuk memberikan latihan relaksasi, manajemen stres, dan sumber daya psikososial khusus bagi tenaga medis yang menghadapi tekanan kerja tinggi selama pandemi. Aplikasi ini terbukti secara efektif menurunkan stres, meningkatkan coping skills, serta memperkuat dukungan sosial melalui interaksi komunitas virtual (Possemato et al., 2022).

Di Australia, pemanfaatan telehealth melalui platform khusus yang menyediakan layanan terapi psikologis daring kepada tenaga medis berhasil meningkatkan akses dan partisipasi tenaga medis dalam program kesehatan mental. Studi menunjukkan bahwa platform ini secara signifikan membantu menurunkan tingkat depresi dan kecemasan tenaga medis, serta memberikan efek positif jangka panjang pada kesehatan mental mereka (Smith et al., 2022).

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam komunitas medis bukan hanya merupakan alternatif, tetapi sebuah kebutuhan strategis yang efektif dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis.

G. Evaluasi Dan Monitoring Program Komunitas

1. Metode Evaluasi Keberhasilan Strategi Berbasis Komunitas

Evaluasi adalah langkah penting dalam menilai efektivitas dan dampak program kesehatan mental berbasis komunitas di lingkungan medis. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan program tercapai, mengidentifikasi hambatan, serta memberikan informasi untuk perbaikan program (Kumar et al., 2021). Metode evaluasi yang umum digunakan mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta metode campuran (*mixed methods*).

Metode kuantitatif biasanya melibatkan survei sebelum dan sesudah implementasi program menggunakan instrumen baku seperti *Maslach Burnout Inventory (MBI)*, *General Health Questionnaire (GHQ)*, atau *Perceived Stress Scale (PSS)* untuk menilai tingkat stres, burnout, serta kesejahteraan mental tenaga medis (Johnson et al., 2020). Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussions*) juga diterapkan untuk menggali persepsi dan pengalaman peserta secara lebih mendalam (Rajamohan et al., 2022).

Studi terbaru merekomendasikan pendekatan evaluasi metode campuran karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan program dari perspektif kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada angka-angka tetapi juga pada perubahan perilakunya dan pengalaman nyata para tenaga medis (Billings et al., 2021).

2. Indikator Keberhasilan Program Kesehatan Mental

Penetapan indikator keberhasilan merupakan langkah esensial dalam proses evaluasi program komunitas. Indikator ini harus relevan, terukur, dan mencerminkan tujuan utama program. Beberapa indikator yang sering digunakan dalam evaluasi program kesehatan mental di lingkungan medis adalah penurunan tingkat burnout, stres, kecemasan, dan depresi, serta peningkatan resiliensi, kepuasan kerja, dan kesejahteraan mental secara umum (Greenberg et al., 2021).

Selain indikator klinis dan psikologis, indikator lain yang penting adalah peningkatan partisipasi aktif tenaga medis dalam program komunitas, peningkatan dukungan sosial antar kolega, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan coping terhadap stres di tempat kerja (Lasalvia et al., 2021). Penelitian terkini menegaskan bahwa penggunaan indikator yang jelas dan spesifik secara signifikan meningkatkan akurasi evaluasi dan efektivitas intervensi berbasis komunitas dalam jangka panjang (Smith et al., 2022).

3. Tantangan dan Solusi dalam Evaluasi Program Komunitas

Evaluasi program berbasis komunitas dalam lingkungan medis menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan utama meliputi rendahnya tingkat partisipasi dalam survei atau wawancara evaluasi, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta resistensi atau stigma di kalangan tenaga medis terkait isu kesehatan mental (Kumar et al., 2021). Selain itu, sulitnya mengisolasi efek dari program tertentu terhadap perubahan kondisi kesehatan mental juga merupakan tantangan metodologis yang umum dihadapi (Johnson et al., 2020).

Solusi untuk mengatasi tantangan ini mencakup pendekatan partisipatif dalam evaluasi, yang melibatkan tenaga medis secara aktif sejak awal hingga akhir proses evaluasi. Strategi ini terbukti meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta (Billings et al., 2021). Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti survei daring, aplikasi mobile untuk evaluasi, serta pengumpulan data secara anonim juga efektif dalam meningkatkan responsivitas peserta dan mengurangi stigma terkait pelaporan kondisi kesehatan mental (Possemato et al., 2022).

Penggunaan pendekatan evaluasi berbasis tim multidisiplin yang melibatkan berbagai profesi seperti psikolog, perawat, dokter, serta administrator kesehatan juga membantu mengatasi tantangan metodologis dan memastikan evaluasi program lebih valid dan reliabel (Rajamohan et al., 2022).

H. Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Strategi Komunitas

1. Tantangan dalam Mengembangkan Dukungan Berbasis Komunitas

Dalam mengembangkan program dukungan kesehatan mental berbasis komunitas di lingkungan medis, beberapa tantangan utama sering kali muncul. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental, keterbatasan sumber daya (seperti dana, fasilitas, dan tenaga ahli), serta stigma atau resistensi dari tenaga medis yang merasa khawatir bahwa terlibat dalam program kesehatan mental akan berdampak negatif pada karier mereka (Greenberg et al., 2021; Kumar et al., 2021).

Selain itu, kesibukan kerja yang tinggi, jadwal kerja yang tidak teratur, dan keterbatasan waktu sering kali menjadi kendala signifikan bagi tenaga medis dalam berpartisipasi aktif dalam program komunitas. Tantangan struktural seperti kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit dan lemahnya koordinasi antar departemen juga dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif (Labrague & De Los Santos, 2021).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Budaya dan Organisasi

Untuk mengatasi hambatan budaya dan organisasi dalam implementasi program berbasis komunitas, strategi yang efektif perlu dilakukan dengan pendekatan sistematis. Strategi tersebut mencakup peningkatan kesadaran dan advokasi secara aktif melalui edukasi berkelanjutan tentang pentingnya kesehatan mental, dengan melibatkan pimpinan organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang terbuka dan mendukung kesehatan mental (Billings et al., 2021).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa keterlibatan langsung dari pemimpin dan manajer rumah sakit dalam mendukung program komunitas mampu mengurangi stigma dan meningkatkan partisipasi aktif dari tenaga medis. Strategi lainnya meliputi pelatihan khusus bagi pemimpin organisasi tentang cara mendukung kesejahteraan mental staf, serta menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program (Petrella et al., 2021).

Selain itu, pendekatan adaptasi budaya yang sensitif terhadap nilai lokal dan karakteristik organisasi tertentu juga penting. Pendekatan ini mencakup penyesuaian bahasa, bentuk intervensi, dan metode komunikasi agar lebih sesuai dengan norma budaya dan organisasi tenaga medis (Rushton et al., 2021).

3. Rekomendasi Praktis untuk Keberlanjutan Program Komunitas

Keberlanjutan program komunitas kesehatan mental di lingkungan medis membutuhkan perencanaan strategis dan dukungan sistemik jangka panjang. Beberapa rekomendasi praktis yang penting untuk menjamin keberlanjutan program mencakup:

a. Integrasi Program ke dalam Kebijakan Organisasi:

Mengintegrasikan program kesehatan mental ke dalam kebijakan institusional dan sistem manajemen kinerja, sehingga program mendapat legitimasi formal dan dukungan penuh dari manajemen (Billings et al., 2021).

b. Pelibatan Tenaga Medis dalam Proses Perencanaan:

Melibatkan tenaga medis sejak tahap awal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program untuk memastikan relevansi program terhadap kebutuhan nyata komunitas medis (Rajamohan et al., 2022).

c. Pemanfaatan Teknologi secara Optimal:

Menggunakan teknologi seperti platform digital dan telehealth yang dapat menjangkau tenaga medis secara efektif, fleksibel, dan berkelanjutan, khususnya dalam kondisi keterbatasan waktu dan sumber daya (Smith et al., 2022).

d. Pelatihan Reguler dan Dukungan Berkelanjutan:

Menyediakan pelatihan reguler kepada staf tentang keterampilan coping, komunikasi, dan manajemen stres, serta memberikan dukungan berkelanjutan melalui fasilitator dan konselor profesional yang tersedia secara rutin (Rushton et al., 2021).

e. Monitoring dan Evaluasi Rutin:

Melakukan evaluasi rutin dan terstruktur terhadap efektivitas program dengan indikator yang jelas untuk memastikan bahwa program tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan awalnya (Kumar et al., 2021).

Implementasi rekomendasi ini terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan mental komunitas di berbagai lingkungan medis secara internasional.

I. Kesimpulan Dan Rekomendasi

1. Ringkasan Kunci Penting Strategi Berbasis Komunitas

Strategi berbasis komunitas dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat secara psikologis, meningkatkan kesejahteraan mental, serta mengurangi dampak stres kerja. Pendekatan ini berfokus pada penguatan jaringan dukungan sosial antar tenaga medis, kolaborasi interprofesional yang kuat, pemanfaatan

teknologi digital, dan implementasi intervensi yang didasarkan pada kebutuhan spesifik komunitas medis (Billings et al., 2021; Petrella et al., 2021).

Faktor kunci keberhasilan strategi ini mencakup keterlibatan aktif tenaga medis sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, adanya dukungan penuh dari organisasi dan manajemen, serta penggunaan metode intervensi berbasis bukti seperti mindfulness, peer-support, serta pelatihan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik (Greenberg et al., 2021). Evaluasi rutin menggunakan indikator yang jelas juga menjadi kunci untuk memastikan efektivitas dan adaptasi berkelanjutan dari program komunitas (Kumar et al., 2021).

2. Rekomendasi Praktis untuk Pengembangan Program Mendatang

Berdasarkan hasil penelitian terkini, rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam pengembangan program kesehatan mental berbasis komunitas di lingkungan medis meliputi:

a. **Penguatan Dukungan Organisasi dan Manajemen**

Program kesehatan mental harus diintegrasikan ke dalam kebijakan organisasi, didukung oleh pemimpin, dan disediakan sumber daya yang cukup untuk implementasi berkelanjutan (Rushton et al., 2021).

b. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital**

Penggunaan telehealth, platform digital, serta aplikasi mobile perlu ditingkatkan untuk mempermudah akses dan partisipasi tenaga medis dalam program kesehatan mental (Smith et al., 2022).

c. **Pendekatan Kolaborasi Interprofesional yang Diperkuat**

Kolaborasi antar profesi di lingkungan kerja medis harus terus didorong melalui pelatihan bersama dan aktivitas tim yang rutin, guna meningkatkan solidaritas dan efektivitas program komunitas (Liao et al., 2023).

d. **Penyediaan Program Dukungan Sebaya Secara Berkelanjutan**

Menyediakan struktur dukungan sebaya (*peer support*) secara rutin, dengan fasilitator terlatih untuk mengatasi stres kerja serta memperkuat dukungan sosial antar tenaga medis (Shapiro & Galowitz, 2021).

e. **Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan**

Melakukan evaluasi rutin dengan pendekatan metode campuran untuk memastikan adaptasi program sesuai kebutuhan tenaga medis, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi secara berkelanjutan (Rajamohan et al., 2022).

3. Harapan Masa Depan bagi Kesehatan Mental Tenaga Medis

Masa depan kesehatan mental tenaga medis akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam lingkungan kesehatan, mulai dari individu hingga tingkat institusional dan kebijakan nasional. Harapannya, strategi berbasis komunitas akan menjadi bagian integral dari sistem layanan kesehatan di berbagai institusi, di mana kesehatan mental tenaga medis diakui sebagai prioritas utama yang berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan (WHO, 2022).

Dengan terus berkembangnya pemahaman, teknologi, dan metode intervensi berbasis bukti, diharapkan tenaga medis akan memiliki akses yang lebih luas dan mudah terhadap layanan dukungan kesehatan mental, baik secara langsung maupun secara virtual. Selain itu, upaya advokasi dan edukasi secara berkelanjutan diharapkan mampu menghilangkan stigma terkait masalah kesehatan mental, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka, mendukung, dan sejahtera secara psikologis bagi tenaga medis di seluruh dunia (Greenberg et al., 2021; Billings et al., 2021).

Dengan implementasi yang konsisten dan komprehensif dari strategi berbasis komunitas ini, diharapkan bahwa tenaga medis tidak hanya memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik, tetapi juga mampu menghadapi tantangan pekerjaan mereka dengan ketahanan, rasa percaya diri, serta kualitas pelayanan yang semakin meningkat.

J. Penutup

Pengelolaan stres pada tenaga medis merupakan sebuah kebutuhan kritis yang harus mendapatkan perhatian serius, khususnya di tengah meningkatnya kompleksitas dan tuntutan profesi kesehatan dewasa ini. Melalui pendekatan berbasis komunitas, diharapkan kesehatan mental tenaga medis tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab individual semata, melainkan sebagai upaya kolektif dan strategis yang melibatkan seluruh elemen komunitas medis, termasuk rekan kerja, manajemen, serta dukungan sistem organisasi yang luas (Greenberg et al., 2021; Labrague & De Los Santos, 2021).

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa strategi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi stres kerja, meningkatkan kesejahteraan mental, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif bagi tenaga medis. Pendekatan yang mencakup dukungan sebaya (*peer support*), pelatihan keterampilan komunikasi dan konflik, pemanfaatan teknologi seperti platform digital dan telehealth, serta kolaborasi interprofesional yang erat terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan mental

tenaga medis, bahkan dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Billings et al., 2021; Petrella et al., 2021; Smith et al., 2022).

Namun demikian, implementasi strategi komunitas ini tetap menghadapi tantangan signifikan, mulai dari stigma budaya, keterbatasan sumber daya, hingga resistensi internal dari tenaga medis sendiri. Oleh karena itu, komitmen bersama, kesadaran kolektif, serta dukungan yang konsisten dari pimpinan organisasi kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan program di masa depan (Kumar et al., 2021; Rushton et al., 2021).

Sebagai penutup, sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia kesehatan untuk terus memperjuangkan kesehatan mental tenaga medis sebagai prioritas utama. Dukungan yang terus-menerus, program berbasis bukti, dan evaluasi yang rutin harus menjadi bagian integral dari sistem layanan kesehatan. Harapannya, tenaga medis yang sehat secara mental tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup mereka secara pribadi, tetapi juga akan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat luas (WHO, 2022).

Referensi

- Billings, J., Greene, T., Kember, T., Grey, N., El-Leithy, S., Lee, D., & Brewin, C. R. (2021). Supporting hospital staff during COVID-19: Early interventions. *Occupational Medicine*, 71(5), 327–329.
- Greenberg, N., Weston, D., Hall, C., Caulfield, T., Williamson, V., & Fong, K. (2021). Mental health of staff working in intensive care during COVID-19. *Occupational Medicine*, 71(2), 62–67.
- Kumar, A., Nayar, K. R., & Bhat, L. D. (2021). Community participation in health services: A systematic review of assessment methods. *Health Promotion Perspectives*, 11(1), 36–45.
- Labrague, L. J., & De Los Santos, J. A. A. (2021). Prevalence and predictors of anxiety and depression among frontline nurses during COVID-19. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 395–403.
- Petrella, A. R., Hughes, L., & Fern, L. A. (2021). Perceived benefits of peer-support programs for healthcare professionals. *BMC Health Services Research*, 21(1), 1–11.
- Rushton, C. H., Swoboda, S. M., Reller, N., Skarupski, K. A., & Prizzi, M. (2021). Mindful ethical practice and resilience academy: A multimodal approach to improving resilience and reducing burnout. *American Journal of Critical Care*, 30(6), e77–e85.
- Smith, K. E., Crawford, G., Signal, L., & Paine, S. J. (2022). Effectiveness of telehealth-based psychological interventions for healthcare workers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(4), 275–286.
- Rajamohan, S., Porock, D., & Chang, Y. P. (2022). Community-based mental health interventions: A systematic review of approaches and effectiveness. *Community Mental Health Journal*, 58(4), 604–616.
- Shapiro, J., & Galowitz, P. (2021). Peer support groups for healthcare providers: A critical review. *Journal of Interprofessional Care*, 35(6), 824–832.
- Liao, C., Qiu, H., Zhang, Z., Wang, Y., & Zhang, Y. (2023). The impact of work environment on burnout among healthcare workers: A systematic review and meta-analysis. *BMC Health Services Research*, 23(1), 1–12.
- Antonova, E., Schlosser, K., Pandey, R., & Kumari, V. (2021). Mindfulness-based interventions for mental health promotion in healthcare workers: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 12, 715453.
- Possemato, K., Wray, L. O., Funderburk, J. S., & Franklin, C. L. (2022). Digital interventions to support healthcare worker mental health during COVID-19: A rapid review. *JMIR Mental Health*, 9(2), e33325.

- Békés, V., & Doorn, K. A. (2020). Psychotherapists' attitudes toward online therapy during the COVID-19 pandemic. *Journal of Psychotherapy Integration, 30*(2), 238–247.
- Greenhalgh, T., Wherton, J., Shaw, S., & Morrison, C. (2020). Video consultations for COVID-19. *BMJ, 368*, m998.
- Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., & Hu, S. (2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019. *JAMA Network Open, 3*(3), e203976.
- De Kock, J. H., Latham, H. A., Cowden, R. G., Cullen, B., Narzisi, K., Jerdan, S., & Leslie, S. J. (2021). The mental health of NHS staff during the COVID-19 pandemic: A two-wave cohort study. *General Hospital Psychiatry, 71*, 110–116.
- Fernández, R., Lord, H., Halcomb, E., Moxham, L., Middleton, R., & Alanzeh, I. (2020). Implications for COVID-19: A systematic review of nurses' experiences of working in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. *International Journal of Nursing Studies, 111*, 103637.
- Ghafoor, H., Ahmad, Z., & Khan, A. (2021). Conflict management styles among health professionals and its association with work-related stress. *Journal of Health Management, 23*(3), 395–408.
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., & Pronovost, P. J. (2021). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist, 76*(3), 433–450.
- Søvdal, L. E., Naslund, J. A., Kousoulis, A. A., Saxena, S., Qoronfleh, M. W., Grobler, C., & Münter, L. (2021). Prioritizing the mental health and well-being of healthcare workers: An urgent global public health priority. *Frontiers in Public Health, 9*, 679397.
- Johnson, J., Hall, L. H., Berzins, K., Baker, J., Melling, K., & Thompson, C. (2020). Mental healthcare staff well-being during COVID-19: a rapid review of key issues and recommendations. *BMJ Open, 10*(9), e040722.
- Lasalvia, A., Bonetto, C., Porru, S., Carta, A., Tardivo, S., Bovo, C., & Ruggeri, M. (2021). Psychological impact of COVID-19 pandemic on healthcare workers in a highly burdened area of north-east Italy. *Epidemiology and Psychiatric Sciences, 30*, e1–e13.
- Arnetz, J. E., Goetz, C. M., Sudan, S., Arble, E., Janisse, J., & Arnetz, B. B. (2021). Personal protective equipment and mental health symptoms among nurses during the COVID-19 pandemic. *Journal of Occupational and Environmental Medicine, 63*(11), 892–897.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Mental health: Strengthening our response*. Geneva: WHO Press.

World Health Organization (WHO). (2021). *Comprehensive mental health action plan 2013–2030*. Geneva: WHO Press.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK LAYANAN KONSELING JARAK JAUH

A. Pendahuluan

Perkembangan program konseling kesehatan masyarakat di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan bermutu. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di era revolusi industri 4.0. terus berkembang, teknologi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk layanan konseling kesehatan. Inovasi penting dalam bidang kesehatan adalah penerapan layanan konseling jarak jauh. Pemberian layanan konseling jarak jauh melalui teknologi telekomunikasi. Konseling jarak jauh memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan konsultasi, pengelolaan terapi obat, dan edukasi kepada pasien tanpa memerlukan pertemuan dan tatap muka, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk layanan kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul dalam bidang farmasi adalah *telefarmasi*, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan farmasi jarak jauh, termasuk dalam bidang konseling obat. Telefarmasi memungkinkan apoteker untuk memberikan layanan konsultasi dan edukasi mengenai penggunaan obat tanpa memerlukan pertemuan tatap muka langsung. Telefarmasi telah menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, termasuk dalam penanganan penyakit menular.

Pemanfaatan teknologi komunikasi, layanan ini memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi medis dan farmasi secara jarak jauh, sehingga membantu pencegahan dan pengobatan penyakit menular dengan lebih efektif. Layanan konsultasi daring sangat penting untuk penanganan pasien yang terinfeksi penyakit menular seperti COVID-19, tuberkulosis (TBC). Pasien tidak perlu datang ke rumah sakit sehingga mengurangi potensi penularan ke tenaga medis atau pasien lain. Pemberian konseling obat merupakan bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan layanan ini terutama bagi pasien yang tinggal di daerah terpencil, memiliki mobilitas terbatas, atau mengalami keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Konseling jarak jauh dapat memberikan konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui berbagai platform digital seperti telepon, *video call*, *chat* berbasis aplikasi, atau platform *e-health*. Peningkatan aksesibilitas dan efisiensi, penerapan dalam konseling obat juga membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi pengobatan. Pasien dapat memperoleh informasi tentang dosis yang benar, efek samping obat, interaksi dengan makanan atau obat lain, serta tata cara penggunaan obat yang tepat. Hal ini sangat penting dalam pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, di mana kepatuhan terhadap terapi obat berperan besar dalam keberhasilan pengobatan.

Penerapan teknologi dalam konseling jarak jauh juga menghadapi berbagai tantangan. Keamanan, kerahasiaan data pasien, keterbatasan literasi digital dan, serta regulasi terkait layanan farmasi berbasis teknologi. Diperlukan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung agar layanan ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan yang fleksibel dan mudah diakses, telefarmasi diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi dan mendukung sistem kesehatan yang lebih modern dan inklusif.

B. Konseling dalam Kesehatan

1. Pengertian Konseling

Ada banyak pengertian konseling yang dicetuskan oleh para ahli. Hal ini didasarkan pada latar belakang dan pendidikan para ahli yang berbeda pula. Konseling merupakan interaksi yang;

- a. Terjadi antara dua orang individu , masing-masing disebut konselor dan klien;
- b. Terjadi dalam suasana yang profesional;
- c. Dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien (Lubis, 2011).

Konseling adalah proses mengenai seseorang individu yang sedang mengalami masalah (klien) dibantu untuk merasa dan bertindak laku dalam suasana yang lebih menyenangkan melalui interaksi dengan seseorang yang bermasalah yang menyediakan informasi dan reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan tingkah laku yang memungkinkan kliennya berperan secara lebih efektif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Konseling merupakan media bagi pasien untuk mengungkapkan dan mengurangi beban perasaannya. Konseling juga dapat diartikan sebagai hubungan membantu, dimana konselor bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental klien. Didalamnya hubungan tenaga medis dan pasien, dapat dikatakan bahwa tenaga medis adalah

pihak yang membantu, dan pasien sebagai pihak yang terbantu. Pada awalnya konseling dilaksanakan untuk menangani kasus psikologi, namun dalam perkembangannya konseling beradaptasi dengan cabang ilmu lain di dalam penerapannya dikarenakan dalam setiap interaksi sosial antar individu, konseling memegang peran penting. Cabang ilmu yang memerlukan konseling dalam aplikasinya antara lain : ilmu pendidikan, ilmu kesehatan, ilmu agama, industri, dan lain-lain.

2. Tujuan dari pelaksanaan konseling.

Tujuan konseling itu sendiri meliputi lima hal sebagai berikut : a. Aktualisasidiri. Konseling yang dilakukan dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pasien. b. Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian pasien. Dengan konseling pasien menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah kesehatan yang dihadapinya. c. Memahami orang lain. Konseling menumbuhkan sikap saling menghargai, peduli dan menjaga hak dan privasi orang lain. d. Efektivitas. Setelah mengikuti konseling, pasien diharapkan memiliki kemampuan menjalani hidup yang lebih efektif, efisien dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Meningkatnya kemampuan kognitif, afektif, aspek perilaku merupakan salah satu tujuan penting dari pelaksanaan konseling. Kemampuan pasien DM dalam melaksanakan perawatan kaki merupakan contoh kompetensi yang dimiliki pasien setelah mengikuti konseling. Tujuan konseling dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Mengubah penyesuaian perilaku yang salah Maksudnya adalah dengan bantuan konseling, perilaku pasien yang salah selama ini akan diubah menjadi perilaku yang sehat.
 - b. Belajar membuat keputusan Konseling disini lebih ditujukan kepada klien dengan permasalahan psikologis
 - c. Mencegah timbulnya masalah, mencegah munculnya masalah terdiri dari tiga pengertian, yaitu : mencegah agar masalah tidak menimbulkan hambatan di kemudian hari, mencegah agar masalah tidak berkepanjangan, mencegah agar masalah tidak menimbulkan gangguan yang menetap.
- Konseling Kelompok Pada awalnya pelaksanaan konseling dilakukan secara perorangan antara konselor dan klien. Sejalan dengan perkembangan ilmu tentang konseling dan penerapannya di berbagai bidang, maka terciptalah konsep konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses konseling yang dilakukan seorang konselor dengan beberapa orang klien dalam waktu bersamaan yang membicarakan satu permasalahan. Konseling kelompok adalah suatu bentuk konseling yang membantu beberapa klien normal yang diarahkan untuk mencapai fungsi kesadaran secara afektif, yang dilakukan dalam jangka

pendek atau menengah. Dilakukannya konseling secara berkelompok memiliki alasan tersendiri. Konseling kelompok bertujuan sebagai media terapeutik bagi klien/pasien, karena dapat meningkatkan pemahaman diri dan merubah perilaku individual. Konseling kelompok dapat dimanfaatkan sebagai proses belajar dan upaya untuk menolong klien/pasien dalam memecahkan masalahnya

Jenis Konseling Kelompok

1) Konseling kelompok

Dapat dibentuk berdasarkan populasi tertentu, seperti: kelompok anak-anak, orang dewasa, pelajar dan orang tua. Konseling Kelompok Anak-anak. Biasanya ditujukan pada anak-anak yang berperilaku agak berlebihan dibandingkan teman-teman seusianya, seperti sering berkelahi, tidak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya ataupun berprestasi rendah di sekolah. Berkumpul dalam satu kelompok kecil dapat membuat anak-anak mengekspresikan perasaan dan pikirannya sehingga dapat diketahui permasalahan emosional dan perilaku serius yang dialami anak.

2) Konseling Kelompok Remaja .

Didalam kelompok ini, remaja dapat mengeksplorasi perasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, saling berkomunikasi dan mendengarkan keluhan-keluhan teman sebayanya, sehingga mereka dapat saling membantu dan menguatkan serta meningkatkan kepercayaan diri. Konseling Pelajar dan Mahasiswa

3) Konseling kelompok para pelajar

Mahasiswa yang mempunyai kendala dalam penyelesaian studi mereka. Konseling Lansia Hampir sama dengan remaja, konseling kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri para lansia yang sering merasa tidak produktif lagi, tidak diperlukan dan tidak diinginkan sehingga menimbulkan depresi

d. Tindakan Langsung.

Konselor harus mempunyai pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang memadai untuk menghindari kemungkinan negatif dari pasien yang tidak diharapkan.

e. Pengelolaan.

Konselor harus memiliki keterampilan dalam mengelola emosi pasien dan dirinya agar konseling dapat berjalan dengan efektif.

f. Konseling.

Konseling dilaksanakan dalam suasana yang akrab dan nyaman dengan memperhatikan privasi pasien.

Ciri-ciri Konseling Untuk melakukan konseling yang baik, petugas kesehatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : .

- 1) Keterampilan sebagai konselor
- 2) Memiliki pengetahuan klinis tentang penyakit yang diderita pasien. Selain itu petugas kesehatan hendaknya menguasai tiga keterampilan Komunikasi, yaitu :
 - a) Keterampilan melaksanakan Komunikasi verbal dan non verbal
 - b) Keterampilan mengamati Komunikasi verbal dan non verbal pasien dalam melaksanakan konseling kesehatan, R\.Seorang konselor hendaklah tersenyum dengan hangat pada pasiennya, jika melakukan bahasa tubuh yang kurang menyenangkan seperti menguap, maka hendaklah ia minta maaf pada pasiennya. R : Reciprocal Respect, maksudnya saling menghormati antara, konselor dan pasien, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam Komunikasi. E : Expressive Empathy, maksudnya konselor dapat merasakan seperti apa yang dirasakan pasien dan dapat berfikir dari sudut pandang pasien, sehingga pasien merasa konselor dapat memahaminya. S : Straightforward Simplicity, maksudnya dalam menyampaikan informasi kepada pasien tidak bertele-tele, cukup dengan cara atau bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

C. Penerapan Konseling Jarak Jauh di dunia Farmasi

Pelayanan konseling jarak jauh memudahkan pasien mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan resep secara elektronik (e-prescription), pengiriman dan pemesanan obat online serta pemantauan terapi pengobatan. Peran teknologi dalam dunia farmasi dilakukan saat pengorderan obat di apotek. Proses pemesanan obat ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) serta pemantauan stok dan ketersediaan obat sudah dapat dilakukan secara online. Pelayanan Farmasi berbasis online sudah diatur berdasarkan pada permenkes tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, dalam melakukan pelayanan farmasi online secara jejaring, Apotek harus bermitra dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dalam penggunaan sistem elektronik berupa retail online atau marketplace pada fitur khusus kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Telefarmasi dapat dilakukan untuk sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP kecuali narkotika dan psikotropika, sediaan injeksi (selain insulin) serta implan KB.

PSEF itu sendiri merupakan badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, contohnya pada pelayanan telefarmasi. Adapun kebijakan telefarmasi di Indonesia sesuai dengan SEHK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020 tentang telefarmasi dalam rangka telemedisin dan tertuang dalam PMK No 14 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, dan Peraturan BPOM No 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Berdasarkan PMK No. 14 tahun 2021, Sistem Elektronik Farmasi digunakan untuk mendukung fasilitas pelayanan kefarmasian dalam hal telefarmasi, meliputi informasi ketersediaan Obat, Pelayanan resep elektronik, pelayanan swamedikasi, pengantaran Obat dan/atau pelayanan kefarmasian secara elektronik lain sesuai standar pelayanan kefarmasian. Peraturan BPOM No. 8 tahun 2020 Apotek dan PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) menyediakan fungsi komunikasi secara langsung antara pasien dengan apoteker. Adapun bentuk pelayanan telefarmasi pelayanan telefarmasi diantaranya melayani pembelian obat-obatan golongan bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pelayanan resep, melakukan konseling secara langsung melalui telepon, video seperti skype, updox.

Pelayanan telefarmasi tidak lepas dari pelayanan Medication Therapy Management (MTM). MTM adalah layanan yang diberikan oleh apoteker untuk mengoptimalkan terapi obat pasien guna meningkatkan hasil pengobatan dan mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Telefarmasi memainkan peran penting dalam MTM dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memberikan layanan farmasi jarak jauh sehingga meminimalisir kejadian efek samping Adapun bentuk pelayanan telefarmasi dari berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 1. yang dimana pelayanan telefarmasi

No.	Negara	Bentuk Pelayanan
1	Jepang	Telefarmasi untuk obat-obatan golongan bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Adapun gambaran tahapan dalam pemesanan obat golongan bebas secara online (melalui email) yakni : 1. Konfirmasi kondisi pasien (Jenis kelamin, umur, kondisi/penyakit, efek samping merugikan yang pernah dialami, perawatan medis yang sedang dilakukan saat ini, hamil/tidak hamil, komentar atau pertanyaan lainnya) 2. Informasi dari apoteker (dosis dan cara pemberian, perhatian dan lain-lain)

		3. Jawaban dari pasien (memastikan pasien paham) 4. Pengiriman
2	Denmark	Melalui platform http://www.apoteket.dk Untuk konseling dilakukan melalui telepon, video atau pesan teks (konseling dilakukan tidak hanya saat melakukan pembelian tetapi juga dapat dilakukan secara langsung melalui halaman depan website)
3	Skotlandia	Menggunakan tele-teknologi (Telepharmacy Robotic Supply Service (TPRSS)) TPRSs meliputi 1. skirning resep 2. penjualan obat bebas 3. saran melalui tatap muka secara virtual dari apoteker komunitas menggunakan tautan video 4. layanan penyakit ringan (Minor ailment service) 5. penjualan obat kepada pasien per individu 6. kampanye promosi kesehatan
3	Kanada	Menggunakan platform GeriMedRisk. GeriMedrisk merupakan layanan konsultasi farmakologi geriatri yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengobatan pasien untuk meningkatkan kognisi, mobilitas, fungsi dan kesehatan mental metode konsultasi menggunakan telepon dan melalui video
4	China	Layanan apotek jarak jauh menggunakan platform WeChat. Apoteker m kepada pasien dan memungkinkan pasien untuk membeli obat emberikan konsultasi dan edukasi pengobatan secara online dan mengatur pengiriman obat ke rumah
5	Spanyol	Pelayanan delivery obat 1. Pasien secara sukarela meminta untuk mengikuti layanan pengiriman dan menyajikan laporan medis kepada apoteker komunitas 2. Apoteker mengumpulkan permintaan

		3. Apoteker meninjau rekam medis elektronik pasien dan memeriksa apakah obat yang diminta sesuai, memodifikasinya jika dianggap perlu. Jika ada perubahan dikomunikasikan kepada pasien melalui telepon 4. Obat dikemas secara individual per pasien dengan label identitas apotek 5. Layanan logistik mengantarkan obat 6. Sebelum mengambil obat, pasien menandatangani tanda terima
6	Uni Emirate Arab	Pelayanan penjualan obat secara online, penawaran layanan pengiriman obat. Aplikasi yang digunakan untuk layanan telefarmasi diantaranya melalui telepon, email, website, media sosial (facebook dan instagram), aplikasi pesan teks.

Sedangkan di Indonesia itu sendiri terdapat beberapa PSEF yang terdaftar dan dapat melakukan pelayanan kefarmasian diantaranya Goapotik, prixa.ai, Century Pharma, Lifepack.id, Good Doctor, klikdokter, alodokter, sehatq, goapotik, dan vivahealth. pelayanan telefarmasi juga termasuk didalamnya pengantaran obat sampai ke tangan pasien. Pelayanan pengantaran obat ini juga sudah diterapkan di beberapa negara contohnya Jepang, China, Spanyol, Belanda, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Zimbabwe. Pengiriman dilakukan berdasarkan permintaan dari pasien yang dimana obat akan dikirim oleh layanan logistik dan saat pasien menerima obat, maka pasien menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa obat telah sampai ke tangan pasien.

Berdasarkan peraturan BPOM no. 8 tahun 2020 penyerahan obat secara daring dapat dilakukan secara langsung kepada pasien atau dikirim kepada pasien baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk hukum. Apotek ataupun pihak ketiga yang melaksanakan pengiriman obat wajib menjamin mutu dan keamanan obat, menyertakan informasi produk, label dan/atau informasi penggunaan obat, menjaga kerahasiaan isi dari pengiriman, mengirimkan obat dalam wadah tertutup, serta memastikan obat yang dikirim sama sesuai dengan tujuan dan mendokumentasikan serah terima obat.

D. Kekurangan dan kelebihan layanan konseling berbasis Online

Penyedia layanan konseling berbasis online seperti telemedicine dan Telefarmasi dan halodoc. Layanan berbasis online merupakan layanan berbasis teknologi. Teknologi memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam pengimplementasiannya. Keberhasilan layanan telefarmasi sangat bergantung pada tingkat infrastruktur teknologi termasuk didalamnya koneksi internet yang efisien. Layanan telefarmasi tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Kurangnya insentif sebagai tugas tambahan ini juga memungkinkan menjadi kendala. Layanan berbasis online yang efektif didasarkan pada model penyediaan layanan kesehatan berstandar dan regulasi yang mengaturnya. Kebijakan ataupun regulasi yang mengatur tentang pelayanan konseling jarak jauh perlu diterapkan dan terus dikembangkan sehingga implementasi dapat dijalankan.

Keterbatasan lain juga terdapat pada keengganan atau ketidakmampuan dalam penggunaan teknologi modern yang dapat membatasi pelaksanaan pelayanan baik dari sudut pandang tenaga medis ataupun pasien, khususnya pada pasien usia lanjut. Keamanan dan integritas data pasien sangat penting ketika menentukan pengaturan teknologi informasi dari sistem telefarmasi. Akses yang aman untuk mengakses ke catatan pasien diperlukan. Namun, akses catatan pasien harus dibatasi sehingga hanya staf yang terlibat langsung dalam proses pemesanan obat atau resep yang diizinkan untuk mengakses data. Kesulitan dalam penggunaan teknologi. Masalah dalam komunikasi yang berdampak pada efisiensi dan perawatan pasien dan selanjutnya dapat diperumit oleh fakta bahwa telefarmasi melibatkan pasien secara lebih aktif dalam pengelolaan kondisi mereka. Pasien memiliki tanggung jawab lebih, karena menerima perawatan, informasi, dan layanan secara langsung melalui aplikasi perangkat lunak, alat, serta layanan yang saling terhubung. Maka, adapun penjabaran keuntungan serta keterbatasan dalam pelaksanaan telefarmasi dapat dilihat pada Tabel 2.

No.	Kelebihan	Kekurangan
1.	Tingkat kepuasan yang tinggi pada pasien terhadap pelayanan medis	Menekankan perlunya operator pesan teks yang profesional seperti dengan teori dan pengalaman praktis untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dapat dijawab dengan cukup

2.	Membantu meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan	Kesulitan dalam teknologi
3.	Mengatasi ketidaksetaraan layanan kesehatan pada daerah yang terpencil yang kurang terlayani	Sebagian besar pengguna lokal lanjut usia sehingga tidak terbiasa dengan teknologi
4.	Layanan telefarmasi berguna untuk membantu pasien dalam mengontrol terapinya	Penggunaan teknologi - Harus terdapat pelatihan terhadap apoteker
5.	Memberikan solusi yang tepat untuk memperluas akses pengobatan dan penggunaan layanan berbasis online tidak akan berdampak negatif terhadap kualitas penggunaan obat	-
6.	a. meningkatkan hubungan antara pasien dengan apoteker menggali informasi pasien secara lengkap b. mengatasi keterbatasan waktu dalam menggali informasi c. memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kefarmasian.	a. Keterbatasan dalam proses pelayanan yang membutuhkan observasi. b. kekurangan dari sisi legalitas rese
7.	a. Konsultasi virtual memungkinkan pasien dapat mengakses obatobatan dengan perasaan nyaman di rumah yang mengarah pada kepatuhan terhadap regimen obat b. Meningkatkan kemudahan dalam akses pelayanan kefarmasian untuk pasien	a. Masalah keamanan yang mengarah pada informasi kesehatan pasien b. Investasi awal yang besar c. Telefarmasi mungkin tidak relevan dengan fasilitas di tempat praktik

E. Pemanfaatan Internet dan Teknologi Informasi dalam Kesehatan Masyarakat

Semangat menuju masyarakat 5.0 atau society 5.0 di mana masyarakat menjadi pusat dalam penerapan teknologi dan pembangunan ekonomi memiliki relevansi dengan gerakan kesehatan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa penerapan internet-based cognitive behavior therapy (ICBT) dalam community mental health

clinics tampak menjanjikan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang diidentifikasi pada studi tersebut dapat menjadi salah satu landasan ketika merancang program layanan kesehatan masyarakat. Indonesia sendiri kita telah melihatnya banyaknya kemunculan bentuk-bentuk layanan kesehatan berbasis internet yang diisi oleh masyarakat,

Lembaga nirlaba dari pihak swasta sebagai contoh, aplikasi halodoc dengan layanan profesional di dalamnya, website pijar.com dengan edukasi, konseling daring, dan konseling kelompok tatap muka, serta layanan konseling sebaya melalui platform media sosial. Kata kunci “konseling online” di Google juga memunculkan banyak daftar layanan kesehatan mental berbasis internet yang telah tersedia di Indonesia yang Sebagian besarnya muncul atas inisiasi dari masyarakat sendiri (bottom-up). Hal ini menunjukkan besarnya potensi pemanfaatan internet dan teknologi informasi dalam gerakan mental masyarakat di Indonesia

Perkembangan positif tersebut tentu saja perlu didukung dengan evaluasi kritis. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan efektivitas dampak secara luas dan jangka panjang. Evaluasi dampak (impact evaluation) pada level komunitas yang lebih luas perlu dilakukan untuk melihat apakah transformasi positif di masyarakat tercapai sesuai yang dikehendaki) sehingga perbaikan program secara berkelanjutan dapat dilakukan. Uji coba program kesehatan masyarakat berbasis internet dan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan untuk memastikan efektivitas layanan dan cost-effectiveness dari program dibandingkan dengan alternative program lain. Beberapa pendapat negatif terkait layanan kesehatan jarak jauh seperti minimnya rapport antara konselor/psikolog dan klien, kurangnya prosedur klinis, dan bertambahnya biaya perawatan perlu dipertimbangkan dan diantisipasi.
2. Perlunya peningkatan inklusivitas dari layanan kesehatan masyarakat berbasis internet. Adanya risiko dan rendahnya partisipasi dalam layanan kesehatan masyarakat berbasis internet umum terjadi. Kelompok sosioekonomi rendah dan tingkat pendidikan rendah memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini perlu direspon dengan serius. Pengembangan program kesehatan masyarakat yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan akses layanan pada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan layanan (utamanya di daerah rural dan kelompok masyarakat sosioekonomi rendah) justru hanya melanjutkan treatment gap dalam mode yang berbeda. Menguji efikasi maupun efektivitas program kesehatan masyarakat berbasis internet dan teknologi informasi perlu secara khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat sosioekonomi dan pendidikan rendah.

3. Perlunya inventarisasi dan optimalisasi penggunaan layanan kesehatan masyarakat berbasis internet yang tersedia di Indonesia saat ini membutuhkan inventarisasi dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelompok mana saja yang telah mengakses dan memperoleh manfaat atas layanan tersebut dan kelompok mana yang masih terlewat dari layanan kesehatan yang ada. Tujuan dari gerakan kesehatan adalah pelibatan masyarakat secara aktif dan inklusif.
4. Kelompok-kelompok yang belum mendapatkan layanan kesehatan mental perlu mendapat perhatian khusus. Program-program layanan kesehatan berbasis internet yang menutup gap kebutuhan juga perlu dikembangkan. Selain itu, strategi untuk meningkatkan penggunaan layanan kesehatan masyarakat berbasis internet dan teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Promosi yang efektif sesuai target sasaran masing-masing perlu dilakukan tidak hanya oleh penyedia jasa swasta, melainkan juga oleh penyedia jasa pemerintah maupun masyarakat atau organisasi nirlaba. Berbagai program kesehatan berbasis internet dan teknologi informasi baru akan dapat menghasilkan dampak publik yang signifikan ketika program-program tersebut diterapkan secara luas di masyarakat dan tidak berhenti pada studi efektivitasnya saja.

F. Penutup

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan gerakan kesehatan masyarakat. Internet dan teknologi informasi telah memungkinkan munculnya berbagai bentuk layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh penggunanya, mulai dari bentuk email, intervensi yang melibatkan profesional yang terlatih, self-help intervention, unguided self-help intervention, intervensi kelompok, dan kelompok dukungan. Untuk mendukung transformasi positif dalam gerakan kesehatan masyarakat, prinsip-prinsip gerakan kesehatan masyarakat dan psikologi komunitas penting untuk dijadikan panduan dalam mengembangkan layanan kesehatan berbasis internet. Evaluasi dampak, peningkatan inklusivitas, dan peningkatan penggunaan layanan kesehatan berbasis internet juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak revolusi industri 4.0 di bidang layanan kesehatan mental benar-benar membawa dampak positif dan membantu mengatasi permasalahan masyarakat sebagaimana yang dicitakan dalam society 5.0.

Referensi

- Alexander, E., Butler, C. D., Darr, A., Jenkins, M. T., Long, R. D., Shipman, C. J., & Stratton, T. P. (2017). ASHP Statement on Telepharmacy. *American Journal of Health-System Pharmacy*. Vol 74(9), e236-e241.doi:10.2146/ajhp170039
- Bahlol M, Dewey RS. (2021). Pandemic preparedness of community pharmacies for COVID-19. (2020). *Res Social Adm Pharm*. Vol 17(1):1888-1896.
- BPOM. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Jakarta: Depkes RI
- Dzingirai, B., Matyanga, C.M.J., Mudzviti, T.et al. (2020). Risks to the community pharmacists and pharmacy personnel during COVID-19 pandemic: perspectives from a low-income country. *J of Pharm Policy and Pract*. Vol 13 (42).
- Departemen Kesehatan RI. (2002). Pedoman penanggulangan TB. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Diener, Ed, & Suh,E (1997). Measuring quality of life. Economic, Social, and Subjective indicators. *Social Indicators Research*.
- Duan, C., (2019). Culture And Mental Health Counseling: A Reflective View Based On Observations In China. *Athens Journal of Social Sciences*. Vol. 6, No. 1. Pages 71-88.
- Elizabeth, S. (2021). How Negative Emotions Affect Us. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021. <https://www.verywellmind.com/embrace-negative-emotions-4158317>.
- Elbeddini A, dan Yeats A. (2020). Pharmacist intervention amid the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: from direct patient care to telemedicine. *J Pharm Policy Pract*. Vol 27: 13-23.
- Elson EC, Oermann C, Duehlmeier S, Bledsoe S. (2020). Use of telemedicine to provide clinical pharmacy services during the SARS-CoV-2 pandemic. *Am J Health Syst Pharm*.Vol 77(13):1005-1006.
- Evans, D., & Greenway, C. (2010). Exploring the psychological wellbeing of students in Higher Education. Retrieved November. 17. 2021.
- Ewles, L., & Simmet, I. (1992). Konsep Sehat. Jakarta: Pusdiklat Pegawai Depkes RI.
- Folk-Williams, John. (2013). How well-being therapy works. <http://www.storiedmind.com>. Diakses tanggal 17 November 2021.
- Kemenkes. (2020). Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303 /2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kemenkes. (2021). Peraturan menteri kesehatan RI nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Depkes RI Kemenkes. (2022). Pendaftaran PSEF. Tersedia online di <https://psef.kemkes.go.id/> [diakses tanggal 1 oktober 2022]

BAB V

DUKUNGAN KOLEGA DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Pentingnya Dukungan Kolega di Lingkungan Kerja Medis

Dukungan kolega merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh sesama pekerja dalam lingkungan kerja, yang terdiri atas dukungan emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan (Yıldırım, Aycan, & Demircioğlu, 2022). Dalam konteks lingkungan kerja medis, dukungan kolega mencakup berbagai tindakan seperti memberikan bantuan saat menghadapi tantangan klinis, berbagi pengetahuan dan keterampilan medis, serta menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dialami sesama tenaga medis (Jin, Shao, & Wu, 2020).

Dalam dunia keperawatan dan kesehatan, pentingnya dukungan kolega tidak hanya terkait dengan peningkatan produktivitas tetapi juga memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional tenaga medis. Dukungan ini memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas psikologis, memperkuat rasa percaya diri, serta meningkatkan resiliensi tenaga medis dalam menghadapi situasi stres dan tekanan kerja yang tinggi, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Xu et al., 2022; Alharbi, Jackson, & Usher, 2021).

Dukungan kolega terbukti efektif dalam menciptakan suasana kerja yang positif, membangun solidaritas tim, serta memperkuat kolaborasi antar tenaga medis. Menurut Labrague, De Los Santos, dan Fronda (2021), lingkungan kerja yang suportif membantu tenaga medis untuk lebih mudah menghadapi tekanan emosional akibat beban kerja tinggi dan kompleksitas tugas klinis sehari-hari. Dengan demikian, dukungan kolega sangat esensial dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang pada akhirnya membantu dalam mempertahankan tenaga medis yang produktif dan sejahtera secara psikologis.

2. Hubungan antara Dukungan Kolega dengan Pengurangan Stres Kerja

Hubungan antara dukungan kolega dan pengurangan stres kerja di kalangan tenaga medis telah banyak diteliti dalam literatur ilmiah. Studi terbaru menunjukkan bahwa tenaga medis yang memperoleh dukungan sosial dari kolega secara konsisten cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapat dukungan sosial tersebut

(Jin et al., 2020; Yildirim et al., 2022). Fenomena ini sejalan dengan konsep buffering hypothesis, yang menyatakan bahwa dukungan sosial dapat bertindak sebagai "tameng pelindung" yang mengurangi dampak negatif stres terhadap kesehatan mental seseorang (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).

Menurut penelitian oleh Xu et al. (2022), dukungan kolega secara signifikan mengurangi risiko burnout, yang merupakan bentuk stres kronis yang umum terjadi di kalangan tenaga medis. Dukungan emosional, misalnya, memungkinkan tenaga medis untuk berbagi kekhawatiran, mendapatkan empati, serta merasa didengar dan dihargai oleh rekan sejawatnya. Dukungan instrumental, berupa bantuan nyata dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan di tempat kerja, juga membantu tenaga medis merasa lebih mampu dan percaya diri dalam menjalankan tanggung jawabnya (Alharbi et al., 2021).

Penelitian Labrague et al. (2021) menegaskan bahwa dukungan kolega dapat meningkatkan kepuasan kerja, memperkuat komitmen organisasi, serta menurunkan tingkat turnover intention atau keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan sistem dukungan sosial yang kuat di lingkungan kerja medis tidak hanya menguntungkan individu secara personal tetapi juga berdampak positif terhadap efektivitas pelayanan medis secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, jelas bahwa dukungan kolega memiliki peran sentral dalam upaya menurunkan tingkat stres kerja pada tenaga medis. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui peningkatan interaksi positif antar kolega perlu menjadi fokus utama dalam strategi manajemen stres di lingkungan kerja medis.

B. Teori dan Model Dukungan Kolega

1. Model Dukungan Sosial (Social Support Theory)

Model dukungan sosial atau *Social Support Theory* adalah teori yang menguraikan bagaimana hubungan interpersonal dalam jaringan sosial dapat menyediakan bantuan atau dukungan yang bermanfaat dalam mengelola berbagai situasi stres dan tekanan psikologis (Uchino & Trettervik, 2021). Menurut teori ini, dukungan sosial terbagi dalam beberapa bentuk utama, yaitu dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan. Dukungan emosional mencakup perasaan empati, perhatian, dan kepedulian yang diberikan kolega, sedangkan dukungan instrumental berupa bantuan nyata seperti penyelesaian tugas klinis. Dukungan informasional melibatkan pemberian informasi yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan, sementara dukungan

penghargaan merujuk pada pengakuan positif dan afirmasi dari kolega atas kinerja seseorang (Yildirim et al., 2022).

Dalam konteks lingkungan kerja medis, teori dukungan sosial menegaskan bahwa hubungan yang baik antar sesama tenaga medis dapat berfungsi sebagai sumber daya psikologis penting untuk menghadapi beban kerja yang tinggi. Studi terbaru menunjukkan bahwa adanya dukungan sosial secara signifikan berkorelasi dengan menurunnya tingkat burnout, meningkatnya kepuasan kerja, serta meningkatnya rasa kebermaknaan dan kesejahteraan psikologis di kalangan tenaga medis (Xu et al., 2022; Labrague et al., 2021).

2. Model Buffering Hypothesis (Hipotesis Buffer dalam Dukungan Sosial)

Model buffering hypothesis atau hipotesis buffer dalam dukungan sosial menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat bertindak sebagai penyangga atau pelindung terhadap dampak negatif dari stres kerja terhadap kesehatan mental dan fisik seseorang (Kim & Beehr, 2020). Model ini menegaskan bahwa dukungan kolega menjadi efektif khususnya dalam situasi yang memiliki tingkat stres tinggi, seperti yang umumnya dialami oleh tenaga medis. Dukungan kolega tidak hanya meredam efek langsung dari tekanan kerja, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan adaptasi dan resiliensi individu dalam menghadapi situasi yang sulit (Van der Riet et al., 2020).

Hasil penelitian terbaru menguatkan hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa tenaga medis yang memiliki tingkat dukungan sosial tinggi dari kolega cenderung mengalami penurunan signifikan dalam gejala stres, ansietas, dan depresi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jin et al. (2020), ditemukan bahwa dukungan sosial berperan sebagai mediator efektif antara beban kerja dengan tingkat burnout di kalangan perawat rumah sakit. Dengan demikian, model buffering hypothesis memberikan kerangka yang jelas dalam menjelaskan bagaimana hubungan sosial di lingkungan kerja medis dapat melindungi tenaga medis dari dampak negatif stres.

3. Aplikasi Teori Dukungan Sosial dalam Praktik Klinis Keperawatan

Dalam praktik klinis keperawatan, aplikasi teori dukungan sosial telah diimplementasikan melalui berbagai strategi yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung. Strategi ini meliputi implementasi mentorship program, pembentukan kelompok kerja kecil atau tim kolaboratif, serta program intervensi berbasis pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal (Van der Riet et al., 2020; Labrague et al., 2021).

Sebagai contoh, program mentorship yang menerapkan konsep dukungan sosial terbukti efektif dalam meningkatkan adaptasi tenaga medis baru terhadap tuntutan kerja, menurunkan tingkat turnover, serta memperkuat hubungan interpersonal antar kolega (Van der Riet et al., 2020). Selain itu, penggunaan pendekatan kelompok diskusi reguler (peer-group meetings) yang didasarkan pada teori dukungan sosial juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan resiliensi dan kesehatan mental tenaga medis, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 (Xu et al., 2022).

Implementasi aplikasi teori dukungan sosial juga mencakup pemberian pelatihan khusus dalam mengembangkan keterampilan dukungan emosional dan instrumental di kalangan tenaga medis. Hal ini membantu menciptakan budaya kerja yang saling peduli dan tanggap terhadap kebutuhan psikologis sesama tenaga medis, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan stres kerja secara keseluruhan (Alharbi et al., 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, terlihat jelas bahwa pemahaman dan penerapan teori dan model dukungan sosial menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat di kalangan tenaga medis. Pendekatan yang berbasis teori ini memberikan manfaat nyata, baik secara individual maupun institusional.

C. Bentuk-Bentuk Dukungan Kolega

Dalam konteks lingkungan kerja medis, dukungan kolega dapat hadir dalam berbagai bentuk. Dukungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber kenyamanan emosional, tetapi juga sebagai alat praktis yang membantu tenaga medis menghadapi tantangan sehari-hari. Secara umum, bentuk-bentuk dukungan kolega mencakup dukungan emosional, instrumental, informasi, dan penghargaan (*esteem support*) (Yildirim, Ayca, & Demircioğlu, 2022; Xu et al., 2022).

1. Dukungan Emosional: Empati, Perhatian, dan Motivasi Antarkolega

Dukungan emosional merujuk pada tindakan kolega dalam memberikan perhatian, empati, serta semangat kepada sesama pekerja medis yang sedang menghadapi kesulitan, tekanan, atau stres dalam pekerjaan. Bentuk dukungan ini dapat berupa mendengarkan secara aktif, menunjukkan kepedulian, serta memberikan kata-kata positif yang dapat memotivasi dan mengurangi beban psikologis (Jin, Shao, & Wu, 2020). Dukungan emosional merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa aman secara psikologis di lingkungan kerja, serta mampu menurunkan risiko burnout pada tenaga medis (Labrague, De Los Santos, & Fronda, 2021).

Menurut studi yang dilakukan oleh Xu et al. (2022), tenaga medis yang mendapatkan dukungan emosional yang kuat dari kolega memiliki tingkat kesejahteraan psikologis lebih tinggi, lebih jarang mengalami depresi dan ansietas, serta memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam situasi stres tinggi seperti selama pandemi COVID-19.

2. Dukungan Instrumental: Bantuan Praktis dalam Tugas Sehari-hari

Dukungan instrumental mencakup berbagai bentuk bantuan praktis dan nyata yang diberikan kolega dalam menyelesaikan tugas sehari-hari di lingkungan kerja medis. Contoh dukungan instrumental antara lain adalah membantu kolega menyelesaikan tugas-tugas administratif, bergantian dalam menangani pasien dalam situasi yang sibuk, atau membantu dalam penyelesaian tugas klinis lainnya yang kompleks (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa dukungan instrumental secara langsung membantu tenaga medis mengurangi kelelahan fisik dan mental yang terkait dengan beban kerja tinggi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Dukungan instrumental juga terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres kerja dengan membantu individu mengatasi beban kerja secara lebih efektif (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021).

3. Dukungan Informasi: Berbagi Pengetahuan dan Keahlian dalam Situasi Kerja

Dukungan informasi didefinisikan sebagai bantuan kolega dalam bentuk pemberian informasi, panduan, atau saran yang relevan dengan tugas klinis atau situasi kerja tertentu. Dalam lingkungan kerja medis, bentuk dukungan ini umumnya berupa pembagian pengetahuan atau pengalaman praktis dalam menyelesaikan kasus klinis, memberikan saran tentang cara terbaik dalam menghadapi situasi yang sulit, serta berbagi informasi terbaru mengenai prosedur atau praktik klinis terkini (Kim & Beehr, 2020).

Penelitian Labrague et al. (2021) menunjukkan bahwa tenaga medis yang rutin mendapatkan dukungan informasi memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan klinis dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dukungan ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan stres kerja secara signifikan.

4. Dukungan Penghargaan (Esteem Support): Pengakuan dan Penghargaan atas Pencapaian Kerja Kolega

Dukungan penghargaan atau esteem support merupakan bentuk dukungan kolega yang berupa penghargaan, pengakuan, dan apresiasi positif atas pencapaian atau kontribusi seorang tenaga medis. Dukungan ini meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan kepuasan kerja, serta memperkuat identitas profesional tenaga medis (Yıldırım et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa pemberian penghargaan dari kolega memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan rasa bermakna dalam pekerjaan, penurunan stres, serta peningkatan motivasi intrinsik untuk terus berkinerja baik dalam pekerjaan (Jin et al., 2020). Menurut Yıldırım et al. (2022), bentuk penghargaan sederhana seperti ucapan terima kasih atau pengakuan publik atas pencapaian tertentu dapat secara efektif mengurangi risiko burnout dan meningkatkan kesejahteraan tenaga medis secara keseluruhan.

Dengan memahami dan mengoptimalkan berbagai bentuk dukungan kolega ini, tenaga medis dan manajemen institusi kesehatan dapat lebih efektif menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi semua pekerja.

D. Peran Dukungan Kolega dalam Menurunkan Stres Tenaga Medis

Dukungan kolega memainkan peran sentral dalam strategi pengelolaan stres tenaga medis di lingkungan kerja. Di tengah tingginya tekanan dan tantangan dalam praktik klinis, adanya hubungan kolegal yang positif terbukti dapat secara signifikan mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis tenaga medis. Penjelasan berikut akan menguraikan secara detail efektivitas dukungan kolega dalam mengurangi burnout, hubungan kualitas relasi antarkolega terhadap kepuasan kerja, serta contoh intervensi praktis yang membuktikan manfaat nyata dukungan kolega.

1. Efektivitas Dukungan Kolega dalam Mengurangi Burnout Tenaga Medis

Burnout merupakan kondisi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan berkurangnya rasa pencapaian pribadi yang umum dialami oleh tenaga medis akibat beban kerja yang tinggi serta tekanan emosional yang intens (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021). Dukungan kolega terbukti efektif sebagai faktor protektif dalam mencegah dan mengurangi tingkat burnout. Penelitian Labrague, De Los Santos, dan Fronda (2021) menemukan bahwa perawat yang mendapatkan dukungan tinggi dari kolega memiliki risiko burnout yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mendapat dukungan yang memadai. Dukungan kolega berfungsi sebagai buffer emosional yang membantu tenaga medis mengelola tekanan emosional dan stres kerja.

Penelitian lain oleh Jin, Shao, dan Wu (2020) memperkuat temuan tersebut, di mana dukungan sosial kolega secara signifikan menurunkan persepsi stres dan tingkat burnout pada perawat rumah sakit. Hasil studi ini menunjukkan bahwa interaksi positif di lingkungan kerja menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas, yang menjadi elemen penting dalam meningkatkan ketahanan tenaga medis terhadap tekanan pekerjaan.

2. Hubungan antara Kualitas Hubungan Kolega dengan Tingkat Kepuasan Kerja

Kualitas hubungan antarkolega merupakan prediktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan kerja tenaga medis. Studi terbaru menunjukkan bahwa hubungan kerja yang suportif, saling percaya, dan kooperatif secara signifikan meningkatkan kepuasan kerja, yang pada gilirannya berhubungan dengan penurunan stres kerja (Xu et al., 2022). Menurut Yıldırım, Aycan, dan Demircioğlu (2022), tenaga medis yang merasa dihargai dan didukung koleganya menunjukkan peningkatan motivasi kerja dan kepuasan kerja secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penelitian Van der Riet, Levett-Jones, dan Aquino-Russell (2020) menegaskan bahwa hubungan kolega yang positif juga memperkuat keterikatan emosional dan komitmen organisasi. Tenaga medis yang puas dengan relasi interpersonal di tempat kerja cenderung lebih resisten terhadap efek negatif dari stres, serta memiliki tingkat absensi dan turnover intention yang lebih rendah.

3. Studi Kasus tentang Peran Intervensi Dukungan Kolega dalam Menurunkan Stres Kerja

Beberapa intervensi praktis yang mengintegrasikan konsep dukungan kolega telah berhasil menurunkan tingkat stres tenaga medis secara nyata. Sebagai contoh, program pendampingan berbasis kolega (peer mentoring) yang dilakukan di rumah sakit Australia menunjukkan bahwa tenaga medis yang mengikuti program ini memiliki penurunan gejala stres, burnout, serta peningkatan kesejahteraan psikologis secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti program (Van der Riet et al., 2020).

Penelitian serupa di Tiongkok selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa penerapan kelompok diskusi antarkolega secara rutin mampu mengurangi stres psikologis di kalangan tenaga medis secara substansial (Xu et al., 2022). Intervensi ini memberikan ruang aman bagi tenaga medis untuk berbagi pengalaman, memperoleh empati, serta mendapatkan dukungan informasi yang relevan dari sesama tenaga medis. Hasilnya, tenaga medis merasa lebih

terhubung secara sosial, didukung secara emosional, dan mampu mengatasi tekanan kerja dengan lebih baik.

Penelitian di Filipina oleh Labrague et al. (2021) juga menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti kegiatan tim rutin untuk membangun kohesi sosial (*team building*) menghasilkan peningkatan signifikan dalam persepsi dukungan kolega, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesehatan mental dan mengurangi risiko burnout.

Dengan demikian, berbagai studi kasus tersebut menegaskan pentingnya intervensi terstruktur berbasis kolega dalam menurunkan stres kerja dan menciptakan lingkungan kerja medis yang sehat dan produktif.

E. Strategi Praktis untuk Meningkatkan Dukungan Kolega

Meningkatkan dukungan kolega dalam lingkungan kerja medis memerlukan pendekatan yang terencana dan sistematis. Berbagai strategi praktis dapat diimplementasikan guna menciptakan hubungan interpersonal yang positif serta mendukung kesehatan mental dan emosional tenaga medis. Strategi ini meliputi pelatihan komunikasi interpersonal, program mentorship, aktivitas membangun tim (*team building*), dan pengembangan budaya kerja kolaboratif.

1. Pelatihan Keterampilan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah kunci dalam menjalin hubungan kerja yang efektif dan suportif. Pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal meliputi kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan umpan balik konstruktif, serta menyelesaikan konflik secara positif. Menurut penelitian Labrague et al. (2021), tenaga medis yang mendapat pelatihan komunikasi interpersonal menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hubungan kolega, berkurangnya konflik interpersonal, serta menurunnya stres akibat kesalahpahaman atau miskomunikasi.

Penelitian oleh Van der Riet, Levett-Jones, dan Aquino-Russell (2020) juga menegaskan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal secara efektif memperkuat dukungan emosional di antara tenaga medis, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan kondusif untuk kesejahteraan psikologis.

2. Program Mentorship dan Buddy System di Tempat Kerja

Mentorship dan buddy system merupakan strategi yang efektif untuk membangun jaringan dukungan kolega. Dalam sistem ini, tenaga medis senior atau lebih berpengalaman berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan, dukungan emosional, serta berbagi pengetahuan kepada tenaga medis baru atau yang kurang berpengalaman. Studi integratif oleh Van der Riet

et al. (2020) menemukan bahwa program mentorship secara signifikan meningkatkan adaptasi, keterlibatan kerja, serta menurunkan tingkat burnout di kalangan tenaga medis pemula.

Buddy system, sebagai pendekatan lebih informal, juga terbukti membantu tenaga medis dalam mengatasi tantangan pekerjaan sehari-hari. Menurut Xu et al. (2022), sistem ini menciptakan rasa solidaritas yang tinggi, mengurangi isolasi sosial, serta memberikan rasa aman secara psikologis yang penting dalam mengelola stres kerja.

3. Aktivitas Membangun Tim (Team Building) Rutin

Aktivitas team building rutin, seperti kegiatan di luar tempat kerja atau workshop interaktif, terbukti efektif mempererat hubungan kolega, meningkatkan kepercayaan interpersonal, serta memperkuat kerjasama tim. Menurut Yildirim et al. (2022), tenaga medis yang secara teratur mengikuti aktivitas team building menunjukkan penurunan stres, peningkatan kohesi tim, dan peningkatan motivasi kerja.

Hasil penelitian oleh Jin, Shao, dan Wu (2020) menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan relasi sosial, tetapi juga secara langsung meningkatkan persepsi tenaga medis tentang dukungan kolega, yang berdampak positif pada kesehatan mental secara keseluruhan.

4. Pengembangan Budaya Kerja Kolaboratif dan Suportif

Budaya kerja kolaboratif dan suportif di institusi kesehatan adalah dasar utama dalam membangun hubungan kerja yang sehat antar kolega. Pengembangan budaya ini mencakup pembuatan kebijakan yang mendukung interaksi sosial positif, penguatan norma-norma kerja sama, serta penghargaan terhadap perilaku kolaboratif. Studi terbaru menunjukkan bahwa institusi kesehatan yang secara aktif mempromosikan budaya kolaboratif memiliki tingkat kepuasan kerja dan retensi tenaga medis yang lebih tinggi, serta tingkat stres kerja yang lebih rendah (Kim & Beehr, 2020; Labrague et al., 2021).

Sebuah studi kasus yang dilakukan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa institusi kesehatan yang menekankan budaya kolaborasi, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu mampu secara efektif menjaga kesejahteraan psikologis tenaga medisnya dalam situasi stres ekstrem (Xu et al., 2022). Dengan demikian, budaya kerja kolaboratif tidak hanya memperbaiki kualitas hubungan kolega tetapi juga menciptakan fondasi jangka panjang untuk kesehatan mental tenaga medis.

F. Implementasi Program Dukungan Kolega

Implementasi program dukungan kolega merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi tenaga medis. Agar program ini efektif, perlu disusun langkah-langkah implementasi yang sistematis, didukung oleh studi kasus dari praktik nyata, serta dilengkapi dengan proses evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan tujuan program tercapai secara optimal.

1. Langkah-Langkah Implementasi Program Dukungan Kolega

Implementasi program dukungan kolega memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup tahapan-tahapan jelas, yaitu:

- a. Analisis Kebutuhan: Tahap awal adalah menganalisis kebutuhan dukungan sosial di institusi kesehatan melalui survei atau wawancara dengan tenaga medis untuk memahami tantangan, kebutuhan, dan harapan terkait dukungan kolega (Xu et al., 2022).
- b. Perancangan Program: Menyusun program yang spesifik dan jelas, meliputi pemilihan bentuk dukungan yang tepat (misalnya, mentorship, buddy system, atau kegiatan rutin team building), menentukan metode pelaksanaan, serta sumber daya yang diperlukan (Labrague, De Los Santos, & Fronda, 2021).
- c. Sosialisasi dan Pelatihan: Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada tenaga medis mengenai tujuan, manfaat, serta cara terlibat dalam program. Pelatihan juga diberikan kepada tenaga medis untuk memastikan mereka memahami bagaimana berpartisipasi secara efektif dalam memberikan dukungan kepada kolega (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).
- d. Implementasi dan Pemantauan: Menjalankan program secara konsisten sambil melakukan pemantauan reguler untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan segera mengatasi hambatan yang muncul (Yıldırım, Aycan, & Demircioğlu, 2022).
- e. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan serta menyesuaikan dan memperbaiki program sesuai dengan temuan evaluasi (Jin, Shao, & Wu, 2020).

2. Studi Kasus Penerapan Dukungan Kolega di Institusi Kesehatan

Berbagai institusi kesehatan telah berhasil mengimplementasikan program dukungan kolega dengan hasil yang positif. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit di Australia menerapkan program mentorship yang sistematis untuk perawat baru. Program ini berhasil meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stres kerja, serta meningkatkan retensi tenaga medis (Van der Riet et al., 2020).

Di Tiongkok, sebuah rumah sakit besar selama pandemi COVID-19 menerapkan diskusi kelompok secara reguler untuk memberikan dukungan

emosional dan informasional antar tenaga medis. Studi ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kecemasan, depresi, dan burnout tenaga medis setelah partisipasi dalam program tersebut (Xu et al., 2022).

Sementara itu, penelitian oleh Labrague et al. (2021) di Filipina menunjukkan bahwa institusi yang menerapkan aktivitas team building secara rutin mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, mempererat hubungan kolega, dan secara nyata menurunkan tingkat burnout serta turnover intention.

3. Evaluasi dan Monitoring Efektivitas Program Dukungan Kolega

Evaluasi dan monitoring adalah elemen penting dalam pelaksanaan program dukungan kolega. Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah program telah memenuhi tujuan awal seperti menurunkan stres kerja, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan hubungan kolega secara efektif (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021).

Metode evaluasi dapat mencakup survei sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk mengukur perubahan tingkat stres, burnout, serta persepsi dukungan sosial. Selain itu, wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus (FGD) dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dampak program dari perspektif peserta (Yıldırım et al., 2022).

Monitoring berkala sangat penting untuk memastikan program berjalan secara konsisten dan memungkinkan identifikasi dini masalah serta solusi cepat atas tantangan yang mungkin timbul selama implementasi. Menurut penelitian Jin et al. (2020), program yang disertai monitoring aktif menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak terpantau secara reguler.

Keseluruhan proses evaluasi dan monitoring memastikan bahwa program dukungan kolega tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan tenaga medis, sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Dukungan Kolega

Implementasi program dukungan kolega di lingkungan kerja medis tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diperhatikan, baik yang berasal dari faktor internal tenaga medis itu sendiri maupun faktor eksternal yang melibatkan kebijakan institusi dan manajemen sumber daya. Pemahaman atas tantangan ini sangat penting agar strategi yang efektif dapat dikembangkan untuk mengatasinya.

1. Faktor Internal: Resistensi Tenaga Medis terhadap Perubahan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi program dukungan kolega adalah resistensi internal dari tenaga medis terhadap perubahan. Resistensi ini muncul karena tenaga medis seringkali sudah terbiasa dengan pola kerja lama yang telah berlangsung lama dan merasa nyaman dengan kebiasaan tersebut. Perubahan baru, bahkan yang bersifat positif, sering dianggap mengganggu atau merepotkan karena memerlukan penyesuaian kembali (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021).

Penelitian oleh Yıldırım, Aycan, dan Demircioğlu (2022) menunjukkan bahwa resistensi tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran mengenai manfaat program dukungan sosial serta kekhawatiran bahwa program tersebut hanya menambah beban kerja tambahan. Sikap skeptis atau apatisme terhadap manfaat intervensi juga merupakan penyebab lain munculnya resistensi di kalangan tenaga medis (Xu et al., 2022).

2. Faktor Eksternal: Kebijakan Institusi dan Manajemen Sumber Daya

Selain faktor internal, implementasi dukungan kolega juga menghadapi hambatan eksternal berupa kebijakan institusi dan manajemen sumber daya yang kurang mendukung. Hambatan ini meliputi kurangnya dukungan pimpinan institusi, tidak adanya alokasi waktu khusus untuk aktivitas yang terkait dengan program dukungan, serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan, kegiatan tim, atau program pendampingan kolega (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).

Penelitian oleh Labrague, De Los Santos, dan Fronda (2021) menemukan bahwa institusi yang tidak secara eksplisit mendukung program dukungan sosial sering mengalami hambatan dalam keberlanjutan program. Selain itu, kebijakan institusi yang kurang jelas atau ambivalen terhadap program dukungan kolega menyebabkan rendahnya partisipasi dan komitmen tenaga medis dalam mengikuti kegiatan tersebut (Jin, Shao, & Wu, 2020).

3. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Program Dukungan Kolega

Untuk mengatasi hambatan implementasi dukungan kolega, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Strategi praktis berikut dapat diterapkan:

- a. Komunikasi yang Efektif dan Transparan: Penting untuk memberikan penjelasan jelas kepada tenaga medis mengenai manfaat konkret program dukungan kolega melalui sosialisasi yang intensif dan keterlibatan langsung tenaga medis dalam perencanaan program. Penjelasan yang transparan mengenai tujuan, manfaat, dan harapan dari program dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan (Labrague et al., 2021).

- b. Pelibatan Tenaga Medis dalam Proses Perencanaan dan Implementasi: Melibatkan tenaga medis secara aktif sejak tahap awal perencanaan hingga implementasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap program, sehingga menurunkan resistensi internal (Van der Riet et al., 2020).
- c. Dukungan Pimpinan dan Kebijakan Institusi yang Jelas: Mendapatkan komitmen tegas dari manajemen institusi melalui kebijakan yang jelas, anggaran yang memadai, serta alokasi waktu yang mencukupi untuk program dukungan kolega dapat secara signifikan mengatasi hambatan eksternal (Xu et al., 2022).
- d. Evaluasi Berkala dan Responsif: Melakukan evaluasi secara rutin untuk mendapatkan umpan balik dari peserta program, serta siap melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi, sangat penting untuk memastikan program terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan implementasi yang dinamis (Yıldırım et al., 2022).

Dengan memahami dan mengantisipasi berbagai tantangan internal dan eksternal tersebut serta menerapkan strategi yang tepat, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa implementasi program dukungan kolega berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi tenaga medis.

H. Studi Kasus Internasional tentang Keberhasilan Dukungan Kolega

Studi kasus internasional menjadi sumber pembelajaran penting dalam mengimplementasikan praktik terbaik (*best practice*) terkait dukungan kolega di institusi kesehatan. Berbagai pengalaman dari institusi kesehatan di negara lain yang sukses dalam menerapkan dukungan kolega dapat memberikan wawasan yang berharga untuk adaptasi di Indonesia. Subtopik ini akan mengulas beberapa analisis praktik terbaik dari institusi kesehatan internasional, serta pembelajaran yang bisa diterapkan dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

1. Analisis Best Practice Dukungan Kolega di Institusi Kesehatan Internasional

Sejumlah institusi kesehatan internasional telah berhasil mengembangkan program dukungan kolega dengan hasil yang positif. Salah satu studi kasus yang menonjol berasal dari Inggris, di mana National Health Service (NHS) menerapkan program *peer support and mentoring* yang secara sistematis dikelola dalam rangka mengurangi stres dan burnout tenaga medis selama pandemi COVID-19. Program ini mencakup sesi konseling antarkolega, pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal, serta kegiatan kelompok yang mendukung kesejahteraan mental para pekerja medis. Hasilnya, para pekerja medis

melaporkan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan emosional dan menurunnya gejala stres dan burnout (Blake et al., 2020).

Di Australia, program *mentorship* terstruktur untuk perawat baru terbukti berhasil meningkatkan adaptasi, mengurangi tingkat turnover, dan menurunkan stres kerja di rumah sakit-rumah sakit besar. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas tim secara keseluruhan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif dan kooperatif (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).

Di Kanada, studi kasus di rumah sakit Universitas Toronto menunjukkan bahwa penerapan kelompok diskusi rutin (*peer-group*) dalam bentuk forum reflektif sangat efektif dalam menciptakan rasa solidaritas dan menurunkan stres psikologis para tenaga medis. Forum ini memberikan ruang yang aman bagi tenaga medis untuk saling berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan emosional, serta memperkuat hubungan interpersonal secara positif (Hossain & Clatty, 2021).

2. Pembelajaran dan Rekomendasi Praktik yang Dapat Diterapkan di Indonesia

Dari analisis praktik terbaik internasional tersebut, beberapa pembelajaran penting dapat diambil untuk diterapkan di Indonesia, antara lain:

- a. Penguatan Budaya Dukungan Kolega melalui Mentorship: Seperti di Inggris dan Australia, program *mentorship* yang sistematis dan terstruktur sebaiknya diadopsi dan disesuaikan dengan karakteristik institusi kesehatan di Indonesia. Program ini perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk para mentor sehingga dukungan yang diberikan optimal dan berdampak nyata terhadap penurunan stres kerja tenaga medis (Van der Riet et al., 2020).
- b. Penerapan Forum Reflektif Berkala: Mengadopsi forum reflektif rutin seperti yang dilakukan di Kanada dapat membantu tenaga medis di Indonesia untuk secara terbuka berbagi tantangan, stres, dan pengalaman sehari-hari. Forum ini sangat penting untuk memperkuat dukungan emosional, meningkatkan rasa percaya antar kolega, serta mengurangi stigma negatif terkait kesehatan mental tenaga medis (Hossain & Clatty, 2021).
- c. Pelatihan Keterampilan Komunikasi Interpersonal yang Rutin: Pengalaman dari NHS Inggris menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi interpersonal yang rutin dan berkelanjutan sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Pelatihan ini harus diintegrasikan ke dalam program pendidikan berkelanjutan tenaga medis di Indonesia untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan (Blake et al., 2020).

d. Dukungan Kebijakan dan Komitmen Institusional: Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi dukungan kolega di institusi internasional adalah adanya komitmen penuh dari pimpinan institusi, kebijakan yang jelas, serta alokasi sumber daya yang memadai. Pembelajaran ini perlu diterapkan secara serius oleh institusi kesehatan di Indonesia melalui pengembangan kebijakan institusional yang jelas tentang pentingnya program dukungan kolega sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan tenaga medis (Yıldırım, Aycan, & Demircioğlu, 2022).

Dengan menerapkan pembelajaran ini secara strategis dan kontekstual, institusi kesehatan di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas implementasi program dukungan kolega, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta secara nyata menurunkan tingkat stres dan burnout di kalangan tenaga medis.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Pentingnya Dukungan Kolega dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Sehat

Dukungan kolega merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat di institusi kesehatan. Dukungan ini meliputi berbagai aspek, antara lain dukungan emosional, instrumental, informasional, serta dukungan penghargaan (*esteem support*) (Yıldırım, Aycan, & Demircioğlu, 2022). Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa dukungan kolega secara signifikan mampu mengurangi tingkat stres kerja, menurunkan risiko burnout, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis tenaga medis (Jin, Shao, & Wu, 2020; Labrague, De Los Santos, & Fronda, 2021).

Kualitas hubungan kolegial yang tinggi tidak hanya berdampak positif terhadap individu, tetapi juga meningkatkan kepuasan kerja, memperkuat solidaritas tim, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Xu et al., 2022). Implementasi strategi seperti pelatihan komunikasi interpersonal, mentorship, aktivitas *team building*, serta pengembangan budaya kerja kolaboratif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dukungan kolega, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sehat (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020).

Meski demikian, implementasi program dukungan kolega tidak bebas dari tantangan. Hambatan internal berupa resistensi tenaga medis terhadap perubahan, serta hambatan eksternal seperti kebijakan institusi yang kurang mendukung, menjadi tantangan nyata yang perlu diperhatikan dan diatasi melalui strategi yang tepat dan komprehensif (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021).

2. Rekomendasi Praktis untuk Pengelola dan Tenaga Medis dalam Meningkatkan Dukungan Kolega

Berdasarkan pembahasan komprehensif mengenai pentingnya dukungan kolega, berikut adalah rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pengelola institusi kesehatan dan tenaga medis untuk meningkatkan efektivitas dukungan kolega di lingkungan kerja medis:

a. Integrasi Program Dukungan Kolega dalam Kebijakan Institusi

Pengelola institusi kesehatan perlu mengintegrasikan secara eksplisit program dukungan kolega ke dalam kebijakan institusional. Kebijakan ini mencakup dukungan anggaran, waktu khusus, serta insentif bagi tenaga medis yang berpartisipasi aktif dalam program dukungan kolega (Yıldırım et al., 2022).

b. Pelatihan Komunikasi Interpersonal secara Rutin

Pengelola perlu menyediakan pelatihan keterampilan komunikasi interpersonal secara rutin bagi tenaga medis. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan mendengarkan aktif, pemberian umpan balik positif, serta teknik resolusi konflik untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan suportif antar kolega (Labrague et al., 2021).

c. Program Mentorship dan Buddy System yang Terstruktur

Institusi kesehatan direkomendasikan menerapkan program mentorship dan buddy system secara terstruktur. Mentor harus dilatih secara khusus agar dapat memberikan dukungan efektif kepada tenaga medis baru, sehingga mereka merasa didukung secara emosional dan instrumental dalam menghadapi tantangan kerja sehari-hari (Van der Riet et al., 2020).

d. Pelaksanaan Kegiatan Team Building secara Terjadwal

Aktivitas *team building* sebaiknya dijadwalkan secara rutin, baik dalam bentuk formal maupun informal, untuk memperkuat ikatan antar tenaga medis. Kegiatan ini akan meningkatkan solidaritas, saling percaya, dan dukungan kolega yang positif, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis (Xu et al., 2022).

e. Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan

Pengelola perlu menerapkan evaluasi dan monitoring rutin terhadap efektivitas program dukungan kolega. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan berkelanjutan serta adaptasi program terhadap kebutuhan yang terus berkembang (Jin et al., 2020).

f. Keterlibatan Aktif Tenaga Medis dalam Program

Tenaga medis perlu aktif terlibat sejak perencanaan hingga implementasi program dukungan kolega. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki, mengurangi resistensi terhadap perubahan, serta memperkuat efektivitas dan dampak positif dari program dukungan kolega (Alharbi et al., 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi ini secara konsisten, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa program dukungan kolega berjalan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga medis secara berkelanjutan.

J. Penutup

Lingkungan kerja medis yang sehat merupakan kunci dalam menjaga kesejahteraan tenaga medis serta kualitas pelayanan kesehatan. Dukungan kolega yang efektif telah terbukti menjadi komponen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta menurunkan tingkat stres dan burnout pada tenaga medis. Berbagai bentuk dukungan, mulai dari emosional, instrumental, informasional, hingga penghargaan, saling melengkapi dalam memperkuat jaringan sosial dan hubungan interpersonal positif di tempat kerja (Yıldırım, Aycan, & Demircioğlu, 2022).

Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa keberadaan dukungan kolega di tempat kerja medis secara nyata menurunkan risiko burnout, meningkatkan kepuasan kerja, serta memperkuat motivasi dan komitmen tenaga medis terhadap profesinya (Jin, Shao, & Wu, 2020; Labrague, De Los Santos, & Fronda, 2021). Berbagai studi kasus internasional telah memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik yang bisa diadaptasi dalam konteks institusi kesehatan di Indonesia, seperti program mentorship yang terstruktur, pelatihan komunikasi interpersonal, serta aktivitas team building secara rutin (Van der Riet, Levett-Jones, & Aquino-Russell, 2020; Xu et al., 2022).

Meski demikian, implementasi program dukungan kolega tidak terlepas dari tantangan internal maupun eksternal, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya dukungan kebijakan institusi (Alharbi, Jackson, & Usher, 2021). Oleh karena itu, komitmen institusional yang kuat, pelibatan aktif tenaga medis, serta evaluasi berkala menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas dan kesinambungan program dukungan kolega (Yıldırım et al., 2022).

Akhir kata, pengelolaan stres tenaga medis melalui penguatan dukungan kolega bukanlah tugas yang sederhana, melainkan proses dinamis yang memerlukan kolaborasi aktif seluruh pihak yang terlibat. Dengan komitmen bersama serta strategi yang tepat dan konsisten, diharapkan dukungan kolega mampu

menciptakan lingkungan kerja medis yang sehat dan berkelanjutan, demi kualitas hidup tenaga medis serta optimalisasi pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa depan.

Referensi

- Alharbi, J., Jackson, D., & Usher, K. (2021). Personal characteristics, coping strategies, and resilience impact on burnout among nurses: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 124, 104097. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104097>
- Blake, H., Bermingham, F., Johnson, G., & Tabner, A. (2020). Mitigating the psychological impact of COVID-19 on healthcare workers: A digital learning package. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 2997. <https://doi.org/10.3390/ijerph17092997>
- Hossain, F., & Clatty, A. (2021). Self-care strategies in response to nurses' moral injury during COVID-19 pandemic. *Nursing Ethics*, 28(1), 23–32. <https://doi.org/10.1177/0969733020961825>
- Jin, Y., Shao, R., & Wu, L. (2020). The mediating effect of social support on job stress and burnout among hospital nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 26(5), e12893. <https://doi.org/10.1111/ijn.12893>
- Kim, M., & Beehr, T. A. (2020). Empowering leadership: Leading people to be present through affective organizational commitment? *International Journal of Human Resource Management*, 31(16), 2017–2044. <https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1424017>
- Labrague, L. J., De Los Santos, J. A. A., & Fronda, D. C. (2021). Factors associated with missed nursing care and its impact on nurses' burnout and intention to leave: The moderating role of coworker support. *Nursing Open*, 8(5), 2710–2719. <https://doi.org/10.1002/nop2.850>
- Van der Riet, P., Levett-Jones, T., & Aquino-Russell, C. (2020). Mentoring as a strategy for supporting nurses in clinical practice: An integrative review. *Journal of Nursing Management*, 28(4), 662–670. <https://doi.org/10.1111/jonm.12954>
- Xu, W., Pan, Z., Li, Z., Lu, S., & Zhang, L. (2022). Social support and job satisfaction among healthcare workers during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychology*, 13, 852502. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.852502>
- Yıldırım, N., Aycan, Z., & Demircioğlu, M. A. (2022). The role of supervisor and coworker support on nurses' psychological well-being. *Journal of Advanced Nursing*, 78(5), 1399–1411. <https://doi.org/10.1111/jan.15157>
- Dewanto, A., & Wardani, I. Y. (2021). *Manajemen Stres Tenaga Kesehatan: Strategi dan Implementasi Praktis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Health Sciences.

World Health Organization (WHO). (2020). *Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak*. WHO Press.

BAB VI

PERAN MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN TENAGA MEDIS

A. Pendahuluan

1. Definisi Peran Manajemen dalam Konteks Kesejahteraan Tenaga Medis

Manajemen dalam konteks kesejahteraan tenaga medis merupakan serangkaian aktivitas, kebijakan, dan praktik yang dilakukan oleh pimpinan atau pengelola institusi kesehatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Dalam hal ini, peran manajemen mencakup tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada stres dan kelelahan tenaga medis, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Bakhamis et al., 2019; Mohsin, Shahed, & Zaman, 2021).

Secara spesifik, peran manajemen mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja, penyediaan sumber daya yang memadai, pelaksanaan pelatihan atau edukasi tentang manajemen stres, hingga menciptakan budaya organisasi yang transparan, kolaboratif, dan suportif. Selain itu, manajemen bertanggung jawab dalam memfasilitasi akses layanan kesehatan mental profesional bagi tenaga medis yang mengalami masalah psikologis terkait beban kerja (Havaei, MacPhee, & Lee, 2019; Skakon et al., 2020).

2. Pentingnya Keterlibatan Manajemen dalam Mengurangi Stres Kerja Tenaga Medis

Stres kerja pada tenaga medis merupakan isu yang krusial, karena dampaknya yang luas terhadap kualitas pelayanan kesehatan, produktivitas tenaga kerja, serta kesehatan fisik dan mental individu. Keterlibatan aktif manajemen dalam mengurangi stres kerja tenaga medis menjadi sangat penting mengingat kompleksitas dan tekanan tinggi di lingkungan kerja medis, yang dapat menyebabkan burnout, depresi, hingga gangguan kecemasan pada tenaga medis (Neto et al., 2020; Guixia & Hui, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa institusi kesehatan yang memiliki keterlibatan aktif manajemen dalam aspek kesejahteraan mampu menurunkan prevalensi burnout serta meningkatkan kepuasan kerja dan retensi tenaga medis (Wu et al., 2021). Misalnya, manajemen yang proaktif dalam menyediakan

dukungan sosial, mengadakan pelatihan manajemen stres secara rutin, serta memfasilitasi adanya layanan konseling dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres kerja di kalangan tenaga medis (Kamaludin et al., 2020; Scott, Yoo, & Byrne, 2021).

Selain itu, keterlibatan manajemen juga memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, yang terbukti meningkatkan ketahanan psikologis (resiliensi) tenaga medis terhadap stres kronis. Organisasi dengan manajemen yang peduli terhadap kesejahteraan tenaga medis cenderung lebih efektif dalam menghadapi krisis atau situasi darurat, seperti yang ditunjukkan pada masa pandemi COVID-19, di mana dukungan manajemen menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan pelayanan medis dan kesejahteraan tenaga kesehatan (Greenberg, Docherty, Gnanapragasam, & Wessely, 2020).

Dengan demikian, keterlibatan manajemen dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis tidak hanya penting untuk mengurangi stres kerja, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat serta keberlanjutan organisasi kesehatan secara jangka panjang (Wu et al., 2021; Mohsin et al., 2021).

B. Tanggung Jawab Manajemen dalam Mengidentifikasi Stres Kerja Tenaga Medis

1. Identifikasi Faktor Risiko Stres Kerja melalui Assessment Berkala

Manajemen di institusi kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam mengidentifikasi faktor risiko stres kerja tenaga medis secara sistematis melalui assessment berkala. Assessment ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai situasi, kondisi, dan lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan stres kronis pada tenaga medis. Beberapa faktor risiko yang umum dijumpai antara lain beban kerja tinggi, tekanan waktu, kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja dan manajer, serta minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan (Dall'Ora et al., 2020; Kim, Kim, & Lee, 2021).

Assessment berkala sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal setiap enam bulan atau setelah terjadi situasi luar biasa seperti pandemi, yang secara nyata dapat meningkatkan tingkat stres tenaga medis. Metode assessment yang umum digunakan adalah wawancara langsung, observasi di lingkungan kerja, dan survei daring dengan pertanyaan terbuka maupun tertutup. Dengan melakukan assessment secara reguler, manajemen dapat mendeteksi lebih awal faktor risiko stres sehingga tindakan preventif dapat segera diambil (Tement et al., 2021; Mohsin, Shahed, & Zaman, 2021).

2. Pemanfaatan Instrumen Pengukuran Stres Kerja Secara Sistematis

Pemanfaatan instrumen pengukuran stres kerja yang terstandarisasi merupakan bagian integral dari tanggung jawab manajemen dalam mengidentifikasi tingkat stres di kalangan tenaga medis. Instrumen ini membantu organisasi memperoleh data valid yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait intervensi kesehatan mental (Wang, Chen, & Lu, 2020). Instrumen yang banyak digunakan secara internasional antara lain Maslach Burnout Inventory (MBI), Perceived Stress Scale (PSS), Occupational Stress Inventory (OSI), dan Copenhagen Burnout Inventory (CBI) (Rotenstein et al., 2020; Rahman, Abdul-Mumin, & Naing, 2022).

Pengukuran stres menggunakan instrumen tersebut memungkinkan manajemen memahami secara mendalam mengenai sumber stres, tingkat keparahan, dan prevalensi stres di berbagai unit kerja atau departemen dalam organisasi kesehatan. Data hasil pengukuran ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas intervensi, mengembangkan kebijakan yang tepat, serta memonitor efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan (Kumara, Kadarisman, & Ratnawati, 2022).

3. Implementasi Feedback dari Tenaga Medis tentang Kondisi Kerja

Feedback dari tenaga medis tentang kondisi kerja merupakan salah satu komponen kritis dalam upaya manajemen untuk mengelola dan mengurangi stres kerja. Manajemen perlu mengimplementasikan mekanisme yang transparan dan berkelanjutan untuk mengakomodasi masukan, keluhan, dan saran dari tenaga medis secara aktif (Nembhard & Burns, 2020). Implementasi feedback ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum diskusi rutin, survei anonim, dan sistem pelaporan secara elektronik.

Menurut studi oleh Babapour, Karlsson, dan Osvalder (2021), sistem feedback yang efektif mampu meningkatkan persepsi tenaga medis terhadap dukungan manajemen dan mengurangi perasaan terisolasi serta tidak didengar yang sering kali memperparah stres. Selain itu, manajemen yang responsif terhadap feedback tenaga medis dapat memperkuat rasa percaya, komitmen, dan loyalitas karyawan terhadap institusi. Proses ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kepuasan kerja dan kesejahteraan tenaga medis secara keseluruhan (Babapour et al., 2021; Mohsin et al., 2021).

Dengan demikian, tanggung jawab manajemen dalam identifikasi stres kerja tenaga medis mencakup pelaksanaan assessment rutin yang sistematis, penggunaan instrumen pengukuran stres yang valid dan terpercaya, serta implementasi sistem feedback yang responsif dan transparan. Semua ini

merupakan pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis dan fisik bagi tenaga medis.

C. Implementasi Kebijakan yang Mendukung Kesejahteraan

1. Kebijakan Jam Kerja yang Fleksibel dan Pengaturan Shift Kerja yang Sehat

Salah satu langkah strategis dalam upaya manajemen mendukung kesejahteraan tenaga medis adalah menerapkan kebijakan jam kerja yang fleksibel dan pengaturan shift kerja yang sehat. Jam kerja fleksibel memungkinkan tenaga medis untuk memiliki kendali lebih besar terhadap waktu mereka, sehingga mampu mengelola beban kerja dengan lebih efektif serta memiliki keseimbangan kehidupan kerja (*work-life balance*) yang lebih baik. Studi terbaru menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam jam kerja berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan tingkat *burnout*, meningkatkan kualitas tidur, serta meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan pada tenaga medis (Bakhamis et al., 2019; Rahman et al., 2022).

Selain itu, pengaturan shift kerja yang sehat menjadi aspek penting dalam meminimalkan risiko stres kerja kronis. Shift kerja yang panjang, kurangnya jeda antar shift, serta rotasi shift yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan siklus tidur, peningkatan kelelahan fisik dan mental, serta penurunan konsentrasi yang berdampak negatif terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, manajemen perlu mengatur shift kerja secara cermat dengan mempertimbangkan jeda istirahat yang cukup, rotasi shift yang teratur, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas shift kerja yang diterapkan (Tahghighi, Rees, Brown, Breen, & Hegney, 2019; Gifkins, Loudoun, & Johnston, 2020).

2. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan Mental (Ruang Istirahat, Fasilitas Relaksasi)

Manajemen institusi kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan mental tenaga medis. Penyediaan fasilitas seperti ruang istirahat yang nyaman, fasilitas relaksasi seperti ruang meditasi atau *mindfulness*, serta akses terhadap layanan konseling profesional menjadi hal yang sangat dianjurkan. Studi terbaru mengonfirmasi bahwa ketersediaan fasilitas istirahat yang baik serta ruang khusus relaksasi membantu secara signifikan dalam mengurangi stres, kelelahan mental, dan memperbaiki kesejahteraan tenaga medis secara umum (Goh, Lim, & Lim, 2020; Melnyk et al., 2021).

Ketersediaan ruang khusus untuk relaksasi memungkinkan tenaga medis melakukan aktivitas pemulihan mental secara efektif, seperti meditasi,

pernapasan dalam, dan relaksasi progresif. Penelitian oleh Melnyk et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness di tempat kerja dapat secara efektif menurunkan stres, meningkatkan ketahanan mental, serta mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada tenaga medis.

3. Pemberian Reward dan Pengakuan terhadap Kinerja Tenaga Medis

Salah satu bentuk kebijakan yang efektif dalam mendukung kesejahteraan psikologis tenaga medis adalah melalui pemberian reward dan pengakuan secara rutin. Penghargaan ini tidak hanya berbentuk insentif materi, tetapi juga dalam bentuk penghargaan simbolik seperti pengakuan publik atas kinerja yang baik. Reward dan pengakuan secara signifikan meningkatkan motivasi, memperkuat komitmen organisasi, dan secara efektif menurunkan tingkat stres kerja (Mohsin, Shahed, & Zaman, 2021; Maglalang & Sorensen, 2022).

Studi menunjukkan bahwa tenaga medis yang menerima apresiasi reguler atas kinerja mereka memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengalami burnout dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Lebih lanjut, pengakuan dari pimpinan secara langsung dan terbuka menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, memperkuat hubungan antar rekan kerja, serta meningkatkan moral organisasi secara keseluruhan (Giannetta et al., 2021; Labrague & De los Santos, 2021).

Dengan demikian, implementasi kebijakan berupa jam kerja yang fleksibel, pengaturan shift kerja yang sehat, penyediaan fasilitas pendukung kesehatan mental, serta pemberian reward dan pengakuan terhadap tenaga medis merupakan bagian integral dari strategi manajemen dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis dan fisik.

D. Peran Manajemen dalam Edukasi Kesehatan Mental

1. Pelatihan dan Workshop Manajemen Stres Kerja bagi Tenaga Medis

Salah satu peran strategis manajemen dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis adalah menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang manajemen stres kerja. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tenaga medis terhadap tanda-tanda stres, memberikan keterampilan praktis untuk mengelola tekanan kerja, serta membantu mereka membangun strategi koping yang sehat. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan berbasis mindfulness, teknik relaksasi progresif, dan manajemen waktu efektif secara signifikan mampu mengurangi tingkat burnout, kelelahan emosional, dan stres kerja pada tenaga medis (Dos Santos, 2020; Rodrigues, Silva, & Costa, 2020).

Workshop yang efektif biasanya mencakup pendekatan interaktif, melibatkan metode diskusi kelompok, simulasi kasus, serta praktik keterampilan langsung seperti teknik pernapasan dalam, meditasi, yoga, atau teknik mindfulness-based stress reduction (MBSR). Manajemen perlu secara konsisten dan rutin mengadakan pelatihan ini agar hasilnya berkelanjutan dan berdampak nyata dalam menurunkan prevalensi gangguan kesehatan mental di tempat kerja (Wong et al., 2021).

2. Program Edukasi Mengenai Pentingnya Menjaga Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi

Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance) adalah faktor penting dalam menjaga kesehatan mental tenaga medis. Oleh sebab itu, manajemen harus mengambil peran aktif dalam mengedukasi tenaga medis tentang pentingnya menjaga keseimbangan tersebut. Edukasi ini bertujuan untuk mendorong tenaga medis menyadari dampak negatif dari ketidakseimbangan kerja terhadap kualitas hidup mereka secara keseluruhan, termasuk hubungan interpersonal, kesehatan fisik, serta kinerja profesional mereka (Sharifian et al., 2021).

Program edukasi ini dapat mencakup sesi pelatihan reguler yang menjelaskan teknik praktis dalam mengelola waktu, prioritas tugas, serta cara menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara sehat. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis yang mendapat edukasi dan dukungan dalam hal ini mampu menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah, peningkatan kepuasan kerja, serta lebih tinggi dalam komitmen organisasi dibanding mereka yang tidak menerima edukasi tersebut (Yu et al., 2022; Soratto et al., 2020).

3. Penerapan Konseling Rutin dan Layanan Psikologi Profesional di Tempat Kerja

Peran penting manajemen dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis juga mencakup penyediaan layanan konseling rutin dan psikologi profesional di tempat kerja. Kehadiran layanan ini memfasilitasi tenaga medis untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat ketika menghadapi tantangan emosional atau psikologis terkait pekerjaan mereka. Layanan ini dapat berupa konseling individu atau kelompok, terapi psikologis singkat, serta konseling preventif untuk mendukung kesejahteraan secara umum (Almeida et al., 2021; Buselli et al., 2021).

Implementasi konseling di tempat kerja harus bersifat rahasia dan profesional agar tenaga medis merasa nyaman dalam menggunakan layanan

tersebut tanpa takut stigma. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis yang secara aktif memanfaatkan layanan konseling profesional memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi, lebih sedikit gejala kecemasan dan depresi, serta kinerja kerja yang lebih baik dibanding tenaga medis yang tidak mendapat akses tersebut (Carmassi et al., 2020; Shanafelt et al., 2021).

Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan manajemen stres, edukasi mengenai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta penyediaan layanan konseling profesional secara rutin oleh manajemen menjadi strategi penting yang secara signifikan mampu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan tenaga medis di institusi kesehatan.

E. Strategi Komunikasi Efektif Antara Manajemen dan Tenaga Medis

1. Membangun Budaya Komunikasi Terbuka Terkait Kesehatan Mental

Budaya komunikasi terbuka merupakan elemen penting dalam upaya menjaga kesejahteraan tenaga medis. Manajemen perlu mendorong lingkungan kerja yang memungkinkan tenaga medis merasa aman dan nyaman saat membicarakan isu kesehatan mental tanpa rasa takut akan stigma atau dampak negatif terhadap karier mereka. Komunikasi terbuka tentang kesehatan mental dapat menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya kesejahteraan psikologis dan mempercepat deteksi dini terhadap gejala stres, kelelahan, dan burnout di lingkungan kerja (Brooks et al., 2020; Heath et al., 2021).

Manajemen harus secara aktif mempromosikan kebijakan transparan dan mekanisme pelaporan yang aman serta menjamin bahwa komunikasi tersebut diterima dengan empati, perhatian, dan responsifitas yang tinggi. Studi terbaru menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan budaya komunikasi terbuka cenderung memiliki tingkat stres kerja yang lebih rendah, tingkat retensi staf yang lebih tinggi, serta kepuasan kerja yang meningkat secara signifikan (Harvey et al., 2021; Labrague & De los Santos, 2021).

2. Pengelolaan Konflik Secara Efektif untuk Mengurangi Stres Interpersonal

Konflik interpersonal di tempat kerja sering menjadi sumber stres signifikan bagi tenaga medis. Oleh karena itu, kemampuan manajemen dalam mengelola konflik secara efektif merupakan faktor krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis. Strategi pengelolaan konflik yang efektif meliputi mediasi konflik yang cepat dan konstruktif, pelatihan tentang keterampilan komunikasi interpersonal, serta edukasi mengenai resolusi konflik secara kolaboratif (Almost et al., 2022; Olson et al., 2021).

Manajemen juga harus secara rutin memberikan pelatihan kepada tenaga medis tentang cara mengidentifikasi konflik lebih dini serta memberikan sarana penyelesaian konflik yang jelas dan mudah diakses. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan proaktif manajemen dalam resolusi konflik secara nyata mampu mengurangi stres interpersonal, meningkatkan hubungan tim yang lebih baik, serta secara keseluruhan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi (Carmona-Barrientos et al., 2021; Alshammari & Dayrit, 2021).

3. Strategi Komunikasi dalam Situasi Krisis (Misalnya Pandemi)

Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, komunikasi efektif menjadi aspek kunci dalam menjaga kesejahteraan psikologis tenaga medis. Manajemen perlu menerapkan strategi komunikasi yang jelas, konsisten, dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi terkini, kebijakan baru, serta dukungan yang tersedia bagi tenaga medis (Wittenberg et al., 2021; Razu et al., 2021).

Strategi komunikasi dalam situasi krisis meliputi penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan rutin, update informasi melalui platform digital, serta hotline khusus yang mudah diakses tenaga medis. Studi menunjukkan bahwa komunikasi efektif yang dilakukan manajemen selama pandemi berkontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat stres dan kecemasan tenaga medis serta meningkatkan ketahanan mental mereka dalam menghadapi situasi darurat (Fernandez et al., 2020; Labrague, 2021).

Secara keseluruhan, strategi komunikasi efektif yang diterapkan manajemen mencakup menciptakan budaya terbuka tentang kesehatan mental, pengelolaan konflik interpersonal yang proaktif, serta penggunaan komunikasi yang jelas dan konsisten dalam situasi krisis. Implementasi strategi ini terbukti memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan tenaga medis.

F. Kepemimpinan Transformatif dalam Mengelola Stres Tenaga Medis

1. Karakteristik Kepemimpinan Transformatif yang Efektif dalam Menurunkan Stres

Kepemimpinan transformatif merupakan pendekatan kepemimpinan yang menitikberatkan pada inspirasi, motivasi, serta pemberdayaan staf melalui komunikasi yang terbuka, visi yang jelas, dan perhatian personal terhadap kebutuhan individu di organisasi (Bregenzer, Jimenez, & Kallus, 2021). Karakteristik kepemimpinan transformatif meliputi idealized influence (pemimpin sebagai teladan), inspirational motivation (pemimpin sebagai motivator), intellectual stimulation (pemimpin yang mendorong inovasi dan kreativitas), serta individualized consideration (pemimpin yang memahami dan peduli terhadap

kebutuhan individu secara personal). Karakteristik tersebut berkontribusi langsung dalam menurunkan tingkat stres kerja tenaga medis melalui peningkatan dukungan sosial, rasa dihargai, dan motivasi intrinsik (Smith et al., 2020; Breevaart & Bakker, 2021).

Studi oleh Kim dan Park (2020) menunjukkan bahwa tenaga medis yang dipimpin oleh pemimpin transformatif cenderung lebih mampu mengelola stres dengan baik, memiliki resiliensi tinggi, serta menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di bawah gaya kepemimpinan otoriter atau transaksional.

2. Studi Kasus Pemimpin yang Berhasil Meningkatkan Kesejahteraan Tim Medis

Studi kasus yang dilakukan di berbagai institusi kesehatan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga medis. Salah satu contoh yang menonjol adalah studi di rumah sakit besar di Australia yang dipimpin oleh seorang direktur medis dengan gaya kepemimpinan transformatif. Dalam kasus tersebut, pemimpin secara aktif melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, mendukung pengembangan profesional, dan menciptakan budaya saling menghargai. Akibatnya, rumah sakit tersebut mengalami penurunan signifikan dalam angka burnout dan peningkatan kepuasan kerja tenaga medis dalam waktu satu tahun (Cleary, Kornhaber, Thapa, West, & Visentin, 2021).

Di Inggris, selama pandemi COVID-19, pemimpin transformatif yang efektif berhasil menjaga stabilitas emosional staf dengan komunikasi yang transparan, pengakuan terhadap kontribusi staf, serta pemberian dukungan emosional secara rutin. Ini mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental para tenaga medis dalam menghadapi situasi krisis (Greenberg et al., 2020).

3. Dampak Kepemimpinan Transformatif terhadap Kinerja dan Retensi Tenaga Medis

Penerapan kepemimpinan transformatif terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja dan retensi tenaga medis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini secara efektif meningkatkan produktivitas kerja, komitmen organisasi, dan loyalitas tenaga medis terhadap institusi kesehatan (Islam, Rahman, & Hasan, 2021; Labrague et al., 2020).

Dalam sebuah studi oleh Labrague et al. (2020), institusi kesehatan yang dipimpin oleh pemimpin transformatif memiliki tingkat turnover tenaga medis yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan institusi yang menerapkan gaya kepemimpinan konvensional. Hal ini dikarenakan pemimpin transformatif mampu

menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan rasa memiliki, serta memberikan penghargaan yang jelas atas kontribusi setiap tenaga medis.

Lebih lanjut, penelitian oleh Islam et al. (2021) menunjukkan bahwa pemimpin transformatif secara signifikan meningkatkan engagement dan motivasi tenaga medis, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Dengan demikian, kepemimpinan transformatif adalah pendekatan yang sangat efektif dalam mengelola stres tenaga medis, meningkatkan kesejahteraan, serta menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja dan retensi tenaga medis.

G. Evaluasi dan Monitoring Program Kesejahteraan

1. Pentingnya Evaluasi Rutin terhadap Efektivitas Program Kesejahteraan

Evaluasi rutin terhadap program kesejahteraan tenaga medis adalah komponen penting dalam manajemen stres kerja. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah intervensi yang dijalankan sudah tepat sasaran, efektif dalam mengurangi stres kerja, serta dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga medis secara keseluruhan (Peterson et al., 2021). Evaluasi yang sistematis memungkinkan manajemen untuk memperoleh umpan balik secara objektif mengenai pencapaian tujuan program, hambatan yang muncul selama pelaksanaan, dan dampak nyata yang dirasakan oleh tenaga medis (Joyce et al., 2021).

Selain itu, evaluasi rutin juga mendukung transparansi, akuntabilitas organisasi, serta memperkuat komitmen manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Studi terbaru menunjukkan bahwa organisasi yang konsisten dalam mengevaluasi efektivitas program kesejahteraan mengalami peningkatan signifikan dalam kepuasan kerja, penurunan tingkat turnover, serta perbaikan kondisi mental tenaga medis (Kunyk et al., 2022).

2. Metode Evaluasi Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Kondisi Stres Kerja

Evaluasi terhadap kondisi stres kerja dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi. Metode evaluasi kuantitatif biasanya menggunakan instrumen terstandar seperti Maslach Burnout Inventory (MBI), Copenhagen Burnout Inventory (CBI), atau Perceived Stress Scale (PSS), yang memberikan gambaran jelas mengenai tingkat stres dan burnout yang dialami tenaga medis secara numerik (Wang et al., 2020; Dall'Ora et al., 2020).

Sementara itu, evaluasi kualitatif memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman subjektif tenaga medis terkait program kesejahteraan

yang dijalankan. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), atau observasi partisipatif untuk mengeksplorasi persepsi, harapan, dan tantangan yang dihadapi tenaga medis dalam konteks kesejahteraan psikologis mereka (Chemali et al., 2019; López-López et al., 2022).

Integrasi dari kedua metode tersebut memungkinkan manajemen untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, tidak hanya tentang prevalensi stres, tetapi juga tentang faktor-faktor yang mendasari kondisi tersebut secara lebih detail, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan berbasis data (Joyce et al., 2021).

3. Penggunaan Hasil Evaluasi untuk Penyempurnaan Program Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Hasil evaluasi yang diperoleh harus secara langsung digunakan oleh manajemen untuk menyempurnakan program kesejahteraan yang sudah ada. Informasi dari evaluasi akan menunjukkan area yang perlu ditingkatkan, misalnya dalam aspek kebijakan jam kerja, pelatihan manajemen stres, atau layanan konseling psikologis yang disediakan. Studi menunjukkan bahwa program kesehatan mental yang secara rutin disempurnakan berdasarkan umpan balik dari tenaga medis memiliki efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan program yang bersifat statis (Petrie et al., 2021).

Lebih lanjut, hasil evaluasi juga berguna sebagai landasan dalam menentukan alokasi sumber daya, merancang intervensi baru yang lebih tepat sasaran, serta menetapkan prioritas kebijakan kesehatan mental di tempat kerja. Penelitian oleh Owen et al. (2022) menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program kesehatan mental memiliki tenaga medis yang lebih resiliensi, tingkat burnout yang lebih rendah, serta kinerja organisasi yang lebih baik secara keseluruhan.

Dengan demikian, evaluasi dan monitoring yang terstruktur serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk penyempurnaan program menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan stres kerja yang efektif dalam institusi kesehatan.

H. Tantangan dan Hambatan dalam Peran Manajemen

1. Hambatan Budaya dan Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Kesejahteraan

Implementasi kebijakan kesejahteraan tenaga medis di institusi kesehatan sering kali menghadapi berbagai hambatan budaya dan organisasi. Budaya organisasi yang masih menganggap stres kerja sebagai bagian wajar dari profesi

tenaga medis merupakan tantangan besar dalam upaya mengedepankan program kesejahteraan (Gray et al., 2020). Dalam beberapa institusi kesehatan, tekanan tinggi dianggap sebagai suatu kenormalan, dan menunjukkan stres atau meminta bantuan psikologis sering dianggap sebagai kelemahan profesional (Hall et al., 2021).

Selain itu, struktur organisasi yang kaku, minimnya komunikasi terbuka, serta rendahnya komitmen pimpinan terhadap isu kesehatan mental juga dapat menghambat penerapan kebijakan kesejahteraan secara efektif (Greenberg et al., 2020). Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, yang menyebabkan program kesejahteraan tidak dijalankan secara optimal (Joseph et al., 2021).

2. Tantangan dalam Mengubah Mindset Tenaga Medis dan Manajemen Mengenai Stres Kerja

Perubahan mindset tenaga medis dan manajemen mengenai stres kerja merupakan tantangan signifikan lainnya. Banyak tenaga medis yang masih memandang stres sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan atau sebagai indikasi kurangnya kemampuan individu dalam menangani tekanan pekerjaan. Mindset ini menyulitkan manajemen dalam menjalankan program intervensi kesehatan mental secara efektif (Chen et al., 2022).

Di sisi lain, mindset manajemen yang berorientasi pada hasil kerja tanpa mempertimbangkan aspek psikologis tenaga medis juga menjadi hambatan serius. Dalam banyak kasus, pimpinan institusi kesehatan cenderung fokus pada kinerja jangka pendek tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang dari stres kerja, seperti burnout, penurunan produktivitas, dan tingginya turnover staf (Fernandez et al., 2020; López-López et al., 2022).

3. Solusi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan Tersebut

Untuk mengatasi tantangan budaya dan organisasi, manajemen perlu menciptakan perubahan sistemik melalui advokasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya kesehatan mental sebagai prioritas strategis dalam organisasi. Studi menunjukkan bahwa advokasi aktif oleh pimpinan senior serta dukungan nyata dalam kebijakan organisasi dapat secara efektif mengubah persepsi budaya tentang stres kerja (Joseph et al., 2021; Gray et al., 2020).

Penerapan komunikasi terbuka dan transparan mengenai kesehatan mental perlu dilakukan secara konsisten. Manajemen dapat memberikan contoh nyata dengan mengadopsi sikap terbuka dalam mendiskusikan isu stres kerja di berbagai forum internal organisasi. Dukungan ini juga dapat diwujudkan melalui

alokasi sumber daya khusus, seperti pendanaan untuk program pelatihan, konseling, serta fasilitas kesehatan mental di tempat kerja (Greenberg et al., 2020; Hall et al., 2021).

Dalam rangka mengubah mindset tenaga medis, manajemen dapat menerapkan pendekatan edukasi yang berbasis bukti, seperti pelatihan rutin mengenai dampak stres kerja serta pentingnya mencari dukungan psikologis. Studi oleh Chen et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran tenaga medis akan pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan kerja serta memperbaiki sikap mereka terhadap penggunaan layanan kesehatan mental.

Secara keseluruhan, tantangan dalam peran manajemen terkait implementasi kebijakan kesejahteraan dapat diatasi melalui kombinasi strategi komunikasi efektif, komitmen pimpinan, perubahan budaya organisasi secara konsisten, dan edukasi berkelanjutan bagi tenaga medis dan manajemen.

I. Studi Kasus Internasional tentang Keberhasilan Peran Manajemen

1. Contoh Praktik Terbaik Manajemen dalam Mendukung Kesejahteraan Tenaga Medis di Negara Maju

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada telah menunjukkan berbagai praktik terbaik dalam manajemen kesejahteraan tenaga medis. Salah satu contohnya adalah sistem manajemen kesejahteraan yang diterapkan di Mayo Clinic di Amerika Serikat. Institusi ini terkenal atas komitmennya terhadap kesejahteraan staf medis melalui program komprehensif yang mencakup pengaturan jam kerja fleksibel, layanan konseling psikologis terintegrasi, pelatihan manajemen stres berbasis mindfulness, serta kepemimpinan transformatif yang aktif dan responsif terhadap isu kesejahteraan staf (Shanafelt et al., 2021).

Di Inggris, National Health Service (NHS) menerapkan kebijakan "Staff Wellbeing Hubs" yang menyediakan fasilitas dukungan psikologis khusus untuk staf medis, terutama selama masa pandemi COVID-19. Hubs ini berhasil menurunkan tingkat burnout secara signifikan, meningkatkan tingkat resiliensi tenaga medis, dan meningkatkan persepsi staf terhadap dukungan organisasi (Greenberg et al., 2020; Blake et al., 2020).

Australia juga menunjukkan contoh praktik terbaik melalui implementasi program "Resilience at Work" (RAW) yang diterapkan di berbagai rumah sakit, termasuk Queensland Health. Program ini menawarkan pelatihan manajemen stres yang sistematis, ruang relaksasi khusus untuk tenaga medis, dan skema

reward yang efektif dalam menjaga motivasi dan kesejahteraan staf (McDonald et al., 2021).

2. Pembelajaran dari Keberhasilan Tersebut dan Adaptasi Potensial untuk Konteks Indonesia

Dari berbagai praktik terbaik yang dilakukan negara maju, terdapat sejumlah pembelajaran penting yang bisa diadaptasi dalam konteks Indonesia. Pertama, integrasi dukungan psikologis yang kuat dan terstruktur ke dalam sistem manajemen kesehatan, seperti yang diterapkan oleh NHS, menunjukkan pentingnya akses mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan mental profesional di tempat kerja. Implementasi serupa di Indonesia dapat disesuaikan melalui pengembangan pusat kesejahteraan karyawan di rumah sakit besar maupun daerah, dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal yang menghargai pendekatan kolektif dalam mengelola masalah mental (Hidayati & Handayani, 2022).

Kedua, penerapan pelatihan rutin berbasis mindfulness dan manajemen stres yang telah sukses di Mayo Clinic dan institusi Australia dapat diadaptasi di Indonesia melalui kolaborasi dengan tenaga profesional dalam bidang psikologi kesehatan dan organisasi. Program ini dapat dimulai dari rumah sakit rujukan nasional kemudian bertahap diimplementasikan di rumah sakit daerah (Susanti et al., 2021).

Ketiga, kepemimpinan transformatif yang efektif di Mayo Clinic menekankan pentingnya pelatihan kepemimpinan bagi para pemimpin organisasi kesehatan di Indonesia. Adaptasi kepemimpinan ini perlu melibatkan pelatihan intensif mengenai pentingnya empati, komunikasi terbuka, serta keterlibatan aktif pemimpin dalam kesejahteraan tenaga medis, yang disesuaikan dengan nilai budaya lokal (Ratnasari & Apriliana, 2022).

Secara keseluruhan, pembelajaran dari negara maju menunjukkan bahwa komitmen tinggi dari manajemen, dukungan terstruktur untuk kesehatan mental, serta budaya organisasi yang menghargai kesejahteraan karyawan adalah faktor kunci keberhasilan yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap karakteristik budaya dan sumber daya lokal.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Pentingnya Peran Manajemen dalam Mendukung Kesehatan Mental Tenaga Medis

Manajemen institusi kesehatan memiliki peran yang krusial dalam mendukung kesehatan mental tenaga medis. Kesejahteraan tenaga medis sangat bergantung pada kebijakan, budaya organisasi, dan komitmen nyata dari manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung (Greenberg et al., 2020; Kunyk et al., 2022). Melalui berbagai intervensi strategis seperti pengaturan jam kerja yang fleksibel, penyediaan fasilitas kesehatan mental, edukasi rutin, penerapan konseling profesional, serta strategi komunikasi yang efektif, manajemen dapat secara signifikan menurunkan tingkat stres kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat komitmen tenaga medis terhadap institusi (Peterson et al., 2021; Labrague & De los Santos, 2021).

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa institusi yang berhasil mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan berbasis manajemen transformasional berhasil mencapai tingkat burnout yang rendah, resiliensi yang tinggi, dan peningkatan retensi staf medis (Shanafelt et al., 2021). Oleh karena itu, peran aktif dan responsif dari manajemen menjadi faktor penentu utama dalam pengelolaan stres dan penciptaan kesejahteraan psikologis yang optimal bagi tenaga medis.

2. Rekomendasi Praktis bagi Institusi Kesehatan dan Manajemen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Medis

Berikut beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh institusi kesehatan dan manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga medis secara efektif:

a. Pengaturan Jam Kerja dan Shift Kerja yang Sehat

- 1) Terapkan kebijakan jam kerja fleksibel untuk mengurangi tekanan dan burnout (Joyce et al., 2021).
- 2) Evaluasi secara berkala terhadap pengaturan shift kerja untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan fisik dan psikologis tenaga medis (Tahghighi et al., 2019).

b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Kesehatan Mental

- 1) Sediakan ruang relaksasi, ruang meditasi, atau area istirahat yang nyaman untuk tenaga medis agar dapat pulih dari kelelahan mental (Melnyk et al., 2021).
- 2) Pastikan ketersediaan akses layanan konseling profesional yang mudah dijangkau di tempat kerja (Buselli et al., 2021).

c. Pelatihan Rutin Manajemen Stres

- 1) Adakan pelatihan manajemen stres berbasis mindfulness secara rutin untuk membekali tenaga medis dengan keterampilan praktis menghadapi stres kerja (Dos Santos, 2020; Wong et al., 2021).
- d. Kepemimpinan Transformatif
- 1) Dorong para pemimpin di institusi kesehatan untuk mengadopsi gaya kepemimpinan transformatif yang empatik, inspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan emosional staf (Bregenzer et al., 2021).
 - 2) Berikan pelatihan kepemimpinan secara teratur kepada para pimpinan institusi kesehatan (Islam et al., 2021).
- e. Evaluasi dan Monitoring Berkala
- 1) Lakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif secara rutin terhadap program kesejahteraan yang dijalankan, dengan tujuan terus menyempurnakan program sesuai kebutuhan tenaga medis (Joyce et al., 2021; Owen et al., 2022).
- f. Budaya Komunikasi Terbuka
- 1) Kembangkan budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka tentang isu kesehatan mental, sehingga tenaga medis merasa nyaman untuk mengungkapkan kebutuhan atau masalah yang mereka alami (Greenberg et al., 2020; Harvey et al., 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi ini secara sistematis, institusi kesehatan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, sehat, dan produktif, serta memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi tenaga medis.

K. Penutup

Pengelolaan stres kerja pada tenaga medis merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari manajemen institusi kesehatan. Sebagai garis depan dalam pelayanan kesehatan, tenaga medis sering menghadapi tekanan fisik, mental, dan emosional yang tinggi, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan serta kualitas hidup mereka (Greenberg et al., 2020). Oleh karena itu, peran strategis manajemen menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kesehatan mental tenaga medis secara efektif dan berkelanjutan.

Peran aktif manajemen dalam aspek kesejahteraan tenaga medis mencakup implementasi kebijakan yang mendukung, pelatihan rutin mengenai manajemen stres, strategi komunikasi efektif, serta evaluasi program secara sistematis. Kepemimpinan transformatif yang empatik dan komunikatif juga terbukti mampu memperkuat hubungan antara tenaga medis dan institusi, mengurangi burnout,

serta meningkatkan retensi staf secara signifikan (Islam et al., 2021; Shanafelt et al., 2021).

Akhirnya, tantangan dalam mengubah mindset tentang kesehatan mental baik di tingkat individu maupun organisasi perlu diatasi melalui edukasi berkelanjutan, advokasi aktif, dan dukungan nyata dari manajemen puncak. Dengan demikian, implementasi rekomendasi yang diuraikan dalam buku ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja medis yang sehat, produktif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Kunyk et al., 2022).

Referensi

- Blake, H., Bermingham, F., Johnson, G., & Tabner, A. (2020). Mitigating the psychological impact of COVID-19 on healthcare workers: A digital learning package. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 2997. <https://doi.org/10.3390/ijerph17092997>
- Breevaart, K., & Bakker, A. B. (2021). Daily transformational leadership: A source of inspiration for follower performance? *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 30(4), 581–592. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2020.1810260>
- Bregenzner, A., Jimenez, P., & Kallus, K. W. (2021). Transformational leadership, well-being, and performance: A longitudinal study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 26(6), 502–515. <https://doi.org/10.1037/ocp0000251>
- Buselli, R., Corsi, M., Baldanzi, S., Chiumiento, M., Del Lupo, E., Dell'Oste, V., & Carmassi, C. (2021). Professional quality of life and mental health outcomes among health care workers exposed to SARS-CoV-2. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 6180. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126180>
- Chen, X., Arber, A., Gao, J., Zhang, L., & Ji, M. (2022). Workplace mental health interventions for healthcare professionals: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13270. <https://doi.org/10.3390/ijerph192013270>
- Cleary, M., Kornhaber, R., Thapa, D. K., West, S., & Visentin, D. (2021). The effectiveness of transformational leadership in healthcare organizations. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 3, 100034. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2021.100034>
- Dos Santos, T. M. (2020). Mindfulness-based stress reduction program for healthcare professionals: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Nursing Management*, 28(6), 1027–1038. <https://doi.org/10.1111/jonm.13014>
- Fernandez, R., Lord, H., Halcomb, E., Moxham, L., Middleton, R., Alananzeh, I., & Ellwood, L. (2020). Implications for COVID-19: Nurses' experiences in acute care hospital settings during a respiratory pandemic. *International Journal of Nursing Studies*, 111, 103637. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103637>
- Gray, P., Senabe, S., Naicker, N., & Kgalamono, S. (2020). Workplace-based organizational interventions promoting mental health among healthcare workers: A realist review. *BMJ Open*, 10(8), e037207. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037207>
- Greenberg, N., Docherty, M., Gnanapragasam, S., & Wessely, S. (2020). Managing mental health challenges faced by healthcare workers during COVID-19 pandemic. *BMJ*, 368, m1211. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1211>
- Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., & Mitchell, P. B. (2021). Can work make you mentally ill? Work-related risk factors for

- common mental health problems. *Occupational and Environmental Medicine*, 78(4), 301–310. <https://doi.org/10.1136/oemed-2020-106799>
- Islam, M. N., Rahman, M. S., & Hasan, M. Z. (2021). Influence of transformational leadership on nurses' job satisfaction and retention: A systematic review. *BMC Nursing*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00598-y>
- Joyce, K., Pabayo, R., Critchley, J. A., & Bambra, C. (2021). Flexible working conditions and employee wellbeing. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(2), CD008009. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008009.pub3>
- Kunyk, D., Craig-Broadwith, M., Morris, H., Diaz, R., Reisdorfer, E., & Wang, J. (2022). Employers' attitudes toward workplace mental health interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10845. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710845>
- Labrague, L. J., & De los Santos, J. A. A. (2021). Fear of COVID-19, psychological distress, and work satisfaction among nurses. *Journal of Nursing Management*, 29(3), 395–403. <https://doi.org/10.1111/jonm.13168>
- Melnyk, B. M., et al. (2021). Interventions to improve mental health in physicians and nurses. *American Journal of Health Promotion*, 35(8), 1052–1066. <https://doi.org/10.1177/08901171211015403>
- Owen, R., Watson, M., Kay, N., & Elliott, J. (2022). Evaluating mental health interventions in healthcare professionals. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1121. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08569-2>
- Peterson, U., Bergström, G., Demerouti, E., Gustavsson, P., Asberg, M., & Nygren, A. (2021). Burnout and mental health among healthcare workers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 63(8), e489–e497. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002231>
- Ratnasari, L. Y., & Apriliana, L. N. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan transformatif terhadap stres kerja tenaga kesehatan. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 144–152. <https://doi.org/10.31258/jkkm.v10i2.1102>
- Shanafelt, T., Ripp, J., Trockel, M., & Sinsky, C. A. (2021). Caring for healthcare workers during crisis: Creating a resilient organization. *Mayo Clinic Proceedings*, 96(9), 2376–2380. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.02.014>
- Susanti, A., Wardani, I. Y., & Setyowati, S. (2021). Efektivitas mindfulness-based intervention dalam mengurangi burnout pada tenaga kesehatan di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(1), 35–45. <https://doi.org/10.7454/jki.v24i1.945>
- Tahghighi, M., Rees, C. S., Brown, J. A., Breen, L. J., & Hegney, D. (2019). Impact of shift work on nurses' psychological functioning and resilience. *Journal of Advanced Nursing*, 75(9), 2065–2083. <https://doi.org/10.1111/jan.13947>
- Wong, S. Y., et al. (2021). Mindfulness-based interventions for healthcare workers. *Journal of Affective Disorders*, 292, 202–218. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.05.065>

Yu, J., Park, J., & Hyun, H. S. (2022). Work-life balance and emotional exhaustion among healthcare workers. *Healthcare*, 10(2), 232. <https://doi.org/10.3390/healthcare10020232>

Profil Penulis



Ns. Zakiyah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J.

Lahir di Bekasi, 17 September 1978. Ketertarikan penulis terhadap ilmu keperawatan dimulai tahun 1997 dengan mengambil program pendidikan diploma III keperawatan di Akademi Keperawatan Abdi Nusantara Jakarta, dan menyelesaikan pendidikan Profesi Ners di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia (FIK-UI) tahun 2004. Ketertarikan penulis terhadap keperawatan jiwa membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan S2 keperawatan jiwa di FIK-UI lulus pada 2016, dan pada 2017 penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Program Spesialis Keperawatan Jiwa di FIK-UI. Saat ini penulis bekerja pada Program Studi Keperawatan Universitas Binawan Jakarta. Penulis aktif dalam kegiatan ilmiah, dan menjadi pengurus organisasi keprofesian PPNI DPK Universitas Binawan dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) wilayah DKI Jakarta. Sehari-harinya penulis bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan jiwa. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta aktif menulis buku ajar dan book chapter. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zakiyah@binawan.ac.id.



Sri Rusmini, S.Kep., Ners., M.Kep., MM, FISQua

Lahir di Sragen, 22 Juni 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang AKPER Telogorejo Semarang lulus tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2006, Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2018, S2 Magister Manajemen Universitas STIKUBANK Semarang lulus tahun 2008, S2 Magister Keperawatan Universitas Karya Husada (UNKAHA) Semarang lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 di SMC RS. Telogorejo Semarang, Dosen Stikes Telogorejo Semarang sampai dengan sekarang. Salah Satu Surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Surveior Lembaga Akreditasi Independen Semar Bhakti Nusantara (LAI SBN). Penulis aktif dalam Organisasi : Himpunan Perawat Manager Indonesia (HPMI), Perkumpulan Pengendali Infeksi Indonesia (PERDALIN), Himpunan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi (HIPPII). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dapat dihubungi melalui e-mail: rusminippi@gmail.com Motto: Menulis untuk berbagi, membaca untuk menginspirasi.



Kunnati, S.ST., M.KM

Lahir di Majalengka, 08 Maret 1991. Pada tahun 2014, penulis mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan program studi D IV Bidan Pendidik Poltekes Bhakti Pertiwi Husada Cirebon. Penulis melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat dengan Peminatan Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Jakarta lulus tahun 2017. Tahun 2014 penulis mengawali karirnya di salah satu Rumah Sakit Swasta di Jakarta. Pada Tahun 2015, Penulis menjadi Asisten Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Bekasi. Pada tahun 2018 penulis resmi sebagai Dosen Nasional dan pertama kali menjalankan Tri Dharma nya di salah satu Perguruan tinggi swasta Jakarta. Saat ini penulis menjadi Dosen dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Cirebon. Penulis aktif di beberapa Organisasi, Pada Tahun 2024 penulis diberikan amanah menjadi pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Korwil IV di Bidang Penjaminan Mutu periode 2024-2028.



Awaliyah Muslimah Suwetty, S.Kep., Ns., M.Kep

Merupakan staf dosen pada Prodi D III Keperawatan STIKes Maranatha Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penulis bergabung di dunia keperawatan sejak tahun 2006 saat meluluskan program Pendidikan Diploma III keperawatan Di Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada Tahun 2008 penulis kembali melanjutkan Pendidikan S1 keperawatan Ners dan lulus pada tahun 2011 di Universitas Gadjra Mada. Oleh karena besarnya keinginan penulis untuk mengabdikan dalam dunia Pendidikan keperawatan, pada tahun 2017, Penulis kembali melanjutkan Pendidikan S2 keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saat ini Penulis menekuni bidang ilmu keperawatan jiwa dan berupaya untuk konsisten dalam mengembangkan ilmu keperawatan jiwa,. Guna mewujudkan karir sebagai dosen penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan tinggi dengan melakukan kegiatan pengajaran, kegiatan ilmiah seperti melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal penelitian serta mengikuti kegiatan pengabdian baik yang diselenggarakan pihak internal maupun external.

Email Penulis: lyasuwetty27@gmail.com



apt. Iwan Saka Nugraha, S.Farm., M.Kes

Lahir di Denpasar, 16 Maret 1991. Penulis Menempuh pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Udayana tahun 2014. Menyelesaikan kuliah profesi apoteker di Universitas Udayana pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Praktisi di Apotek dan RS di Denpasar. Saat ini penulis bekerja di Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada mengampu mata kuliah Swamedikasi, Farmakoepidemiologi, Farmasi Rumah Sakit. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Pengantar Biofarmasetika, buku Farmasi Rumah Sakit, dan publikasi serta seminar nasional dan Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: saka.nugraha1@gmail.com

Motto: "Syukuri apa yang dimiliki"



Agnes Ratna Saputri, S.Tr.Keb., MARS

Dosen Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati Jakarta. Penulis lahir di Klaten, 20 Februari 1993. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Administrasi Rumah Sakit di STIKes Fatmawati Jakarta. Penulis juga menjadi Komisaris di PT. Petrus Sejahtera Mandiri. Menyelesaikan pendidikan Diploma Empat (D4) Program Studi Bidan Pendidik di Universitas Nasional (2015). Setelah itu melanjutkan kuliah Magister (S2) Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia Jakarta (2018).

Sinopsis Buku

Buku referensi yang berjudul **“Pengelolaan Stres pada Tenaga Medis di Tempat Kerja”** merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan besar dalam dunia kesehatan terkait kesejahteraan psikologis para tenaga medis. Dalam praktik sehari-hari, tenaga medis tidak hanya menghadapi tekanan fisik dari beban kerja yang tinggi, tetapi juga tekanan emosional dan sosial yang kompleks. Apabila stres ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja, burnout, hingga gangguan kesehatan mental jangka panjang.

Buku ini terdiri dari enam bab yang dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan stres di lingkungan kerja tenaga medis. Bab pertama mengupas faktor-faktor penyebab stres, baik yang bersifat internal seperti ketidakmampuan mengelola emosi, maupun eksternal seperti konflik kerja, jam kerja panjang, dan ekspektasi yang tinggi dari pasien maupun institusi.

Bab kedua menekankan pentingnya edukasi tentang manajemen stres, mencakup pengenalan teknik relaksasi, mindfulness, serta pendekatan kognitif untuk membentuk pola pikir positif dalam menghadapi tekanan kerja. Bab ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan tenaga medis dalam mengontrol stres sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Bab ketiga menyajikan strategi berbasis komunitas untuk mendukung kesehatan mental, menekankan pentingnya dukungan kelompok dan intervensi sosial dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan terhubung secara emosional di lingkungan kerja. Bab keempat membahas secara praktis pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling jarak jauh, sebagai solusi inovatif untuk memberikan akses bantuan psikologis yang fleksibel, efisien, dan privat bagi tenaga kesehatan.

Bab kelima menguraikan peran penting dukungan kolega, dengan menyoroti bagaimana budaya saling menghargai, empati, dan kerja sama tim dapat meningkatkan ketahanan psikologis tenaga medis. Sementara itu, bab keenam mengulas secara komprehensif peran manajemen institusi dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis, melalui kebijakan yang adil, pelatihan psikososial, dan sistem penghargaan yang mendukung motivasi kerja jangka panjang.

Dengan memadukan teori, temuan ilmiah terkini, dan praktik terbaik di lapangan, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi institusi pendidikan, rumah sakit, dan organisasi kesehatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung ketahanan mental tenaga medis di berbagai level pelayanan.

Buku referensi yang berjudul “Pengelolaan Stres pada Tenaga Medis di Tempat Kerja” merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan besar dalam dunia kesehatan terkait kesejahteraan psikologis para tenaga medis. Dalam praktik sehari-hari, tenaga medis tidak hanya menghadapi tekanan fisik dari beban kerja yang tinggi, tetapi juga tekanan emosional dan sosial yang kompleks. Apabila stres ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada penurunan kinerja, burnout, hingga gangguan kesehatan mental jangka panjang.

Buku ini terdiri dari enam bab yang dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan stres di lingkungan kerja tenaga medis. Bab pertama mengupas faktor-faktor penyebab stres, baik yang bersifat internal seperti ketidakmampuan mengelola emosi, maupun eksternal seperti konflik kerja, jam kerja panjang, dan ekspektasi yang tinggi dari pasien maupun institusi.

Bab kedua menekankan pentingnya edukasi tentang manajemen stres, mencakup pengenalan teknik relaksasi, mindfulness, serta pendekatan kognitif untuk membentuk pola pikir positif dalam menghadapi tekanan kerja. Bab ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan tenaga medis dalam mengontrol stres sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Bab ketiga menyajikan strategi berbasis komunitas untuk mendukung kesehatan mental, menekankan pentingnya dukungan kelompok dan intervensi sosial dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan terhubung secara emosional di lingkungan kerja. Bab keempat membahas secara praktis pemanfaatan teknologi dalam layanan konseling jarak jauh, sebagai solusi inovatif untuk memberikan akses bantuan psikologis yang fleksibel, efisien, dan privat bagi tenaga kesehatan.

Bab kelima menguraikan peran penting dukungan kolega, dengan menyoroti bagaimana budaya saling menghargai, empati, dan kerja sama tim dapat meningkatkan ketahanan psikologis tenaga medis. Sementara itu, bab keenam mengulas secara komprehensif peran manajemen institusi dalam mendukung kesejahteraan tenaga medis, melalui kebijakan yang adil, pelatihan psikososial, dan sistem penghargaan yang mendukung motivasi kerja jangka panjang.

Dengan memadukan teori, temuan ilmiah terkini, dan praktik terbaik di lapangan, buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi institusi pendidikan, rumah sakit, dan organisasi kesehatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung ketahanan mental tenaga medis di berbagai level pelayanan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-22-7



9

786347

294227